

中国传统医学网

www.ccwtm.com

本网站资源为网友提供或网络搜集，仅用于学习和研究使用，不能用于商业目的。如果您认为影响了您的版权，请和管理员联系！我们会在三个工作日内给予处理！

本站提供的任何书籍资料，均为网友提供，若无意中侵犯到您的版权利益，敬请来信联系我们，我们会在收到信息三天内给予处理！

本站为非营利性站点，所有资源均是私下交流学习之用，任何涉及商业盈利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！

本站仅提供一个观摩学习的环境，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后24小时内删除。如果您觉得满意，请购买正版！

本站严厉谴责和鄙夷一切利用本站资源进行牟利的盗版行为！

以辯證唯物主義為
指導經典著作為依
據結合實際為豐富
中醫理論作貢獻

為伯祥同志《脈法求真》題

崔月犁

一九九七年五月



原國家衛生部部長 中華醫學會會長
中藥學會會長崔月犁為本書親筆題詞

内 容 简 介

本书以《内经》为源，以阴阳为纲，深入浅出地阐述了脉学原理和诊脉方法。指出了自《难经》以来脉学理论中的误区，并加以纠正，同时指明了正确的诊脉方法。

全书分上、中、下三篇。上篇主要论述了脉学原理及寸关尺三部诊法，并从“全息论”角度出发，论证了寸口诊脉分三关候五脏的科学道理，从而肯定了中医诊脉的科学性。中篇论述了28脉产生的机理、主病及区别要点，并阐述了诊脉中出现的多种情况及其在临床上的意义。下篇主要论述了四时五脏脉法及其在临床上的具体运用，并附以脉案加以说明。

作者经过数十年坚持不懈地探索研究，揭示了《内经》四时五脏脉法的内涵和意义，把四时五脏脉法与寸关尺三部诊法结合起来，揭开了蒙在脉诊学上神秘的面纱，解决了长期以来脉学理论难与临床实践相联系的难题，从而改变了自古以来在诊脉上流传的“只可意会，不可言传”的说不清的局面，为临床更加

科学地运用这一诊法奠定了基础。

学习本书不仅可使初学者少走弯路，而且对临床中医师也会有较大的帮助和提高。

本书在创作和出版中，得到原卫生部长崔月犁同志的鼓励和支持，崔月犁同志并为本书出版题了词。

自序

多年来余苦于辨脉不明，难于辨证施治，而留心于脉久矣！无时不想把脉学真正弄清，于是刻苦学习，努力实践，年近半百，终有所悟，未及动笔，身染重病，几乎丧命。大病之中深感生命有限，再不动笔会遗恨终生。病中仍坚持笔耕，十易其稿，历时3年有余，终于收笔，了却心愿以慰平生。

余深感为医责任之重大，医术不精，无异于谋财而害命，医术难精尤甚于脉，脉理不明，何以为人司命！前贤论脉本于《内》、《难》。然，对经文理解各自不同，仁者见仁，智者见智，虽不乏确当宏论，缪误亦复不少，鱼龙混杂真伪难辨。

余每临证，必验之以脉，其脉有应有不应，凡不应者，必求之理，其理有通有不通。脉，本为断病而设，当确实可信方为正理。然，前人论脉多有脱离实际，以理论理，故弄玄虚，尤其《太素脉法》登峰造极，竟以诊脉断命，辨生死富贵，其与巫何异！

脉之理本于阴阳，以阴阳为纲贯穿于脉，其理易明。缪误多起于后世，正误必求其源。余探本求源，广采博集，参诸家之言，验之临床，尽倾所学：辨脉理，识脉象，察五脏之分部，考求独之方法，正人迎、气口之误，倡四时五脏脉法……。不顾学识薄浅，奋起命笔，为畅脉理著成此书，抛砖引玉以为后人阶石。

《内经》为先哲经典之作，为后人明理论，立纲纪，因其年代久远文字深奥，其意难明。《内经》论脉颇多变化，脉随四季阴阳，人体气血盛衰，变化多端，不一而定。后世则不然，胶柱鼓瑟，刻板套路失其辨证精神。《内经》诊脉不仅有寸口诊脉法，遍身诊脉法（包括人迎、气口诊法），同时也论述了四时五脏脉法。经文论述多种诊法，后人不察，混为一谈。前贤论脉专著如汗牛充栋，对二十八脉、三部九候论述甚详，五脏之脉只言三部分位：“左寸心脉必浮大而散，右寸肺脉必浮短而涩，左关肝脉弦长而滑，右关脾脉缓和，左尺肾脉沉滑，右尺与心同断。”又言心肺俱浮，肝肾俱沉，脾胃居中，寸口脉必如是方为正常。如此论脉试问，何为正常脉象？何为病脉？何以又脉分四季？二十八脉又如何运用？正可谓：“心中易了，指下难明。”余每困惑于此，读遍脉书而未能解，诊脉何岂难也！

寸口之脉，虽有分三关，定五脏之论，然脉无定

候，随季而转，所谓四时五脏脉也。《内经》四时五脏脉法，非指寸、关、尺三部分五脏，而是统言寸口脉。五脏分别旺于五季，正如经言：“五脏不得自至于手太阴，必因于胃气乃至手太阴也，故五脏各以其时自为而至于手太阴也。”肝气旺于春，春之脉即肝之脉也；脾气旺于长夏，长夏之脉即脾之脉也；肺气旺于秋，秋之脉即肺之脉也；肾气旺于冬，冬之脉即肾之脉也。四时五脏脉象已定，脉有胃气，方为正常；脉少胃气、太过、不及本脏自病，虚实易明；出现它脏脉形，依其阴阳盛衰，按五行生克，主病则明。经曰：“微妙在脉，不可不察，察之有纪，从阴阳始，始之有经，从五行生，生之有度，四时为宜，补泄无失，与天地如一，得一之情，以知死生。”

刘伯祥

1997. 12. 于西安

凡 例

欲正脉理，必求其源。脉学源于《内经》。《内经》脉学为先民经验结晶，其朴实无华，接近实际，且具哲理，然因年代久远，文字深奥，欠条理又不完整。后世论脉虽有很大发展，但也夹有不妥之处。本书以《内经》脉学为源，参考《难经》、《伤寒论》以及后人有关论述，对脉学理论中一些重大问题，历来含混不清的地方加以讨论，以图对错误的东西加以纠正，使后学者不致再走弯路。特对书中出现的情况作以下说明：

一、书中凡引自《内经》之《平人氣象论》、《脉要精微论》、《玉机真脏论》等篇内容，均冠以“经曰”概之，不提篇名，其他引文标明出处以便查对。

二、本书对二十八脉，寸关尺主病，多从机理上加以阐述，较少采用某脉主某病，某部见某脉主某病的方式。因脉学本是活泼变化的，一脉主多病，一病有多种脉象，只要抓住阴阳这个纲，明白产生的机理，就一通百通。

三、文中遇有难懂的地方，为了不割断文意除以（ ）的形式直接随文解释外，对个别难解词语以【 】标出，文后加以注释，以便阅读。

四、作者意在寻求《内经》脉理，以正后学之误，非排斥后人一切复古，独遵《内经》。

五、对《内经》中有关运气学说的内容如：“五运之脉”、“六经独至”、“南北政”等，因其理论缺乏科学依据，尚待进一步研究，故不提及，只选取确切而实用的东西加以论述。

对历代脉书中不切实际，单纯以理论理的东西均不加论述。

六、下篇五脏脉法中对五季的划分，是以我国中部黄河中下游地区气候特征为准。由于南北气温寒暑差异较大，脉的表现亦有很大区别，不同的地区在脉与气候相应的原则下，根据当地的实际情况加以变通。

本人水平有限，难免有误，欢迎批评指正。

目 录

自 序

凡 例

上 篇 脉学的一般理论及诊脉方法

一、脉搏形成的机理	(1)
二、影响脉搏的因素	(2)
(一) 非疾病因素	(2)
(二) 疾病因素	(3)
三、诊脉时间	(5)
四、诊脉部位	(6)
五、论“寸口脉诊病分三关候五脏”的科学性 ...	(11)
六、人迎脉、气口脉正误	(17)
七、持脉方法	(19)
八、病位应从变中求	(21)
九、正常人脉象	(22)
十、真脏脉	(24)
十一、诊脉辨证	(26)

(一) “独”字求病位	(26)
(二) 阴阳求病性	(28)
(三) 比较求病势	(29)
十二、脉象反映病理变化	(31)
十三、寸口脉主病脉辨	(33)
(一) 外感病脉辨	(33)
(二) 五脏病脉辨	(34)
(三) 杂病脉辨	(34)
1. 虚劳病脉辨	(35)
2. 暑病脉辨	(37)
3. 虐病脉辨	(38)
4. 黄疸病脉辨	(39)
5. 失血病脉辨	(40)
6. 泻、痢病脉辨	(41)
7. 消渴病脉辨	(41)
8. 痹病脉辨	(42)
9. 胸痹病脉辨	(43)
10. 宿食病脉辨	(44)
11. 淋病脉辨	(44)
12. 寒疝病脉辨	(44)
13. 症瘕积聚病脉辨	(45)
14. 中风病脉辨	(46)
十四、寸关尺三部脉独见主病 (十种脉象主病表解)	
.....	(47)

上篇注释	(50)
------------	------

中 篇 二十八脉辨析及主病

一、对看法 (28 脉主病脉辨)	(54)
(一) 以脉在部位的深浅来分	(54)
1. 浮 脉	(55)
2. 沉 脉	(56)
3. 伏 脉	(57)
(二) 以脉来至数上分	(58)
4. 迟 脉	(58)
5. 数 脉	(59)
6. 缓 脉	(60)
7. 疾 脉	(60)
(三) 以脉来搏动有力无力来分	(61)
8. 虚 脉	(61)
9. 实 脉	(62)
10. 牢 脉	(63)
(四) 以脉来流利与否分	(64)
11. 滑 脉	(64)
12. 涩 脉	(65)
(五) 以脉体长短区分	(66)
13. 长 脉	(66)
14. 短 脉	(67)

15. 动 脉	(67)
(六) 以脉体宽度区分	(68)
16. 洪 脉	(69)
17. 细 脉	(69)
(七) 弦直脉, 从搏动力度和幅度上分	(70)
18. 弦 脉	(70)
19. 紧 脉	(71)
(八) 空虚脉分	(72)
20. 芤 脉	(73)
21. 革 脉	(74)
(九) 虚脉中以脉体宽度区分	(74)
22. 微 脉	(75)
23. 散 脉	(76)
(十) 细软脉从浮沉上分	(77)
24. 濡 脉	(77)
25. 弱 脉	(78)
(十一) 竭止脉以迟数分	(78)
26. 促 脉	(79)
27. 结 脉	(80)
28. 代 脉	(80)
二、类比法	(82)
三、单脉、复合脉、兼脉的意义	(84)
四、辨脉提纲	(85)
五、脉有常、变, 证有真、假, 法有取、舍	(87)

六、脉有初按、久按，浮取、沉取不同	(88)
七、脉逆从阴阳	(90)
八、以脉、色断病新久及预后	(91)
中篇注释	(93)

下 篇 四时五脏脉法及其应用

总 论	(96)
一、四时五脏常脉	(97)
(一) 四时五脏平脉	(98)
四时五脏平脉表解	(101)
(二) 四时五脏病脉	(104)
四时五脏病脉表解	(108)
二、四时五脏变脉	(110)
(一) 变脉有单、兼不同	(110)
(二) 变脉主病与发病早晚	(111)
五脏变脉主病表解	(117)
(三) 变脉主病分类及治法	(118)
当季脏腑变脉主病表解	(121)
三、四季脉解，阴阳盛衰论	(121)
四、六气变化对脉的影响	(125)
六经变脉表解	(127)
按语：六经脉解	(129)
五、四时五脏脉与寸关尺相结合	(130)

六、脉象与体质及用药的关系	(132)
下篇注释	(133)

附：《内经》遍身诊脉法

一、三部九候诊脉法	(137)
二、人迎、气口诊脉法	(150)
三、诊尺肤法	(155)
脉 案	(157)
一、五脏病脉案	(157)
二、杂病脉案	(174)
三、附录	(186)
(一) 文中方剂索引	(186)
(二) 主要参考书目	(194)

上 篇

脉学的一般理论及诊脉方法

一、脉搏形成的机理

脉搏是血液在心脏与动脉血管的共同作用下，血液在脉管里流动形成的。古人说，气为橐龠^[1]，血如波澜，血在气的鼓动下形成脉管搏动，它直接受人体阴阳盛衰，气血变化的影响。人是一个统一的整体，任何脏腑组织局部的变化，必然反映到整体，引起气血的变化，而气血的变化又必然反映在脉搏上。因此，掌握脉搏的变化，可以推测出疾病的发生与发展，为预防及治疗疾病保障人体健康，提供了可靠的依据。正所谓：整体包含着局部，局部反映了整体的信息。

二、影响脉搏的因素

人是生活在自然界中，自然界的阴阳盛衰，四季气候的变化，所处地理环境……等等，凡是影响人体气血盛衰，阴阳变化的因素，都对脉搏有一定的影响。除了自然界的影响外，男女差别，年龄不同，体态动静，情绪的变化等等都是影响脉搏变化的因素。疾病引起脉搏的变化，随着病情的性质，程度不同，部位有别，脉搏的变化有明显的差异。影响脉搏变化的因素归纳起来有二种：

（一）非疾病因素

1. 气候因素：四季阴阳盛衰

春：阳气上升阴气下降——脉弦

夏：阳盛阴虚——脉洪

长夏：暑热伤气，津液亏虚——脉软弱（缓）

秋：阴气上升阳气下降——脉毛（浮）

冬：阴盛阳衰——脉沉（石）

2. 体质因素：

肥人——气虚、肉厚——脉，沉、细

瘦人——气盛、肉薄——脉，浮、大

3. 年龄因素：

少、壮——气盛——脉，大、有力

老、弱——气衰——脉，小、弱

4. 性别因素：

男：阳气旺——脉，强、较大

女：阴气旺——脉，弱、较小

5. 居处因素：

南方——炎热——阳盛——脉，大、浮

北方——寒冷——阴盛——脉，小、沉

6. 情绪因素：

激动——属阳——脉，动、数

安静——属阴——脉，缓、弱

7. 动静因素：

动——为阳——脉，数

静——为阴——脉，缓

(二) 疾病因素

当人体健康时，身体内环境与自然界大环境之间，保持着一种自然的动态平衡，各种因素的影响都比较弱。正如经文所说，春胃微弦，夏胃微钩。所谓：“春胃、夏胃”即指春季、夏季有胃气的正常脉象。微弦的“微”表示季节对正常的脉象有一定的影响，不超过一个正常的范围，其他因素也是一样。疾病引起阴阳盛衰、气血紊乱、脏腑功能失调，反映在脉上，脉

搏的变化超过 正常范围，表现出太过——偏盛；不及——偏衰状态，这就是病脉。

疾病引起脉搏变化是有一定规律的，概言之：病邪有阴阳之分，阳邪致病使人阳盛而阴衰，表现在脉上“阴不胜其阳则脉流薄疾”。薄疾者：脉来急速增快。阴邪致病使人阴盛而阳衰“阳不胜其阴则五脏气争、九窍不通”，脉来迟、缓、细、微。（阴盛阳衰则五脏气虚，不足营运气血，故气争。九窍为五脏所主，脏气虚，九窍失运故不通）。《阴阳应象大论》曰：“善诊者，察色按脉，先辨阴阳，审清浊而知部分^[2]，视喘息听音声而知所苦，观权衡规矩^[3]而知病所主，按尺寸，观浮沉滑涩而知病所生，以治无过，以诊则不失矣。”归纳起来，疾病分：邪盛与正虚，邪盛之中，又可分为阳邪与阴邪；正虚分为：阳虚、阴虚、阴阳两虚。其引起脉搏的变化如下：

1. 邪盛：分阳邪、阴邪

- | | | |
|--------|---|------------------|
| (1) 阳邪 | { | (1) 风、火、暑、热直接伤人。 |
| | | (2) 寒、燥、湿邪入里化热。 |
| | | (3) 五志化火。 |
| | | (4) 过食辛辣厚味。 |
| | | (5) 脏腑功能失调内生火热证。 |

邪并于阳，使人阳盛。脉的表现：浮、数、洪滑

有力。

- (2) 阴邪 { (1) 寒湿之邪。
(2) 水湿内停、痰饮、瘀血、积聚等。
(3) 过食生冷寒凉。
(4) 误治导致的阳损阴盛。

邪并于阴，使人阴盛。脉的表现：沉、迟、紧、涩。

2. 虚邪：分阳虚、阴虚、阴阳两虚

- (1) 阳虚 { 禀赋不足 { 卫外不固
误 治 ———— 脏腑功能低下
久病虚弱 { 寒自内生

脉的表现：鼓动无力，沉、弱、短、微。

- (2) 阴虚 { 热病耗阴 ———— { 精亏血少，津液不足
失血、劳损 { 脏腑阴分亏耗。

脉的表现：虚、细、无力。

- (3) 阴阳两虚 { 禀赋不足 ———— { 阴损及阳
久病 { 阳损及阴

脉的表现：沉、细、微、弱。

三、诊脉时间

经曰：“诊法常以平旦^[4]，阴气未动，阳气未散，饮食未进，经脉未盛，络脉调匀，气血未乱，故乃可诊有过之脉。”引起脉搏变化的诸多因素中，有些是人为

的，暂时的，它们并不反映疾病本身的变化。这些因素是可以消除的，不排除它们的干扰，就难以掌握疾病变化的规律，古人诊脉在平旦就是这个道理。

今天诊脉已不可能都在平旦，但效法古人尽可能地排除外界干扰，还是诊脉中应注意的重要环节。如在大醉、大饱、大怒、运动之后等情况下，不可诊脉。诊脉之时，先让病人休息 15～20 分钟再为诊脉，就是排除干扰的有效方法。

四、诊脉部位

《内经》诊脉方法有多种，主要有遍身诊法，人迎、气口对比诊法，寸口诊脉法和诊尺肤法等。遍身诊法是根据经脉与脏腑的历属关系，及与其循行部位的所属关系，通过诊察各部动脉的变化，推测脏腑、组织器官及该经脉循行部位的病变。帝问曰：“何谓三部？”岐伯曰：“有下部，有中部，有上部，部各有三候，三候者有天、有地、有人也，必指而导之，乃以为真。”（遍身诊法详见后篇）由于此种诊法用于临床很不方便，又难于掌握，后世医家除了在病情危重，生死悠关的紧急时刻，判断预后时少数部位如：趺阳脉、太溪脉^[5]、人迎脉采用外已多不用。

另一种是寸口诊脉法，包括寸关尺三部诊脉法（内经时代是否有分三关，尚有争论。但，尺、寸脉对比诊病却是千真万确的。如：上盛则气高，下盛则气胀。推而上之，上而不下者腰足清也；推而下之，下而不上者头项痛也。促而上击者肩背痛也。上——指寸脉；下——指尺脉）和四时五脏脉法。寸口诊脉法是采用手太阴肺经太渊穴处的动脉诊病。由于寸口脉为肺经动脉，是全身动脉的交会之处，可反映全身脏腑经脉的变化，又易于观测。因此，为《内经》时代所重视，也很受后人欢迎。《内经》首先提出寸口诊脉法。《素问·五脏别论》曰：“气口何以独为五脏主？岐伯曰：胃者水谷之海，六腑之大源也。五味入口，藏于胃，以养五脏气。气口亦太阴也，是以五脏六腑之气味皆出于胃，变见于气口。”《素问·经脉别论》曰：“食气入胃浊气归心，淫精于脉，脉气流经，经气归于肺，肺朝百脉，……气口成寸，以决死生。”《内经》首先提出并且把寸口诊脉法摆在十分重要的位置上。但，此时它并不完善。《难经》在此基础上加以继承发扬，舍去了其他诊法，独取寸口，使复杂的诊脉法逐步简化趋向完善，成为祖国医学中独特的十分重要的诊病方法。

寸口诊脉部位与脏腑相配，《内经》有：“尺内两

傍则季肋也（两侧肋尽处为季肋），尺外（指尺脉前半部）以候肾，尺里（尺脉后半部，外——指端为外；里——肘端为里，余同此。）以候腹。中附上（关脉），左外以候肝（左关脉前半部），内以候膈（左关脉后半部）；右外以候胃（右关脉前半部），内以候脾（右关脉后半部）。上附上（寸部脉），右外以候肺（右寸前半部），内以候胸中（右寸脉后半部）；左外以候心（左寸脉前半部），内以候膻中（左寸脉后半部）。”其分部原则是：“左以候左，右以候右，前以候前，后以候后。”以脉分：寸为前，尺为后；以人体分：身体上部为前，下部为后。所谓候者——诊察之意。“上竟上者（寸部为上）胸、喉中事也；下竟下者（尺部为下），少腹、腰、股、膝、胫、足中事也。”按照这个原则，肺在胸中，故右寸外以候肺，内以候胸中；心在膻中，故左寸外以候心，内以候膻中；肝在膈上，故左外以候肝，内以候膈；胃在脾外、脾居胃里，故右关外以候胃，内以候脾；肾在腹中，故尺外以候肾，内以候腹。或有人要问，肝居于右何以候在左？肺居两侧何以诊在右？答曰：“脏腑分位应既从其形又从气机”人体气机升降，严然如一小天地。肝虽在右其气主升，左升右降乃天地不易之理，故其候在左。肺虽居两侧但其气主降，故其诊在右。经文只言五脏在寸、关、尺

的分部，六腑之中只提到胃而不谈及其他腑脏者，盖突出胃的重要。五脏禀气于先天而靠后天水谷精气的充养，胃为水谷之源，脾为胃运化水谷以养五脏之气，其重要可知，故单列出，其他腑统于脏。肾主二阴，大肠、小肠属后阴，膀胱属前阴。左尺主左肾及小肠、膀胱；右尺主右肾、大肠；胆统于肝。三焦不统于脏而按其部位上、中、下分属于寸、关、尺。膻中、膈、腹经文均以左侧主之，按《内经》分部原则应以左候左，以右候右，当两侧分主之。故，膻中，胸中者，皆为上焦，左、右寸分主之；膈者属中焦，左、右关分主之；腹中属下焦，左、右尺分主之。五脏以经脉与肢体、耳、目、口、鼻相连属，不言其他，亦寓其中。经文只谈尺主肾而未分左、右，后人以两肾分主阴阳，以左肾为阴，右肾为阳。左尺主左肾为肾水，右尺主右肾为肾火（命门），可作为参考。寸口脉诊病，分三关，候五脏是否是科学的，其道理见下节。

寸口脉诊病分三关定五脏部位表解：

寸口脉	左手脉	右手脉
寸脉	心 上焦（左侧）	肺 上焦（右侧）

(续上页表)

寸口脉	左手脉	右手脉
关脉	肝 胆（中焦左侧）	胃 脾（中焦右侧）
尺脉	左肾 小肠 膀胱（下焦左侧）	右肾 大肠（下焦右侧）

《难经》与王叔和《脉经》，均以六腑配五脏，心与小肠在左寸，肺与大肠在右寸，三焦配命门在右尺。我以为不妥，肺虽与大肠相表里，然肺在上而大肠在下，把应属尺脉的大肠腑脏硬归到寸脉，此与经旨前以候前，后以候后的原则相违背。临证中每见燥屎与邪热结于大肠，以及下痢、脏毒、肠风便血等疾病多见尺脉的变化也证实了这一点。《内经》把寸关尺三部，每部又一分为二，分候脏、腑的作法，理论上虽有此一说，临床却未必有意义。三部脉本来就很短，一指之间何能再分为二，脏与腑何能分清？实践中也从未见过在一部脉中出现两个不同的脉象。如何区分是腑病还是脏病呢？《难经·九难》曰：“何以别知脏腑之病耶？抑将在脉也？然，数者腑也，迟者脏也；数则

为热，迟则为寒；诸阳为热，诸阴为寒，故以别知脏腑之病也。”仲景曰：“寸口脉浮为在表，沉为在里，数为在腑，迟为在脏，假令脉迟，此为在脏。”话虽如此，然而脏病不仅有寒证，亦有热证，腑病不仅有热证亦有寒证，不可不知，必四诊合参，脉证互印方可不失。

五、论“寸口脉诊病分三关候五脏” 的科学性

寸口脉诊病，分三关候五脏源于《内经·脉要精微论》：“尺内两旁则季肋也，尺外以候肾，尺里以候腹。中附上，左外以候肝，内以候膈；右外以候胃，内以候脾。上附上，右外以候肺，内以候胸中；左外以候心，内以候膻中。”它的分部原则是：“上竟上者（寸脉为上）胸、喉中事也；下竟下者（尺脉为下）少腹、腰、股、膝、胫、足中事也。”从《内经》以后的二千多年来，除在大肠、小肠、三焦、命门的分部位置上有争议外，基本上是遵循了这一分部原则的。（也有持反对意见的人，如日人丹波元简与明代张三锡等人反对三关分部的诊法，主张以浮中沉分别候五脏）。

近些年来，有人用一些现代的科学方法，试图证实寸口脉诊病分三关候五脏的科学道理，都失败了。因此，就怀疑它的科学性，认为它是不科学的，没有道理，更有甚者，据此来否定中医学，把祖国医学诬为“伪科学”。《中医脉诊学》说的非常明白。他说：“实践证明脉象在临床上具有非常重要的诊断辨证意义，过去许多医学家采取解剖学、生理学、生物学等一些观点和方法，去探索脉学的深奥意义和它的规律性，都未能获得完满的、更合理的解释。如果运用信息论的方法论的方法，对脉学进行研究，可能会揭示出其中的规律和深在的含义，亦可能扫清认为诊脉不可理解的玄妙色彩，而显露出其科学的本来面目。”

由于当今世界上科学技术的飞速发展，人们对世界的认识有了很大的进步，看问题亦不再是狭隘的和孤立的了。有许多道理古人说不清楚而我们今天已经能用科学加以证实。寸口诊脉既然是几千年来盛传不衰，成为中医学中十分重要的诊病手段，从古到今反复验证确有一定的反映。那么，它必然有一定的科学道理，决不能说它是凭空想象“子虚乌有”。它的道理究竟在那里呢？说穿了就是局部包涵着整体的信息。从信息论的观点出发，通过观察局部脉搏的变化而测知整体气血、阴阳的动态变化，“全息论”^[6]就是最有力的

证明。我们都知道，磁铁有南北极，把一块磁铁分成两半仍然有南北极，把它再分成无数个小块，在每块上也仍然有南北极。打碎的激光全息象片分成若干碎片，每一个小部分都可再现出原来象片的全景。再如宇宙的结构是由无数个星系组成的，每个星系又是由无数个围绕中心旋转的恒星和围绕恒星旋转的行星组成的。星球又是由物质组成的。原子是组成物质的最小微粒。大到太阳系的结构可以反映出宇宙的结构，小到原子的结构可以反映出太阳系和宇宙的结构，可以说原子的结构就是太阳系和宇宙的缩影。局部反映了整体的信息，这是自然界中普遍存在着的规律。我们的祖先很早就注意到这一自然规律，并把它运用到实践中。《内经》对面部的分部望诊，以及后来发展起来的望舌等都是这样。不仅在人的医疗活动中是如此，就是看牛、相马也是一样。有人主要相皮毛，有人主要看口齿，有人观体态，……等等。这些都是通过对局部的观察来判断马的好坏。寸口脉诊病也是这个道理。因此，它也是科学的。

寸口脉诊病分三关候五脏是否有科学道理呢？这一点同样要用“全息论”^[6]的观点来回答。局部反映整体信息，在这方面已经证实毋庸置疑。世界进入20世纪以来，一些医家不断的发现了许多局部针灸的新疗

法，在局部施行针灸治疗全身的疾病。如：50 年代发现的耳针疗法，70 年代陕西蓝田医生发现的头皮针（山西稷山县头皮针按解剖投影定位除外），前后又不断发现了背针、鼻针、眼针、舌针、唇针、手针、足针、膝针、腕踝针……等等。尤其是 80 年代初期，我国学者张颖清先生在针灸治病时发现的第二掌骨侧全息穴位群这一新系统。之后，又在许多人身上进行测试，从而得出“人体任何一个节肢的穴位，如果以其对应的整体上的部位来命名的话，则每一个肢节都恰象整个人体的部位在这里的一个索影。”我国学者王存臻、严春友在此基础上创立了“宇宙全息统一论”^[7]。它指出：整体上各部分在“全息元”^[8]上的分布规律与各对应部位，在整体上或其他“全息元”上的分布规律相同。换句话说，身体上每个相对独立的部分都是一个全身的索影，都可反映出全身的信息，身体各部分在这个索影上的穴位分布都是按相同的规律排列的，都有固定的位置。寸口脉作为全身动脉中的一个独立的部分，它与周围组织在结构组成和功能上有相对独立的边界和相对独立的部分。因此它也是一个“全息元”也必遵循这一规律。“穴系全息相关律”指出：在人体中的各“全息元”中，各穴分布都遵循同一比例，如从头顶至足这一模式，将人体从头到足连线分成三

份，脏器官排列，依次分布为：头顶穴、头面穴、咽喉穴、上肢穴、肺穴、心穴、肝穴、胆穴、脾穴、肾穴、膀胱穴、子宫穴、生殖器穴、肛穴、足穴。这与《内经》肢体和脏腑在寸口脉的分布，“上竟上者（寸脉为上）胸、喉中事也；下竟下者（尺脉为下）少腹、腰、股、膝、胫、足中事也。”及心肺在上居寸脉，肝脾在中居关脉，两肾在下居尺脉是何等的相似。由此可见寸口脉分三关候五脏并非是无稽之谈，它是科学的，有理论依据的。

这里需要特别指出的是《内经》寸口脉分三关候五脏中五脏的概念，并非是现代医学所指解剖学上的五脏概念。两者之间虽有一定的联系，却是两个不容混淆的概念。这正是为什么肝居右而脉诊却在左关，肺在两侧，脉诊却在右寸的道理所在。祖国医学所指的脏腑是一个生理、病理学的概念。以脾为例，中医学中，脾的主要功能为主运化，它包括了现代医学所指的整个消化系统“胃、肠、十二指肠、胰、肝、脾（肝、脾为部分功能）胆等。它不能与西医的脾脏等同。因此，绝不能用解剖学上脾脏概念来代替中医学中脾脏的概念，也就不能简单的用“全息律”中，脏器官的位置硬套了。要弄清五脏在寸口脉的位置，首先必须弄清五脏的主要生理功能和它们在三焦中所起的主

要作用。由于心肺同处于上焦，心肺的共同作用使水谷精微和气血得以敷布全身，“上焦如雾露之溉”即是指此而言。因此，寸口脉诊病，寸脉为上，在脏主心、肺。两脏之中，心属火，主温煦，火性炎上；肺主气，司呼吸，肺气以降为顺。左升右降，乃天地不易之理。故，左寸为心脉，右寸为肺脉。脾、胃、肝、胆同居于中，脾主运化，肝主疏泄两脏共同完成了人体对食物的消化吸收，“中焦如沕”正是对此功能的形象描述。由于肝主升发，胃主和降，脾与胃为表里，故肝虽在右而脉诊却在左关，脾胃居左而脉诊在右关。五脏之中两肾居下，其与大肠、小肠、膀胱等共同完成二便的分泌与排泄，“下焦如渚”正是对这种功能的描述。因此，两肾及大、小肠、膀胱等为尺脉所主。大、小肠中小肠与心为表里，属火，居于左尺脉，大肠与肺为表里居右尺脉。从以上分析可以看出，脏腑所处的三焦位置及其主要生理功能是决定它们在寸口脉分布的重要依据。根据“全息律”信息分布规律及中医脏象学说的理论，作为判断寸口脉分三关候五脏的依据，来判明是非，千百年来有关六腑、三焦的划分，大、小肠是在尺脉还是寸脉的匡世之争，也就可以就此罢休，划上一个完整的句号了。

寸口脉分三关候五脏的理论源于《内经·脉要精

微论》，该段文字所指的是寸口脉还是尺肤，历来有两种不同的见解。以杨上善、王冰、丹波元简等人为代表的医家认为：《内经》中未明确提出寸口脉分三关，也没有寸脉、关脉、尺脉的名称。因此，此处所指当为诊尺肤的内容。而《难经》、《脉经》和后世医家张景岳、马蒔等人把它直接作为寸口脉分三关的依据，后人论脉多遵之。由于此事关系重大引起后世争论不休。现在从“全息论”的角度上看，无论当初《内经》所指是诊尺肤，还是诊寸口脉，作为两个不同的“全息元”来说，他们所反映的都是同一个整体的信息，而信息分布规律又都是相同的。因此，这个模式不但适用于尺肤，同样也适用于寸口脉，把它看成是寸口脉诊病分三关候五脏的依据也是正确的，没有必要再争论下去。

六、人迎脉、气口脉正误

人迎脉与气口脉，《内经》以手太阴肺经太渊穴处的动脉为气口，又名寸口脉；结喉两旁足阳明胃经之动脉为人迎脉。以人迎脉主外感，气口脉主内伤。《灵枢·四时气篇》曰：“气口候阴（里），人迎候阳（外）”《灵枢·禁服篇》曰：“寸口主中，人迎主外”。

人迎为胃经之动脉，胃为阳之腑脏，故主乎外；寸口为肺经之动脉，肺为脏属阴，故主乎里。《灵枢·五色篇》曰：“人迎盛坚者伤于寒，气口盛坚者伤于食。”王叔和《脉经》引《脉法赞》文将左寸脉为人迎，右寸脉为气口。他说：“关前一分人命主之，左为人迎，右为气口。”关前一分，当指寸部，即左手寸部脉为人迎，右手寸部脉为气口。后世不察，继承了《内经》人迎脉、气口脉的主病，套用了《脉经》的部位。自《千金方》之后，众多医家宗之，均以左寸脉为人迎，主外感；右寸脉为气口主内伤，就连东垣，时珍等名家悉遵之。东垣《内外伤辨·辨脉》曰：“古人以脉上辨内外伤于人迎、气口。人迎脉大于气口为外伤，气口脉大于人迎为内伤……。外感风寒皆有余之证，是从前客邪来也，其病必见于左手，左手主表……。内伤饮食及饮食不节，劳役过度皆不足之病也，必见于右手，右手主里……。故外感寒邪，则独左寸人迎脉浮紧，按之洪大。内伤饮食则右寸气口脉大于人迎一倍……二倍……三倍。”时珍《濒湖脉学·四言诀》亦说，左为人迎，右为气口。诸贤在人迎，气口脉上辨内伤、外感可谓用心良苦。然而，以鹿为马，南辕北辙，本欲使人辨明者，反使人误入歧途，后学者不可再误。

七、持脉方法

经曰：“持脉有道，虚静为保。”诊脉之时，为医者首先要安静心志，调匀呼息，排除杂念，专心一致地体会指下的感觉。以自己的呼吸作标准，每呼吸一次，病人脉跳4~5次为正常，超过5次为数脉，不足4次为损脉——迟脉。诊脉至少要脉动50次以上，如未察明可适当延长，不可苍促草率。象仲景在《伤寒论·自序》中，批评的那样，握手不及足，动数发息不满50，相对斯须^[9]便处汤药，就是草菅人命了。寸关尺三部每部都有浮中沉三候，三三得九，所谓三部九候。经言：“知内者按而纪之^[10]，知外者终而始之^[11]”。根据《内经》外（脉浮为在外），主外（主表证）；内（脉沉为在内）主内（主里证）；上（寸部脉为上），主上（身体上部疾病），下（尺部脉为下），主下（身体下部疾病）的原则，诊察内部病变要在脉的沉部察看，即“按而纪之”了解外感病变要在脉的浮部察看，所谓“终而始之”诊脉时要以医生与病人相对（可侧对）而坐，以医生的右手诊病人之左脉，医生的左手诊病人的右脉。（侧对时可以医生右手分别诊病人两手脉）掌后高骨定位，高骨相对的部位为关脉，关前为

寸脉，关后为尺脉。身长者脉长，适当放开指距，身短者脉短，适当缩小指距。手指由轻到重，再由重到轻，反复比较，脉在何部表现明显而定浮中沉，先统查，后分部。《内经》曰：“推而内之（推：推寻，侦察之意。）内而不外者，心腹有积也”，脉沉而不浮主病在里，故心腹有积。“推而内之，外而不内，身有热也。”脉在浮部而不在沉部，主病在表，表证必恶寒发热。“推而上之，上而不下者，腰足清也。”寸部搏动正常，尺部脉明显不足，其病在下，为肾阳虚下元不足，故腰足冷而不温。“推而下之，下而不上者，头项痛也。”尺部脉搏动正常，而寸脉明显不足，为气血虚，清阳之气不能行于上，故头项痛。“按之至骨脉气少者，腰背痛也，身有痹也。”按之至骨脉气少，为脉见沉伏细弱，为肾阳虚衰，血运不畅，故腰背痛；血脉痹阻身有痛疾。这里的“推”字，作推寻讲，即侦察之意，并非是推拉的意思。后人多生歧义，如高士宗《素问直解》^[12]，李梴《医学入门》^[13]等人以推拉意来解，另造出了一种上下左右推的指法，流传甚广使人诊脉无所适从，似有画蛇添足之嫌。

寸口脉的部位有极少数人由于生理异常，动脉部位有别，不可不知。太渊无脉反在高骨之上，斜向虎口为斜飞脉（有人以此为反关）。寸口无脉，反见之手

背腕中为反关，此不为怪。

八、病位应从辨中求

以脉诊病虽有上主上，下主下，以左候左，以右候右的法则。但，不可墨守成规，死搬教条。同样是头部疾患，按上主上的原则，异常脉象就必定要反映在寸部脉上吗？其实不然。要知道，相同的症状，可能会有多种不同的病因造成，产生这一症状的机理可能完全不同，表现在脉上其形态和部位会有很大的差异。以头痛为例，引起头痛的病因不仅有外感，也有内伤；有虚证亦有实证。肝阳头痛，异常脉象多不在寸脉，而在左关肝脉上，或左手脉（有时也可能表现在两手六脉）上，其脉弦而有力。胃火头痛，异常脉象也不在寸脉而在右关脉，或右手脉（有时也可能表现在两手六脉）上，其脉洪数有力。肾虚、虚火上冲头痛，异常脉象也不在寸，反见两尺脉虚大而数。由全身疾病引起的头痛，异常脉象也多不在寸脉而表现在整个六脉的变化上。如：风寒引起的头痛，六脉浮紧；湿热引起的头痛，六脉濡细；痰浊引起的头痛，六脉沉滑；血虚引起的头痛，六脉细弱。就是同一种疾病引起脉象的变化，其部位也有不同。《难经·五十五

难》曰：人病有沉滞，有积聚，可切脉而知之耶？然，诊病在右肋有积气，当得肺脉结（右寸脉独见沉伏），脉结甚则积甚，结微则积微。诊不得肺脉（右寸脉未见沉伏）而右肋有积气者何也？然，肺脉虽不见，右手脉当沉伏也。”正是这样的例证。只有局部的气血失调，阴阳失衡引起的病变，在尚未影响到整体时，异常脉象才表现在寸、关、尺局部脉的变化上。象风热在上引起的头面肿痛，上实下虚引起的头痛、眩晕……等等。当病变只对局部造成损害，引起局部脏腑，组织阴阳失衡，气血逆乱时，其脉多反映在局部。当病变影响到整体，引起整体阴阳变化，气血失调时，可能引起整个脉象的变化。

求病位是辩证的，灵活而变化的，刻舟求剑，死背公式的作法是不可取的。只有以阴阳为本，以辨证为法，才能正确掌握和理解求病位的方法。

九、正常人脉象

经曰：“人一吸脉再动（两次为再），一呼脉再动，呼吸定息脉5动，闰以太息^[14]，命曰平人。平人者不病也。常以不病人调病人，医不病，故为病人平息以调之为法。”除一息脉动4~5次以外，正常人的脉象

是有胃气、神气与根的。所谓有胃气，即指脉来均匀和缓，有柔和之象。经言：脉弱以滑是有胃气即是此意。经文曰：“人以水谷为本，故人绝水谷则死，脉无胃气亦死。所谓无胃气者，但得真脏脉，不得胃气也。所谓脉不得胃气者，非^[15]肝不弦，肾不石也。”不得胃气并非指肝脉不弦，肾脉不沉石，而是指脉无柔和之象，即肝脉弦象太过，肾脉沉石太过。又曰：“五脏皆禀气于胃，胃者五脏之本也，脏气者不能自至于手太阴，必因于胃气乃至于手太阴也。”是说五脏之气在胃气的作用下，才能达到寸口脉。因此，寸口脉除反映五脏的盛衰外，还要反映胃气的盛衰。脉有无胃气除反映五脏的盛衰外，还要反映脾胃功能的盛衰。脉之有神，指脉搏力量不大不小，速度不快不慢。所谓脉有根，其指有二：一指沉为有根，脉在沉部，轻取无脉，重按有脉，谓之有根；二指尺脉为根，寸、关虽无脉，只要尺脉不绝即为有根。按五脏来分，尺部主肾，沉部亦主肾。只要肾脉不绝乃为有根，虽病犹可治疗。《难经·十四难》曰：“……人之有尺，譬如树之有根，枝叶虽枯槁，根本将自生，脉有根本，人有原气，故知不死。”因此，正常的脉当是一息脉动4~5次，均匀和缓，力量中等的有根之脉。脉在具备了胃、神、根的同时，也必须反映出四时五脏阴阳盛衰的变

化，只有这样才能称为正常脉象。另有人天生脉来异常。因人的先天禀赋不一，少数人生理有别，有人天生脉来沉细，脉稍变大即为病脉；有人天生脉来粗大，脉稍变弱如常人亦为病脉。此异常脉象，不可当作病脉。遇此种脉，当问其平时脉象如何，参之以证方可不失。

十、真脏脉

何为真脏脉？简言之，没有胃气的脉即为真脏脉。病邪对脉搏的影响超过了其它各种因素的影响，脉象唯反映出疾病引起的变化，此种脉象即为真脏脉。经言：“故邪气胜者精气衰也，故病其者，胃气不能与之俱至于手太阴，故真脏之气独见者，病胜脏也，故曰死。”真脏脉反映在病机上，是病势发展到了极点而正气衰败，正气无力与病邪相争，病势已多不可逆转。它的表现，经曰：真肝脉至，中外急如循刀刃责责然^[16]，如按琴弦，色青血不泽，毛折乃死。又曰：真肝脉来，急益劲，如新张弓弦曰肝死。真心脉至，坚而搏，如循薏苡子累累然^[17]，色赤黑不泽，毛折乃死。又曰：死心脉来，前曲后居，如操带钩^[18]曰心死。真肺脉来，大而虚，如以羽中人肤，色白赤不泽，毛折乃死。又曰：

死肺脉来，如物之浮，如风吹毛曰肺死。真肾脉至，搏而绝，如弹石辟辟^[19]然，色黑黄不泽，毛折乃死。又曰：死肾脉来，发如夺索，辟辟然如弹石曰肾死。真脾脉来，弱而乍数乍疏^[20]，色黄青不泽，毛析乃死。又曰死脾脉来，锐坚如鸟之喙^[21]，如屋之漏，如水之流曰脾死。后人总结为十怪脉。

十怪脉：①雀啄；②屋漏；③釜沸；④虾游；⑤弹石；⑥解索^[22]；⑦鱼翔；⑧偃刀；⑨转豆；⑩麻促。

对十怪脉的理解如下：

1. 雀啄：脉来有短、硬、急速而间歇之象，如雀啄食，连连急数，时复一止，为脾绝之脉。

2. 屋漏：脉来短而迟，如屋漏水之状，久时才见一滴。心率约在 30~40 次/分。多见于窦房结病变和传导阻滞。亦为脾绝脉。

3. 釜沸：脉来浮数之极，犹如滚沸的开水在锅内沸腾。多为心动过速。其中阵发性者预后尚好，室性心动过速则预后不良。

4. 虾游：脉来沉，久时不动，忽见一浮，为极严重的心律失常，心力衰竭，是心的真脏脉。

5. 弹石：脉来硬如以指弹在石上的感觉，为急促，坚硬之脉是肾的真脏脉。

6. 解索：脉来散乱无序，是一种节律严重不整的

脉象，类似于房颤一类的脉象。

7. 鱼翔：脉来迟，不定时见一动。具有浮、迟，不定时的特点。多为完全性传导阻滞，严重的心律失常。

8. 偃刀：脉来弦、细、紧而硬，如用手触摸在刀刃上的感觉，为肝的真脏脉。

9. 转豆：脉形短而燥疾，如转动豆子的感觉。多见于心律紊乱的病人。

10. 麻促：脉至如麻子，有细、短、微至甚，且急促零乱的特点，见于严重的心力衰竭。

十一、诊脉辨证

（一）“独”字求病位

诊察寸口脉的变化，可以看出疾病发生的病位，病性，以及发展变化的趋势。仲景曰：邪不空见，必有所奸。如何分析判断疾病所在的部位与病性呢？《内经·三部九候论》曰：“察九候，独小者病，独大者病，独疾者病，独迟者病，独热者病，独寒者病（独寒、独热为察皮肤温度的变化，为诊尺肤的内容）独陷下者病。”正所谓独处藏奸。所谓独者，其指有二：一是部位独，即在寸、关、尺、左、右手六脉中单独出现一

个部位的异常脉象，独大，独小，独滑，独沉与众不同，说明病变的部位就在该部所属的脏腑或肢体相对应的部位上，多为局部气血失调，脏气不平之象。需要说明的是：在部位独方面，历来脉书均提到独疾、独迟、独数、独缓。我们知道脉搏是血液在心气的推动与动脉血管舒缩功能的共同作用下形成的。血液在运行中是不可能堆积起来的。因此，在一条脉中寸关尺三部脉，其搏动的次数应是一致的，不可能有寸数而尺迟至数上的变化。所谓寸关尺三部独疾，独迟的说法在理论上是行不通的，实践中也是不存在的，此处当予以正误。考：独处求病位的方法源于《内经·三部九候论》遍身诊法，《难经》将此法移至诊寸口脉三部分位上，独疾、独迟、独缓的理论仍保留下来，后人不察缪中留传至今（临症中也有寸、关、尺三部中一部独大，其余脉沉弱而六脉在至数上均为数脉或迟脉，在描述此种脉象时常以某部独浮大而数，或独迟而大，是可以成立的。但它与寸数而尺迟在至数上的独有本质不同，当予以说明。

二是脉象独：寸口脉，左右手六脉同出现一种脉象，独大、独小、独疾、独迟、独浮、独沉……等等。说明整体病变的性质和程度，多为阴阳失调，气血偏盛偏衰的表现。

（二）阴阳求病性

疾病的发生是机体受病邪的侵害，或机体气血逆乱，脏腑功能失调引起的，可归纳为阴阳的偏盛偏衰。人体正常情况下，阴阳是相对平衡的，阴阳失衡就会发生疾病。病邪的性质分阳邪与阴邪。阳邪致病使人阳盛而阴衰；阴邪致病使人阴盛而阳衰。阴阳偏颇表现在脉上，阳邪致病出现阳脉——浮、大、数、实；阴邪致病出现阴脉——沉、迟、虚、微。根据脉搏的表现可以判断出疾病的性质是热症，还是寒症；是虚症还是实症。以脉辨症分虚实，《内经·脉要精微论》五脏脉搏坚软散所主不同就是例证。经曰：“心脉搏坚而长，当病舌卷不能言；其软而散者，当消环自己^[23]。”搏坚而长者为弦实脉，为有余之脉。此为心火亢盛，邪气强实之证。心开窍于舌，主神志，邪火挠心，心窍不利，神识受蒙则舌卷不能言；软而散者为虚脉，其证为虚。心液内虚，当病消渴。其病环转，消渴自愈。“肺脉搏坚而长，当病唾血；其软而散者，当病灌汗^[24]，至令不复散发也。”肺脉搏坚而长亦为太过之脉，阳邪过胜，火热灼肺，伤及阳络，故唾血；肺脉软而散者，肺气虚，气虚卫外不固，易汗多寒，汗出如以水浇灌，故不可再发汗。“肝脉搏坚而长，色不青当病坠若搏，因血在胁下，令人喘逆；其软而散色泽者，当病溢

饮^[25]。”肝脉弦实为肝本脏自病之脉，其色当青，今色反不青，知非肝本脏自病，而因跌扑、打斗瘀血结于胁下，影响气机升降，故令人喘逆；肝脉软散是肝虚证，木弱土反侮之，水湿过盛，脾失运化，故病溢饮。“胃脉搏坚而长，其色赤当病折髀^[26]；其软而散者，当病食痹^[27]。”胃脉搏坚而长为弦实之脉，为阳明火盛，木火交炽胃经必伤，胃的经脉过髀，故病折髀。折髀者，髀部疼痛似折。其软而散者，胃气虚食不能化，故为食痹。“脾脉搏坚而长，其色黄当病少气；其软而散色不泽者，当病足骭肿^[28]，若水状也。”脾脉弦实为脾见肝脉之实证。肝木过克脾土，脾必衰，脾衰其色外现，故色黄而少气；其软而散者，脾本脏虚证。脾虚水泛，湿从内生，故色不泽而病骭肿若水状。“肾脉搏坚而长，其色黄而赤者，当病折腰；其软而散者，当病少血至令不复也。”肾脉弦实为邪干肾，色黄赤为心火亢盛土气有余之证，土、火均与肾水相克，肾水不足而邪气亢盛，故病折腰；肾脉软散为肾本脏虚，肾虚则精亏血少，故令不复。五脏脉见搏坚而长，为实脉而见实证；软而散为虚脉而见虚证。

（三）比较求病势

病势是病机的组成部分，是疾病发展变化的趋势。疾病的发展是由表入里，还是由里出表；向重发展，还

是转愈，从邪正两方面的盛衰变化可以推求。脉象正反映了人体阴阳消长，正邪进退的这种变化，为掌握病势，正确判断疾病的发展变化提供了依据。经曰：“长则气治，短则气病，数则烦心，大则病进，上盛则气高，下盛则气胀，代则气衰（以脉止为代），细则气少，涩则心痛。浑浑革至如涌泉，病进而色弊，绵绵其去如弦绝死。”经文长、短、数、大均指脉象。血为气母，气为血帅，气盛则脉盛，气虚则脉弱。脉长则元气充沛，故为气治，脉短则元气不足，故气病。脉数则为热，邪热挠心，故为心烦。脉大是阳邪为患，愈大阳邪愈盛，故为病进。寸脉为上，尺脉为下，寸脉盛则邪结在上，故气高；尺脉盛则阳邪在下，气陷于下，故为气胀。脉以止为代，元气衰败脉来鼓动不能接续而见止竭，故代则气衰。脉细则元气不足，故为气少。脉涩则血行不畅，心脉痹阻，故为心痛。脉来强劲如泉水奔涌，为实邪为患，故病进而色弊；脉来绵软无力为虚，如弦断绝不来者死。经文正反映了从脉的表现上推断病势的这种变化，但分析病势是在辨证基础上进行的。经言：“大则病进”阳邪为患其脉洪大，脉大表示邪盛，邪盛病情必然发展加重。伤寒三阴症，其脉本沉、细、微、小现脉渐转大为阴症得阳脉，为邪退正复之象，此处当以大则病退。久病之人

脉本沉小，忽然暴出为阴阳离绝之脉，主病危。因此，要掌握病势首先要弄清楚病邪的性质是阴邪还是阳邪，是邪盛还是正虚，才能结合脉象正确地作出判断。经曰：“必先审问其所始病与今方病，而后各切循其脉，视其经络浮、沉，以上下逆从循之……”。今之脉较前之脉，转大还是变弱。一般讲：阳邪为患脉转大是阳邪更盛，病情必加重；阴邪为患脉本沉、迟，愈沉、愈迟病情愈重，脉转浮、转数为病情减轻。虚邪为患脉本微、细、迟、无力，脉渐转大，转有力为病情转轻而忽然浮大暴出为阴阳离绝，预后不良，非为转愈。

十二、脉象反映病理变化

脉在反映病理变化上，有溢脉、覆脉、关脉、格脉，有阴阳相乘脉，有阴阳相伏脉及阴阳绝脉。

1. 溢脉：脉浮而长，超过本部，直上鱼际为溢脉，又名外关。《难经·三难》曰：关之前者，阳之动也，脉当九分而浮，过者法曰太过。溢脉所反映的病理是，气血闭绝于外，阴阳不相交通，阳盛极于上。

2. 覆脉：脉沉长超过本部，直下人尺为覆脉，又名内格。《难经·三难》曰：关之后者，阴之动也，脉当一寸而沉。过者法曰太过；减者法曰不及，遂下入

尺为覆脉。它所反映的病理是阴阳格拒不相融和，阴盛极于下。此二脉为真脏脉。

3. 阴阳相乘脉：脉居阳部反见阴脉，为阴乘阳；脉居阴部反见阳脉为阳乘阴。（阴阳部：寸脉为阳，尺脉为阴；浮脉为阳，沉脉为阴）阴阳相乘脉所反映的病理是阳胜则乘阴，阴胜则乘阳。

4. 阴阳相伏脉：脉虽为阳脉（浮脉），但浮中偶见沉涩，短脉，微脉，此为阳中伏阴；虽为阴脉（沉脉）而偶见浮、滑、长脉，此为阴中伏阳。其反映的病理是阴胜则阳伏，阳胜则阴伏。

5. 阴阳绝脉：仲景曰：寸脉下不至关为阳绝；尺脉上不至关为阴绝。即寸脉短，关尺无脉为阳绝下；尺脉短，关寸无脉为阴绝于上。此二脉古人以为皆不治，决死。（阴绝脉当于有根脉区别）。

以上脉的表现，反映了阴阳盛衰的病理变化，阴盛则乘阳，阴虚则伏于阳中。溢脉、覆脉反映了阴阳偏盛到了极点时出现的脉象，而阴阳绝脉又反映了阴阳衰败时出现的脉象变化。

十三、寸口脉主病脉辨

（一）外感病脉辨

外感病从脉上主要辨别病邪的性质，邪在的部位（或阶段），以及正邪进退，阴阳盛衰。外感病发病的规律一般是，初期病多在表，不解则由表入里，从实转虚，由阳转阴（亦有虚人直中于里）。因此，初病脉象多表现为浮而盛大或盛滑而坚。经曰：“寸口脉浮而盛大者病在外，寸口脉盛滑坚者曰病在外。”随着病情好转，邪退正安，脉由盛大浮数或浮紧，转小转静。如病邪不解，向深层发展，病情加重，邪热入阳明气分则脉洪大、急数；邪入胃肠脉变沉实。向深发展由阳转阴，伤及阴液脉多转细、转数，损伤阳气脉多变沉、变弱。外感初期，随着感邪性质不同，脉的表现亦有明显区别。兼风热者多浮数，兼风寒者多浮紧，兼湿热者多濡数，兼寒湿者多沉细，表虚中风（伤风）者多浮缓。病变早期脉的变化尚有一定的规律可循，随着病情的发展转变，脉的变化可有千差万别，难于用一种格式来规范。但，万变不离其宗，归根到底是阴阳的变化，抓住了阴阳这个纲就可以不变应万变了。

（二）五脏病脉辨

寸口脉，见不当时及少胃气的五脏脉象，长而弦者病在肝，洪而滑者病在心，弱而软者病在脾，浮而涩者病在肺，沉而紧者病在肾。（详见下篇，四时五脏脉法）。

寸、关、尺三部脉中，独见一部异于常，而见五脏证者：右寸独异病在肺，右关独异病在脾胃，右尺独异病在右肾与大肠；左寸独异病在心，左关独异病在肝胆，左尺独异病在左肾及小肠、膀胱。（结合二十八脉主病辨证）。

（三）杂病脉辨

杂病中一脉主多病，一病见多脉尤为明显。如濡细之脉湿痹多见，虚劳、失血、痰饮证中也可见之。要知湿痹病多见濡细脉，而濡细脉并非湿痹所独有。因此，临症辨脉必参以证，脉证合参方可定病，单以脉断病，会怡误病情甚至误人性命。

杂病辨脉，当首先辨病，病名定而后再辨脉、议证。从脉上辨别病位：五脏六腑，三焦上下，表里内外……；病性：虚实寒热，阴阳盛衰；病邪：气、血、痰、食、七情、六淫……。王叔和《脉经》说：阳邪来见脉浮洪，阴邪来见脉微细，水谷邪来见脉实坚，寒癖之邪来见脉弦小。

1. 虚劳病脉辨

虚劳病，为虚损、劳伤之类，皆由先天不足后天失养，饮食失节，劳倦过度或久病失治、误治而来（亦有正气不足瘵虫感染）。元气亏耗，久病不复，气、血、阴、阳损伤，或阴损及阳，阳损及阴或阴阳两虚是其病理。临症多以气、血、阴、阳四者为纲，五脏虚证为目，辨证分类。脉多表现：虚（虚大、虚数、虚滑）、细（细数、细涩）、微、弱、短、缓、濡、芤、弦（细）、沉迟无力等。归纳起来大体上分脉大和脉小两类。仲景说：“夫男子平人，脉大为劳，虚极亦为劳。”仲景所谓的平人，即貌似无病，实为虚损。其人脉大不合于时，多为虚阳外越之象，因虚阳外浮，故见脉大；脉虚极者，为轻取细软，重按极无力，为精血内虚血脉不充，久病劳损之脉。

按气、血、阴、阳分来看，虚劳病偏于阴虚者，脉多表现为，虚大而浮（阴不敛阳），细数（阴虚阳旺），濡细（气阴两虚）等脉象。证状表现上，除五脏阴虚证外，常见五心烦热，潮热盗汗，夜间口干，舌红苔少或苔薄而干等证。仲景云：“劳之为病，其脉浮大，手足烦，春夏剧，秋冬瘥，阴寒精自出酸削不能行。”此为虚劳中偏于阴虚者。阴血亏虚，虚阳外浮，故脉来浮大。阴不足则阳有余，春夏阳旺之时，两阳相合，

阳偏胜而出现烦热、手足热；秋冬阴盛阳衰，虚阴得助浮阳渐敛，阴阳暂时得平，故秋冬瘥。宜大补阴丸^①，六味地黄丸^②之类。

偏于阳虚者，脉多见微、缓、弱、沉迟无力、沉细涩无力等。证状表现上除五脏阳虚证外，兼见畏寒怕冷，四肢不温，面色㿠白，纳少，便溏等证。仲景云：“脉沉小迟，名曰脱气，其人疾行则喘喝，手足寒，腹满，甚则溏泻，食不化也。”脱气者，阳气虚元气不足，故疾行则喘喝。阳气虚寒自内生，故手足寒，脾阳虚不能腐熟运化水谷，故溏泄食不化。附子理中汤^③，金匮肾气汤^④主之。

偏于气虚者，脉多见虚、弱、缓、短。证状表现上除五脏功能低下外，兼见气短懒言，身困乏力或内脏下垂，脱肛等证。补中益气汤^⑤，黄芪建中汤^⑥主之。

偏于血虚者，脉多见细、弱、细弦、芤、虚滑、虚数等。证状表现上除五脏血虚证外兼有面色不华，唇舌色淡，晕眩，心悸，四肢沉困乏力等证。四物汤^⑦加味，归脾汤^⑧主之。

阴阳两虚者，脉多见沉、细、弱。证状表现上必有精神萎靡，易疲倦，见寒则恶寒，遇热则怕热，四肢不温，舌红而瘦或淡红而瘦，纳差，口不渴等证。仲景云：“男子平人，脉虚弱细微者善盗汗也。”阴阳两

虚之人，平时由于阴阳处于相对较低的水平，又在相对平衡之中，故貌似平人，但阴阳两虚，阴虚阳无化源，阳虚阴不能固秘，故卧则善盗汗，动则汗自出。地黄饮子^⑨，右归丸^⑩宜之。

虚劳病的脉象形态变化已如前述，在脉的表现部位上，除了可以反映在六脉上同出现一种虚劳脉象外，还可以根据不同的病位分别表现在寸、关、尺；左、右手脉上。其中左寸独异病在心，左关独异病在肝，右寸独异病在肺，右关独异病在脾胃，两尺独异病在肾。气虚、血虚的脉象除了可反映在五脏所属的部位外，还可以分别表现在左、右手脉的变化上。因左手寸脉主心，关脉主肝；心主血，肝藏血，心肝两脏共同主司血的生成和运藏，故血虚的异常脉象还可以表现在左脉上。气虚的异常脉象除了反映在五脏所属的部位上外，还可以反映在右脉上，因右寸脉主肺，右关脉主脾，肺主气，脾为气血生化之源，两脏共同主司气的生成和发布，故右脉又可以反映出气的虚实变化。

2. 暑病脉辨

暑季外感发热者多为暑病。暑病有阴暑、阳暑之分，又有中暑与伤暑之别。阳暑中分燥热与湿热；阴暑中有寒湿与脾虚伤暑。

暑病，脉洪大按之而虚，身热烦躁，恶热，大渴

饮冷，自汗出，头痛，怠惰，四肢不收，两足痿软者为中暑，属阳暑。多为辛苦之人动中而得，触冒暑热，热伤气阴，脉来洪大不胜重按，白虎加人参汤^⑪主之；其轻者，王孟英清暑益气汤^⑫主之。脉沉实而数，身大热，无汗恶寒，口干不多饮，头痛，肢节疼痛拘急，舌红苔黄而厚者为暑热夹湿，白虎加苍术汤^⑬主之。

暑病，脉浮紧，或濡数，身热无汗或少汗，身静不烦，头痛头闷，肢体困重，口不渴，或恶心欲吐，腹满，便溏者为阴暑。此为安逸之人暑天怕热，贪凉或饮冷而发，寒伤于卫湿伤于脾，发为阴暑，藿香正气汤^⑭、香薷饮^⑮主之。

脉濡细，头痛头闷，身热不扬，周身困乏，口燥不欲饮，纳呆，小便短赤者为伤暑，素体虚弱触冒暑热之气，脾虚不能健运，暑热之气不能及时排出，发为伤暑。东垣清暑益气汤^⑯主之。

3. 虐病脉辨

秋季感受虐邪，寒热往来交替发作，或恶寒发热或但寒不热者为虐病。仲景云：虐脉自弦，弦数者多热，弦迟者多寒，弦小紧者下之瘥。弦迟者可温之，弦紧者可发汗，针灸也，浮大者可吐之，弦数者风发^[29]也，以饮食消息止之。”

虐病发于少阳，邪在半表半里之间，少阳病主脉

为弦脉，因此，仲景说虐脉自弦。虐病有偏寒、偏热的不同，人的体质又有阴阳偏颇，气血盛衰的区别，虽同为虐病其脉的表现上亦有不同。其中热偏盛者脉弦数，寒偏盛者脉弦迟，表邪重者脉弦紧。在治疗上脉弦数者热偏胜，可用和解清热法，柴白汤^{①⑦}主之；脉弦迟者寒偏胜，寒湿之邪为患，可温化之，辛温苦燥芳化淡渗分消之。达原饮^{①⑧}，藿朴夏苓汤^{①⑨}，甘露消毒饮^{②⑩}之类加减化裁宜之。表邪重脉紧者，可用发汗剂或针灸治疗，脉来弦小紧者为病在里，有宿食，故可用通下的办法，大柴胡汤^{②⑪}，枳实导滞丸^{②⑫}之类治之。脉浮大者病在上、在外，可用吐法因势利导来治疗。对那些因感受虐邪又伤阴液的情况，即仲景所说风发脉弦数者，由于热邪伤及胃阴，可用甘寒多汁的饮食类如五汁饮^{②⑬}、粳米汤等调养使邪退正气来复。

4. 黄疸病脉辨

身目俱黄，小便色黄者为黄疸。

黄疸病，脉弦数，发热口渴，腹胀，纳呆，心中懊恼，恶心欲吐，小便黄赤，大便硬，身目黄色鲜明如桔色者为阳黄，茵陈蒿汤^{②⑭}主之。

脉沉细，或沉迟，口不渴，反恶寒怕冷，纳少，脘闷腹胀，身目黄色晦暗如烟薰者为阴黄，寒湿之邪为患，当温阳利湿退黄，茵陈术附汤^{②⑮}加味主之。

脉濡细或濡缓，身困、纳少、腹胀、口不渴、不恶寒、舌苔白厚腻，身目黄居二者之间者为湿热黄疸，湿重于热，当清热利湿与健脾化湿合治。茵陈蒿汤，藿朴夏苓汤合用加减化裁治之。其轻者茵陈五苓汤^{②6}亦主之。

脉虚弱，面目痿黄，小便清利，纳少，心悸、气短，四肢困乏无力者为虚黄，气血亏虚脾不生血，宜益气养血健脾，人参养荣汤^{②7}、归脾汤^{②8}等宜之。

5. 失血病脉辨

失血之脉，洪大而数者多见于吐血，衄血，咳血之证，其血色必鲜红，兼见烦渴，舌红苔黄而燥，为实热证，当清热凉血、止血，犀角地黄汤^{②9}、大黄黄连泻心汤^{③0}主之。脉细数无力按之涩者多见尿血，为气阴两虚，血分蕴热，当以养阴清热，兼以凉血止血，小蓟饮子^{③1}主之。脉浮大而芤按之涩者，为阴血亏虚阳气浮越，必多汗，小便频数，心悸，宜补气养阴中佐以摄纳。便血，脉沉细弱者，久病脾不统血，必短气，纳呆，畏寒，面白，血色淡红。治以益气养血温中健脾，黄土汤^{③2}，归脾汤加减化裁。

失血之脉，浮大牢实者死，滑小弱者生。然，新病邪热盛时脉见浮大牢实为阳邪盛不可断为死，因脉与证相附。大失血之后，邪随血泄，脉当虚、小、弱，

如仍浮大牢数，说明阳邪并未因血泄而减。今正气已虚，而邪热仍盛，为正虚邪实，正不胜邪故曰死。

6. 泻、痢病脉辨

里急后重，腹痛，大便赤白者为下痢。下痢脉沉迟，口不渴，舌苔白而润者为寒湿痢，桃花汤^⑳主之。脉细弱，身静不烦，时发时止者为虚寒痢，理中汤^㉑主之。下痢脉数，发热，口干，舌红苔黄而燥，里急后重，肛门灼热者为湿热痢，芍药汤^㉒主之。

大便稀溏或稀水样便，日数次至数十次者为泻泄。脉滑数，暴迫下注，身热烦躁，口渴引饮，声音洪亮为热泻，葛根芩连汤^㉓主之。脉沉细，口不渴为寒湿泻，理中汤加五苓散主之。脉紧，腹胀不欲饮食，大便溏，秽臭或完谷不化者为伤食泄，保和汤^㉔，枳实导滞丸主之。

脉弦，腹痛即泄，每因情志不畅则发者为气泄，为肝木克脾，脾气不升而发，治以痛泄要方^㉕合逍遥散^㉖加减化裁。

7. 消渴病脉辨

多饮、多食、多尿尿有甜味者为消渴病。

消渴病，脉洪数，口渴多饮，口干舌燥者为热在上焦。治宜清热泻火，生津止渴，治宜消渴方加减。脉实有力，证见多食易饥，大便燥结者为阳明胃火炽盛，

胃液亏耗。治当清热养阴，生津止渴，宜玉女煎^⑩之类。脉沉细而数或沉细无力，小便频数如脂膏，甚至饮一溲二，形体消瘦者为肾阴亏耗，肾气不固或阴阳两损治宜滋阴固肾，麦味地黄汤主之；阴阳两虚者桂附八味丸宜之。

消渴病，脉弦小紧者为久病脏气损伤邪气尚盛，病不易治。

口渴多饮者，除消渴病外，还有消渴症。只有渴饮，而无多食，尿甜者为消渴症。其病有热寒之分，有在脾在肺之别。属热者脉当洪数，病在胃，为热盛，治当清热养阴。在脾肺者为虚为水湿不化。由于脾湿不运，肺虚不布，津液不能蒸化，不能濡润孔窍，故形成口干欲饮，饮后不化，欲呕。其脉多沉细或细弦。在肺者干姜甘草汤^⑪主之；在脾者五苓散^⑫，香砂六君子汤^⑬主之。

8. 痹病脉辨

风寒湿邪合而为患，邪客于肌肉，筋骨，关节间，经脉闭阻，气血不畅肢体关节疼痛肿胀、麻木、重着者为痹病。痹病，脉紧或弦迟，关节痛剧，得热则减，遇寒加重，皮色不变，苔白润者为疼痹。此为寒邪偏重，治以散寒祛风除湿，乌头汤^⑭主之。脉濡缓或沉弱，肢体关节疼痛重着、麻木，活动不便者为着痹，湿邪

偏重，治宜利湿为主佐以祛风散寒，薏苡仁汤^{④5}主之。脉浮滑，肢体关节疼痛，游走不定，累及多个关节或发热恶寒，苔白润者为行痹，风邪偏重，治宜防风汤^{④6}。脉洪数或濡数，关节红肿热痛得热则剧遇冷则减，发热口渴，舌红苔黄者为热痹，为风寒湿邪郁久化热，或素体热盛又感风寒湿邪而发。白虎加桂枝汤^{④7}主之，寒热夹杂者桂芍知母汤^{④8}主之。久病脉细弱，关节肿疼，肌肉消瘦者为虚实夹杂，治宜益气养血调补肝肾佐以疏风通络除湿，宜独活寄生汤^{④9}之类方。

9. 胸痹病脉辨

胸闷、气短、心悸、心痛时发者为胸痹。仲景曰：“阳微阴弦即胸痹心痛，所以然者责其极虚也。”阳微阴弦即指脉象，寸部脉微，（多见于左寸脉）关尺脉弦或指浮取脉微，按之沉弦，因胸阳不足，阴邪干之故病胸痹。此胸痹病中之阳虚证，瓜蒌薤白白酒汤^{⑤0}主之。脉沉迟或紧，胸痛背痛，气短喘促不得卧，苔白滑腻者为寒水之气上凌心火，当以温阳宣痹乌头赤石脂丸^{⑤1}主之。脉短而数，按之无力，心痛、心悸、心烦者为气阴两虚，心火偏盛之证，生脉散加味^{⑤2}或炙甘草汤^{⑤3}主之。脉细涩，胸痛如刺，痛有定处，口唇紫暗者此为瘀血阻络，当活血通络，宜丹参饮^{⑤4}加味。胸痹心腹痛，不得息，脉细小迟者生，（证虚脉虚，脉证相

附) 脉坚大实者死 (证虚脉实, 脉证不附)。

10. 宿食病脉辨

暖气食臭, 腹胀肠鸣, 下利臭秽, 不欲食者为宿食。宿食病, 脉紧如转索, 下利, 舌苔白厚者为宿食在下, 宜攻之承气汤^⑤之类。脉滑而数, 寸脉浮大, 尺脉反弱, 暖气酸腐者病在上, 宜吐之, 瓜蒂散主之。脉紧腹胀, 不欲食者病在中, 宜消磨之, 保和汤主之。脉虚弱, 平时纳少、便溏稍多食则腹胀肠鸣、下利者为脾虚泻。治宜健脾为主, 佐以消导, 参苓白术散^⑥或香砂六君子汤加助消化药。

11. 淋病脉辨

小便频数, 点滴而下, 尿急尿痛者为淋病。淋病, 尺脉盛大者为阴不足阳乘之, 膀胱有热, 八正散^⑦之类主之。脉细而数, 为阴虚有热当滋阴清热利湿, 小蓟饮子^⑧, 知柏地黄汤^⑨主之。

12. 寒疝病脉辨

腹痛绕脐有形, 出见头足^[30]者为者疝。仲景曰: “腹痛, 脉弦而紧, 弦则卫气不行即恶寒, 紧则不欲食, 邪正相搏, 即为寒疝。绕脐痛, 若发则白汗出 (出冷汗), 手足厥冷, 其脉沉弦者, 大乌头煎^⑩主之。”寒疝之病有虚实两端。经曰: 脉急者曰疝瘕少腹痛。脉急, 为弦紧之脉, 此寒邪为患, 寒侵于里, 少腹为厥阴之

地，邪犯厥阴，肝经受寒，气血凝滞，气机不畅，少腹有形，故为疝瘕少腹痛。又曰：脉沉而弱者为寒热及疝瘕少腹痛。脉沉而弱为气血、阴阳两虚，正气内虚寒自内生，稍感外邪直中于里，寒凝气滞故为疝瘕少腹痛。《内经》以脉急为疝瘕少腹痛中的实脉实证，脉沉而弱为疝瘕少腹痛中之虚脉虚证。病虽相同，虚实有别，脉的表现亦有区别。

13. 症瘕积聚病脉辨

症、积者，为有形之病，有结块，终不移；瘕、聚者，为无形之病，发作有时，展转痛移。经曰：寸口脉沉而横曰胁下有积也，腹中有横积痛^[31]。脉沉而横为牢实之脉，为有形之邪结在里，故为有积之征。脉来细软附骨者亦为积，《金匱要略诸积大法》说：“脉来细软附骨者为积也。寸口结（指寸脉）积在胸中；微出寸口，积在喉中。关上结，积在脐旁；微下关者，积在少腹；尺中结，积在气冲。上关上，积在心下。出在左，积在左；脉出右，积在右；脉两出，积在中央，各以其部处之。”脉沉而横与细软附骨，两种脉象同为积，沉而横为邪实，病始成，气血尚未衰败；细软附骨，为久病气血衰之象。同为一病初病久病，虚证实证脉见不同。

症瘕之病，脉紧强急者生，脉沉伏细弱者死。（脉

紧强急者多为瘕聚，病浅在气分，预后较好故曰生。脉沉伏细弱者为症积，病深在血分，预后差，故曰死。）

脉沉小而实，食不下，食则吐，胃有积。脉弦而浮腹中有症积，不可转者死。症瘕积聚脉的区别，丹溪曰：脉弦、细、微者为积，脉沉伏细微者，为积。脉沉紧，心下有寒者为瘕。

14. 中风病脉辨

猝然昏倒不醒人事，口眼歪斜，肢体不遂，语言蹇涩者为中风。中风辨证当分刚、柔。

脉洪数或弦大有力，动中发病，来势急暴变化多端者为刚风。肝阳化风，风阳鸱张气血上冲，闭阻脑窍为其病理。治疗上当分闭证与脱证，并根据气、火、痰、瘀及腑实的有无及程度选方用药。脉的表现上兼风痰者脉兼滑，兼阴虚者脉多芤，兼腑实者脉沉实，风火盛者脉洪数。多以羚羊钩藤汤、^⑥镇肝息风汤^②化裁治疗。刚风，脉由数转缓，证见昏迷加深，呼吸不稳为病情加深，非为好转；脉忽由强转弱，血压聚降呼吸多吸少，多为临终之象。

中风脉较弱，两寸尤甚，静中发病，肢体不遂者为柔风。多为气虚血瘀，瘀血阻络，治以益气通络，补阳还五汤^③主之。

十四、寸关尺三部脉独见主病

寸关尺三部六脉中，独见一部异常，主病。所主何病，当根据脉象与临床表现方可定病。此列举十种脉象简要说明。辨脉贵在灵活，不可死搬教条。十种脉象，按阴阳盛衰，与寸关尺分部举例说明而已，不可作为定式。

对十种脉象寸关尺分部主病表解，特作以下说明：

1. 每种脉象（单脉）都包含有浮、沉、迟、数、虚、实等多种兼脉，它们所代表的意义不同，表中不可能全都列出，只能择其一种兼脉，简要说明。

2. 至数上不可能有部位独，所谓的浮数，沉迟是指某个部位上，浮数、沉迟独明显，其余脉较弱，并非寸数而尺迟之意。

十种脉象寸关尺主病表

主病机理	脉象	分部主病							
		左寸	左关	左尺	右寸	右关	右尺		
阳邪盛	浮(数)	头痛、热、面肿、口疮、头发、头痛、舌生疮	肝热、痛、赤、胆发热	风、筋、目、黄、热	膀胱、便涩、淋	风、小、赤、热	热、咳、鼻、胸、喘、塞、痛	胃盛、满食、难、火、腹、不、便	大、热、难、痢、肠、燥、便、热
阴寒盛	沉(迟)	心痛、引、恶、寒、背、寒	肝、筋、满、痛	寒、胀、痛	腰、膝、冷、痛	肺、痰、蓄、喘、短、寒	寒、水、咳、气、形	脾、寒、满、不、消、胃、中、食	少、腹、冷、寒、泄
热宿病	滑(数)	心、痰、烦、心、头、失、眠	经、火、热、悸、眩、怒	头、目、筋、痛、烦、怒	痛、赤、胀、心、喜	腰、尿、痛、淋、淋	胸、满、咳、逆、热	热、喘、气、痰、脘、满、痛、食、化、逆	胀、腹、宿、不、吐、便、下、痛、痢
气血虚	细(弱)	胸、痹、心、心、悸、怔、忡	血、筋、目、明	虚、痛、不、胀、涩	精、伤、漏	肺、气、虚、自、汗	脾、虚、不、呕、食	血、虚、大、艰、燥、秘	

(续上表)

主病机理	分部主病		左寸	左关	左尺	右寸	右关	右尺
	脉象							
肝寒邪饮	弦(迟)		头痛、心痛	胁胀满、痰症、瘕	饮在下焦	胸及头痛	脾虚肝邪、心腹疼痛	饮在下足、挛疝痛
寒伤邪食	紧		心痛满、伤寒急、发热	腹痛寒疝	奔豚疝痛	伤寒发咳、恶寒、身痛	吐逆、伤腹寒疝	奔豚寒疝
实食热滞	实(大)		心中积、口生咽、心热、舌疮、痛	肝火盛、胀满、易怒、胁痛、躁	少腹热、溺尿、痛、闭、淋血	胸中热、咳喘、肺逆满、热	食滞、腹胀、实、热、腹胃	脐痛、难、疮血、痢、下便痔下热
气血虚弱	虚		心气虚、短汗、悸、血虚、自惊、心	肝血虚、不荣、筋	肾阴虚、腰膝痿软	自汗、怯、久咳不止	脾胃虚、食不化	肾虚精、腰膝痿软
失血	芤		吐血、妄行	肝不藏血、吐血	小便下血、女子崩漏	咳嗽、吐血衄血	呕血、肠下血	大便下血、尿血

(续上表)								
主病机理	分部		左寸	左关	左尺	右寸	右关	右尺
	脉象	主病						
阳气虚	微		虚不神惊胸痛 阳气足，虚悸，痹	冷筋急 肝逆、拘挛	滑带冷 精漏下 遗泄崩下脐痛	虚虚出、促、短 肺寒、汗喘气	寒食 胃胀、不化	泄脐痛 寒泻、下冷

注 释

[1] 橐龠：烧火用的风箱。

[2] 审清浊而知部分：审察面部色泽判断脏腑病变。清：色泽明亮。浊：色泽晦暗。

[3] 权衡规矩：权：计重的器具；衡：测平的器具；规：校正圆形的工具；矩：校正方形的工具。此处以古代权、衡、规、矩来比喻脉与季节气候相应的特点。权，比喻冬脉的沉石；衡，比喻秋天脉的轻虚而浮；规，比喻春脉的园利；矩，比喻夏脉的洪盛。

[4] 平旦：早上太阳露出地平线的时候。

[5] 趺阳脉、太溪脉诊脉法：属遍身诊法内容，但

又区别于《内经》遍身诊法，为仲景所创。

[6]、[7] 全息论——即“宇宙全息统一论”。由我国学者王存臻，严春友创立。宇宙是一个统一的整体，由各系统与子系统组成，各系统与子系统中包涵着宇宙和系统的全部信息，子系统是系统的缩影，系统是宇宙的缩影。

[8] 全息元：物体和宇宙中，物质功能和结构与周围的部分有相对独立的边界的相对独立部分，称为全息元。

[9] 斯须：一小会，指时间很短。

[10] 按而纪之：纪：衡量事物的尺度。用手按脉，在沉部区别脉象。

[11] 终而始之：从头开始，即在浮部诊察脉象。

[12] 《素问直解》：为清代医家高士宗所著。在解释推法时说：言诊脉亦有外、内、上、下之法也。推而外之，医之手指向外以按之，脉偏盛于内而不外，此心腹有积也……

[13] 《医学入门》：为清、李梴所著。说推法应须横且竖，即上下左右推的意思。

[14] 润以太息：正常人数次呼吸中，间有一次较深呼吸。

[15] “非”原文无此字，疑脱今补上。倘不加非字，

无胃气成为肝不弦，肾不石而胃气脉成肝脉弦，肾脉石，这显然是不对的。

[16] 如循刀责责然：循、触摸。责责然，锋利的样子。比喻肝的真脏脉，象用手触摸锋利的刀刃一样，又细又硬。

[17] 如循薏薏子累累然：比喻脉来如手触摸薏米子一样坚硬、短小、密集。

[18] 前曲后居如操带勾：比喻脉来轻取坚强不柔和，重取牢实不动如持革带之钩，失柔和之气。

[19] 如弹石辟辟然：形容脉来强硬，如手指弹在石上的感觉。

[20] 乍数乍疏：脉律不整时快时慢。

[21] 如鸟之喙，形容脉来如鸟的嘴短硬无柔和之象。

[22] 解索：脉来如以手解绳索，比喻力量和节律快慢不等，完全没有规律。

[23] 消环自己：消，指消渴病；环，指循环；自己，病自愈。消渴病由重到轻循环自己好转。

[24] 灌汗：汗出多如以水浇灌。

[25] 溢饮：病名，水液滞留于体表及皮下组织，证见身体疼痛，四肢浮肿，咳喘等。

[26] 折髀：髀，指大腿前方内侧部位。折髀，髀部

疼痛似折。

[27] 食痹：病名，胃病的一种。饮食入胃上腹部闷痛，吐出则舒，多因肝气乘胃，胃脘气滞。

[28] 骭肿：骭骨，指足胫骨。足胫部肿胀为骭肿。

[29] 风发：风指邪气，风发指感受虐邪而发热，伤阴的意思。

[30] 出见头足：腹部隆起包块，可移动，如有头足。

[31] 横积痛：指腹内积块横居作痛。

中 篇

二十八脉辨析及主病

为了更好的学习掌握各种脉象，医家对二十八脉进行了不同的分类。常见的分类方法有：对看法与类比法。

一、对看法

把在某一属性上，具有相反特性的两种脉象，相互对比研究的方法叫做对看法。如：浮脉与沉脉，迟脉与数脉，虚脉与实脉，滑脉与涩脉，洪脉与细脉，濡脉与弱脉，牢脉与芤脉，通过对比更易于掌握它们各自的特点。

（一）以脉在部位的深浅来分

浮脉——沉脉（附：伏脉）

区别要点：脉在上部为浮脉，脉在下部为沉脉，脉在最下部必重按至骨乃得，为伏脉。

1. 浮脉

定义 以脉所在部位的深浅来分，脉在上部为浮脉。

形状 浮脉在肌肤上部，如鱼游水在波，如水漂木，举之有余^[1]，按之不足。

机理 凡外邪中表，正邪相搏，阳气鼓动驱邪于外而现浮脉；或阳气过盛，气火有余鼓动脉出，脉也现浮；阴血不足，阴不恋阳，阳气浮越脉亦现浮。此外尚有阴寒过盛格阳于外，或虚阳暴脱，出现浮脉。

主病 浮脉属阳脉。浮脉主病有阴阳表里不同，虚实寒热之异。其主病，为表证发热恶寒，中风咳喘，为暑热外感，为疮疡肿痛，为中满不食，为中气虚，为阴虚阳浮等。

浮脉以有力无力属阴、属阳。浮而有力为阳、为实，主病在表；浮而无力属阴，属虚，主病在里。表证每以兼风寒则脉浮紧，兼风热则脉浮数，兼风湿则脉浮缓，兼痰热则脉浮滑。里证，脉来浮软无力，证见五心烦热，腰膝酸软，盗汗，遗精滑泄者为精血内虚，为虚劳。脉来浮大无根证见呼吸困难，张口抬肩，面目浮肿者，为肺肾两虚，肾不纳气，气脱于外，病

情凶险。

浮脉除沉脉外可与多种脉象相兼，在意义上：浮而兼数多为风热，浮而兼紧为风寒在表，浮而兼洪为表热实证，浮兼细软为气阴两虚，或为暑湿在表，浮而兼虚，为阴虚阳浮，浮而兼芤多为失血，浮而兼短多为气亏，浮而细涩营血亏虚。外感病初期，脉象不一定都浮，浮脉的出现多在正邪相搏出现或将要出现发热时，因外邪初犯肌肤，阳气受郁一时不能达于肌表，故短期内可见沉脉。

2. 沉脉

定义 以脉所在部位的深浅来分，脉在下部为沉脉。

形状 脉来如石沉水底，中取不见，重按乃得。

机理 沉脉产生的机理有 4 种：

(1) 寒，湿阴邪直接损伤阳气，使阳气受挫不能鼓动于外。

(2) 气郁或邪热阻遏阳气，使阳气郁伏不能健行于外。

(3) 邪结于里，病邪内侵，人体气血亦趋向于里，出现沉脉。

(4) 阳气衰弱，脉来鼓动无力。

主病 沉脉属阴脉，主病，为痛，为饮，为里水

肿胀，为腹胀泄泻，为症积，为气郁，为便结……等等。

沉脉主病根据兼脉的不同有虚实寒热之分，气血阴阳之别。沉而有力为实，主病在里；沉而无力为虚，阳气虚弱。沉数有力为里实热证，沉迟有力为里寒实证，沉迟无力为里虚寒证，沉数无力为里虚热，沉而无力为血虚，沉细而数为阴虚，沉微为阳虚寒盛，沉细而软为阴阳两虚。

沉脉可与除浮脉外的多种脉象相兼。沉而兼滑多为痰饮，沉而细涩多为血瘀，沉而兼紧为冷痛，沉而兼缓为脾湿，沉而兼弦为肝郁气滞，或为痰饮，沉而兼紧主寒主痛，沉而细弦阴虚阳亢或为虚寒，沉而微为阳虚阴寒盛。沉脉辨别阴阳虚实，《学古诊则》说：“脉显阴象而沉者则久按愈微，若阳气郁伏不能浮应于外，脉反伏匿而沉者，则按久不衰。”为确实之论。

3. 伏脉

定义 脉在下部，必重按至骨乃得为伏脉。

形状 比沉脉更沉，推筋寻骨乃见。

机理 伏脉为气血结滞，邪气阻遏，气机壅塞，脉郁伏于内或为积损甚重，阳气衰败无力鼓动脉来见伏。

主病 伏脉为阴脉，为霍乱邪闭，疝瘕，大怒气郁，痛极，陈寒固冷，水气浮肿，溏泄水谷不化，停

痰宿食……等等。

伏脉以有力无力论虚实，有力为实，为火闭、寒闭或为气闭；无力为阳气衰败，症积后期气血损耗，元气衰弱脉多沉伏细微。

（二）以脉来至数上分

迟脉——数脉

缓脉——疾脉

从脉来至数上分，脉来一息四至以下为迟脉；脉来一息四至为缓脉；脉来一息五至以上为数脉；比数脉更快，一息七至、八至为疾脉。

4. 迟脉

定义 脉来一息四至以下为迟脉。

机理 气寒不行，血寒则凝滞，凡阳气受寒邪阻遏，寒入血脉气滞血凝脉来迟滞，或阳气虚弱脉来运行乏力，一息四至以下为迟脉。亦有邪热结于里，郁阻气机脉来迟滞。

主病 迟脉属阴脉，为寒，为痛，为寒痰停饮，心腹冷痛，胃寒食不化，寒泄，肾阳虚腰膝冷痛等。

迟脉有力为实，无力为虚。迟而有力多为寒实，迟而无力多为阳虚。迟脉主寒为常，主热为变。《伤寒论·阳明篇》“阳明病，脉迟，虽汗出不恶寒者其身必重，短气，腹满而喘，有潮热者，此外欲解可攻里也。手足濇然而汗出者，此大便已硬也，大承气汤主之……。”

此为邪入于里郁遏气机，虽为热症仍现迟脉。然，其证必兼口渴喜饮冷，舌红苔黄而燥，腹满，大便硬而不下为辨。迟脉中亦有邪热伤心，气阴两虚，瘀血阻络而现迟脉者，不可作寒论（部分病窦综合症患者如此）。此证必兼心悸、头昏、胸闷、气短，脉来乍数乍疏等症。

迟脉除数脉外可与其他多种脉象相兼。其兼浮者多主表寒，兼沉者多为里寒，兼虚者为阳气虚，兼实者多为寒实证，兼滑者多为寒痰留饮，兼细涩者为气血大虚为虚寒，兼沉弦而小者为陈寒固冷必难治。

5. 数脉

定义 脉来一息五至以上为数脉。

机理 凡邪并于阳，阳偏胜，或阴虚阳旺阴不胜阳，脉来急数，形成数脉。

主病 数脉为阳脉，多主热证，主腑病，为寒热，为阳盛，为疮疡，为胃热，为相火，为淋浊，为阴虚，为虚劳……等等。

数脉以有力无力为辨，数而有力为实热，数而无力为虚热。脉见浮数，当发热而未发热，身有痛处，饮食正常此欲发疮疡。

数脉主热为常，主寒、主虚为变。凡虚损之证，阴阳气血俱不足，心气衰弱多见数脉，不可以热论之。如

脉见浮数大而无力的，按之豁然而空，证见发热，面色戴阳，^[2]此阴寒盛迫阳外浮，是真寒假热，寒极似火非为真热。

数脉可与其他多种脉相兼，数而兼浮兼实者，多为表热实证；数而兼浮兼虚者，多为表热虚证；数而兼沉者为里热；数而兼滑者为痰火；数而兼洪者为阳盛多为疮疡；数而兼细者阴虚；数小无力或数大中空者为虚寒。

6. 缓脉

定义 一说脉来不快不慢四至为缓，一说脉来迟滞软弱无力为缓。

机理 湿邪阻遏阳气不能健行脉来迟缓，或气血向衰脉失健行，主病为虚。阴阳平和脉来和缓是有胃气之脉。喜爱运动之人，脉来和缓一吸四至为健康，长夏脾旺脉来软弱和缓为脾的正常脉象。

主病 缓脉为阴脉。缓脉，主病有虚有湿。主虚有：脾胃虚弱，心气不足，气短懒言，怔忡健忘等等。主湿有：风水、里水、湿痹等等。

缓脉以其兼脉不同而主病不同。浮缓为风邪在表，沉缓为湿邪在里，或为气血虚，缓细为湿痹，缓滑多为内热。

7. 疾脉 （一些医家将此脉归为数脉）

定义 脉来急数有匆忙之感者为疾脉，疾脉至数更多于数脉，一息七至、八至为疾脉。

机理 疾脉为阳邪盛。气有余便是火，邪火迫血急速运行形成疾脉，与数脉一理。或元气欲脱，心气衰败而现疾脉。

主病 疾脉为阳脉，主阳邪盛、热毒、疮疡、火结、气血热极；又主心气衰败，心悸、怔忡和劳瘵虚惫。疾脉以有力为阳邪盛，无力为虚损。伤寒实证热极方见此脉，劳瘵虚惫之人见此脉为阴竭于下，阳亢于上可予决以短期。心血虚心气不足之人，可见阵发性疾脉，此非为热，乃虚损之证。

（三）以脉来搏动有力无力来分

虚脉——实脉（附牢脉）

区别要点：以脉搏有力无力来分；有力为实脉，无力为虚脉，脉来沉实而长为牢脉。

8. 虚脉

定义 脉来无力为虚脉。

形状 脉体较大，按之虚软无力。

机理 虚脉为血脉空虚，阳气浮越之象。血者阴也，气者阳也，阴不足故按之虚软无力，阴虚阳无以守浮越在外，故脉体较大。

主病 虚脉属阴脉。虚脉为脾虚血弱，为伤暑，为

自汗气短，惊悸神疲，为饮食不化，浮肿便溏，为骨蒸潮热，腰膝酸软，头眩耳鸣等等。

虚脉主病有气血阴阳之分与五脏诸虚之别。《景岳全书·脉神章》说：“浮而无力为血虚，沉而无力为气虚，数而无力为阴虚，迟而无力为阳虚……。故凡洪大无神者即阴虚也，细小无神者即阳虚也。”

虚脉根据其所在部位与兼脉的不同，主病各异。虚而兼浮为表虚自汗，虚而兼沉里虚多泄，虚而兼迟多为虚寒，虚而兼数阴虚劳热，虚而兼大阴虚阳浮，虚而细小气虚血弱。五脏脉虚：心脉虚则心悸怔忡；肝脉虚则晕眩失眠；肾脉虚则腰膝酸软，遗精盗汗；肺脉虚则自汗气短；脾胃脉虚则腹胀、泄泻、食不化。

9、实脉

定义 脉来充实有力，按之不减为实脉。

形状 脉体较大，鼓动有力，按之有实满感。

机理 实脉由于邪气亢盛，机体抗病力强，正邪相搏邪抗有力，故脉来实大。如邪盛正虚抗邪无力，脉必实而兼细兼小。

主病 实脉属阳脉。实脉多主火热有余之证，为发狂谵语，阳毒，咽喉肿痛，肝火胁痛，热结便闭，淋痛，下肢肿痛等大热、大邪、大积大聚之象。

实而兼浮多为表热实证；实而兼沉多为里寒实证；

实而兼数多为实热；实而兼迟多为寒实；实而兼洪滑多为火邪实证；实而兼弦主寒主痛，或为症积，或为肝郁；实而兼沉细小或沉细而弦为邪盛正虚脏气损伤，病必难治。

实脉有真假之辨，必参之以证，如见真实热脉，必久按不衰，证必见声音洪亮、面赤、舌红苔黄而燥，口渴饮冷；反之，假实脉则声、色、舌症不相应。景岳说：“虚实之要，莫逃乎脉，如脉真有力，真有神者方是真实证；脉似有力，似有神者，便是假实证。久病孤阳外脱，脉必先见弦数滑实。真阴大亏，燎原日炽脉见关格若实。”实脉真假全在重按沉部分辨，重按不减为真实证；浮取实大，重按有空虚感者为假实证。

10. 牢脉

定义 脉来有沉、弦、实之象为牢脉。

形状 脉在沉部，按之指下如有一横木，挺长而坚实不移。经曰：寸口脉沉而横^[3]曰胁下有积也。

机理 牢脉为阴寒凝聚之象，邪结于里，病邪内侵，如囚禁于牢中，深藏于内。

主病 牢脉为阴脉，主实证，为坚积和疝瘕，又主寒疝、气结。周学海说：“牢脉有气分、血分之辨。在血分者为症瘕、积聚，有形之痞块，饮食寒冷之停滞，与夫久受寒湿，侵入筋骨者也。在气分者，即肝

肾冷气为疝，少腹引腰控睾^[4]也；其轻者，为胸腹气结，呼吸不畅也。”凡失血阴亏之人反见牢脉，是正虚邪盛，正不胜邪，脉无胃气的表现；为真脏脉，预后不良。

（四）以脉来流利与否分

滑脉——涩脉

区别要点：脉来流利为滑脉；脉来艰涩不畅为涩脉。

11. 滑脉

定义 脉往来流利为滑脉。

形状 滑脉来，流利圆滑如盘滚珠、漉漉欲脱。另有一种虚滑脉，脉体散大，往来流利漉漉欲脱。以脉来有峰其形圆利如珠为实；脉来无峰呈片状散大而数，漉漉欲脱为虚。

机理 滑脉其实者为阴气凝聚阳气不衰之象，故经曰：“滑者阴气有余”主痰、主宿食；阴血受风邪鼓动脉亦见滑，故经曰：“滑者曰风”；病在外与新病之人，血方盛气不衰，加上病邪鼓动，脉多见滑，故经曰：“脉盛滑而坚者曰病在外，脉浮滑而疾者谓之新病。”

虚滑脉多为精血亏虚，阳气偏旺，阴阳不相配，阴不足故脉无峰，阳偏胜故脉来数而欲脱。

主病 滑脉为阳脉，主病为痰，为吐逆，为胃热，

为宿食，为尿血，为痰湿闭经，为孕等等。滑脉以其所在部位与兼脉的不同，其属性有别，主病不同。浮滑为阳，沉滑为阴；寸滑为阳，尺滑属阴，然必兼迟数。滑而兼浮为风、为热、为痰火，主病在外；滑而沉者主痰、主饮、主宿食，又主孕。虚滑脉主精亏血少，虚热之象。滑而沉数多为热结，或胃实吐逆。滑而兼缓多为内热，滑而兼紧多为伤食吐泄，浮滑而散多为瘫痪。三部脉中，寸滑病在心肺上焦，多为痰火风热；关滑病在脾胃多为伤食吐逆；尺滑病在下焦肾与膀胱，多为淋浊癃闭。

12. 涩脉

定义 脉来艰涩不利为涩脉。

形状 涩脉来如手捻沙，如轻刀刮竹。脉搏由许多微小波构成，如细小的砂粒又象细小的锯齿一样。

机理 经曰：“涩者阳气有余”是涩而兼浮大之脉，为阳邪被寒所束，气血不畅，正邪相搏，脉来盛大而不流利，故主外，为阳气有余。又曰：“涩则气虚”是阳气虚弱，鼓动无力，脉来不畅，必沉而细涩无力。又曰：“涩则心痛”，“涩则为痹”是血瘀，痛则不通，心脉痹阻血行不畅而为痹，为心痛，必沉细涩有力。

主病 涩脉属阴脉。涩脉主病为寒中，为气滞血瘀，为血痹心痛，为气血亏虚，为血虚肠燥，为淋……

等等。根据兼脉的不同主病各异：沉涩多主血瘀，沉细涩无力多为阳气不足气血虚弱，浮大而涩为寒邪外束表证发热，沉紧而涩多为过服寒凉药物所致。丹溪说：“脉涩而盛大，外怕寒，证为寒中，寒留于血脉，脉泣故大也”。涩而坚大为有实热，涩而虚软为虚火炎上，浮细而涩为汗多亡阳，涩而兼弦为气滞血瘀。

（五）以脉体长短区分

长脉——短脉（附：动脉）

区别要点：脉体长度超过本部为长脉；脉体长度不足本部为短脉；脉体更短，其形如豆动摇不宁为动脉。

13. 长脉

定义 脉体长度超过本部为长脉。

形状 脉来直上直下，超过本部，甚至通贯三部如循长竿为长脉。

机理 长脉是气血旺盛的脉象，经曰：“长则气治”。阳气偏盛，气火鼓动脉来长而实满，为病脉。

主病 长脉属阳脉，为有余之脉，主病为气逆火盛，为阳明热盛，阳毒癫狂，为肝阳上亢，肝热脓痛，为少腹胀满，尿赤淋痛等等。

长而和缓之脉多见于气血旺盛身体健康之人，长而实满之脉见于阳邪为患的疾病中，主热盛。经曰，脉

来中手长过于尺者，是阳盛于下，曰足胫痛；脉来中手长过于寸，出鱼际者是阳盛于上，为气逆喘急曰肩背痛。长而兼浮者邪盛在外，长而兼实为热邪壅滞，长而洪大阳明热盛，长而兼滑多为酒食所伤，长而弦紧多为肝病或主腹痛。老年人脉多长而弦，按之觉硬，如按葛藤为动脉硬化。

14. 短脉

定义 脉体长度不足本部为短脉。

形状 二头无脉，中间有脉不足本部，为短脉。

机理 短脉为元气不足之象，经曰：“短则气病”。气属阳，主乎鼓动，气衰鼓动无力则脉见短拙。若痰食郁滞，胃气阻塞，中气不能畅达也多见短脉，然必短而实按之不衰。

主病 短脉属阴脉，主元气虚损，为心悸气短，头晕目眩，脾虚食少，中气不足，或为痰食郁阻等证。

短而实滑者多为宿食，短而滑数者多伤于酒，短而搏指有力多为虚中夹实，短而沉涩为气虚寒。短而无力多为中气虚。

15. 动脉

定义 脉体比短脉更短而兼滑数者为动脉。

形状 脉来其形如豆，厥厥而动^[5]者为动脉。仲景曰：“若数脉见于关上，上下无头尾，如豆大厥厥动摇

者，名曰动也。”

机理 动脉为阴阳相搏气血不和之象。《伤寒论·辨脉法》说：“阴阳相搏名曰动”，王泰宇曰：“阳升阴降，二者交通，上下往来于尺寸之内，方且冲和安静，焉睹所谓动哉！惟夫阳欲降而阴逆之，阴欲升而阳逆之，两者相搏不得上下，来鼓之势陇然高起而动脉之形著矣。”惊则气乱，阳气受惊扰，血被鼓动脉来见动。

主病 动脉为阴中之阳脉。动脉主病有阴阳、虚实之分。脉来短而有力兼有滑数之象为实证，为邪气干扰气血不和之象。主病：为邪热、气郁、惊恐、诸痛又主孕。脉来动而无力为虚证，为久病气血虚弱阴阳不调，气血不和之象。主病为虚劳、亡精、失血、泻利等证。

寸脉为阳，尺脉为阴。仲景云：“阳动则汗出，阴动则发热。”成无己曰：“阴阳相搏而虚者动，故阳虚则阳动，阴虚则阴动。此关前为阳主汗出，关后为阴，主发热”。经曰，手少阴动甚谓之有子。

动脉兼弱者为惊悸及诸虚，动而兼涩有力者为肝郁气滞，血行不畅，动而数大突然发作者多为大惊之后。

（六）以脉体宽度区分

洪脉——细脉

区别要点：脉体宽大，上下起伏较大为洪脉；脉体细小而直起伏较小为细脉。

16. 洪脉

定义 脉来盛大为洪脉。经曰，来盛去衰曰洪。

形状 脉体宽大，上下起伏较大，状如洪水波涛为洪脉。

机理 洪脉为阳邪鸱张，邪火亢盛鼓动气血形成洪脉。洪脉也是夏季的主时脉象。经言，夏心脉洪，是盛夏阳气旺盛脉来鼓动有力，上下起伏较大，故见洪脉。然，必是洪而不坚有柔和之象方为正常；洪而坚搏指有力为阳邪为患，为太过之脉。

主病 洪脉为阳脉，主热病，证见腹满，烦渴狂躁、斑疹、头痛、疮疡、吐血、便血等。伤寒阳明经病白虎汤证，脉见洪大。

浮洪有力为表热实证，浮洪无力为虚火，沉洪有力为实火，洪大为气盛火亢，浮洪而长为风眩癫狂，洪紧为痈疽或肺热喘急。

17. 细脉

定义 脉体细小而直，起伏较小，软弱无力为细脉。

形状 脉来如线按之不绝，浮沉皆有如丝不断为细脉。

机理 细脉为不足之脉，为气血两虚之象。阴血亏少，元气虚弱，脉体不充又鼓动乏力，故见细脉。或为湿邪，瘀血阻滞脉道，脉来见细。

主病 细脉为不足之脉，主病为怔忡不寐，咳逆气怯，肝虚胁痛，胃虚胀满，梦遗腰痛等诸般虚损。细脉主病有气血、寒热之分，阴阳表里之别。细而兼数者为阴虚内热，细而兼迟者为阳气虚为虚寒，细而兼缓者为湿痹，细而兼涩者，其有力为血瘀，无力为气虚。浮细而软为濡，主湿邪在表，又主气阴两虚；沉而细软为弱，主气血阴阳俱不足。诸般虚损，脉多见细。

（七）弦直脉，从搏动力度和幅度上分

弦脉——紧脉

区别要点：脉体端直而长，起伏较小为弦脉；脉体端直而长，起伏较大搏动有力为紧脉。

18. 弦脉

定义 脉来长而且直，按之不移^[6]为弦脉。

形状 脉体端直且细长，脉来搏动起伏不大，如按琴弦。

机理 经曰：春脉弦，肝脉亦弦，然必弦而柔和方为正常脉象。所谓揭揭招招如揭长竿末梢^[7]即是对弦而柔和脉象的恰当比喻。春季弦脉太过与不足均主

肝病。春天阳气上升，阴气下降，一阳出于二阴之中，阳气虽升，阴气尚重，天气犹寒，故其脉弦。脉遇寒，遇痛脉管收缩，变直变细其脉亦弦。饮邪为患，脉道受阻其脉多弦。

主病 弦脉为阴中之阳脉。弦脉主病有虚、实，寒、热之分，单手、双手之别，尺寸、阴阳之异。除有时为肝本脏自病外，又主寒、主痛、主痰饮，为虐，为拘急，为胁痛为症瘕，为脾虚肝旺，为虚劳，为脏气损伤等等。

寸为阳，尺属阴；阳弦头痛，阴弦腹痛。弦脉主寒、主饮。单弦饮僻^[8]，双弦固冷^[9]。仲景说，虐脉自弦，弦数者热，弦迟者寒。伤寒少阳证，其脉弦。久病脉弦小者为脏气损伤，为难治。

弦而兼浮者为肝阳偏盛，或为支饮；弦而兼沉者多为肝郁气滞，或为悬饮；弦而洪数为阳盛，主热症；弦而兼细兼沉为阴盛，主寒症；弦大无力主虚证；弦紧为寒疝腹痛，弦细而数为阴虚火旺，沉细而弦为阴虚阳亢，弦细而急为肝的真脏脉。

19. 紧脉

定义 脉来紧张有力，有弦、长而数之意为紧脉。

形状 脉来紧张有力，如绷紧的绳索，时珍曰，左右弹跳如拧绳。

机理 紧脉为阴阳相搏，阴凝阳争之脉。寒邪中人正邪交争，脉来急数有力如绷紧的绳索。

主病 紧脉属阴脉。紧脉主病为寒，为痛，为寒饮，为宿食，为疝瘕少腹痛等。紧脉有阴阳寒热之分，浮沉表里之辨。仲景云：“紧脉从何而来？师曰假令亡汗，若吐，以肺里寒故令脉紧；假令咳者，坐饮冷水故令脉紧也；假令下利者，以胃中虚冷故令脉紧也。”此为阳气虚，又感寒邪故脉沉紧。脉浮而紧多主表寒，亦主表寒里热，《伤寒论》38条“太阳病，脉浮紧，发热恶寒，身痛疼不汗出而烦躁者，大青龙汤主之。”即为表寒里热证。杂病中紧脉又主痼病与宿食，《金匱·痼湿喝》篇曰：“夫痼脉，按之紧如弦，直上下行。”《金匱·腹满、寒疝、宿食病脉证治》篇曰：“脉紧，如转索无常者，有宿食不化也。”

紧脉兼浮者多为风寒在表，为阳郁之象；兼沉者为寒伤于里，主寒、主痛。紧而迟者为寒；紧而数者为热或为伤寒；紧而滑者为宿食吐逆；紧而涩者为气血郁结。

（八）空虚脉分

芤脉——革脉

区别要点：两脉均为中空脉，脉来浮大两边有脉，中间无脉为芤脉；浮弦而紧按之中空为革脉。

20. 芤脉

定义 脉来浮大两边有脉，中间无脉为芤脉。

形状 芤脉浮大中空，两边俱有中央独空，时珍曰，浮大中空如按慈葱。

对两边有脉中央空的理解，许多人从竖看，以尺侧、挠侧为两边。王叔和说：“芤脉浮大而软，按之中央空两边实”另一种从横向看，以浮沉为两边，中取为中间。浮沉皆有中取空虚无脉。《脉诀汇辨》说：“芤乃草名，绝类慈葱，浮沉俱有中候独空。”。临症中此种脉多见于精血亏少之人，非失血之人所独有。（作者素体虚弱在40~45岁间，每劳则升阳头面热，急行则喘喝，平时则腰痛乏力，便是此种脉象）。我以为，对中空与两边独有的理解不必死扣字眼，只要是浮大脉按之有虚软中空的感觉就是芤脉，不必一定要“两边有中间无”。死扣字眼则反而不知何为芤脉了，难怪一些知名的医家也曾说过平生未见有芤象者。

机理 失血之人，血脉空虚而气偏胜，血亏于里气脱于外，故脉来浮大按之空虚。精血弱之人阴虚于内，气浮于外，根气仍在，故浮取有脉中取不见，沉部仍有脉。

主病 芤脉为阳中之阴脉，芤脉为孤阳脱阴之候，其症必见低热、头昏、心悸、喘急、多汗、失血、失

精等证。

芤而兼浮多为出血；芤而兼涩多为因瘀失血；芤而兼迟为亡血失精，大虚寒证；芤而兼数、兼虚为阴血两虚，必发热；芤而兼弦为革脉，亡精失血；芤而兼紧兼数多见于肠痈酿脓期，芤而兼虚多见于肠痈溃脓期。

大出血之时，由于邪气方盛并不一定见芤脉，数小时至一二天后脉才显出芤象。

21. 革脉

定义 革脉为浮大弦长而紧，按之中空之脉。

形状 浮取弦长大而紧，按之中空无物，如按鼓皮。

机理 素体精血内虚之人又新感寒邪，寒邪束表，脉管紧缩，机体抗邪于外，故脉来浮取弦紧，按之空虚。或为亡精失血之后，精血亏虚寒自内生，阴不敛阳，孤阳夹寒浮越于外出现革脉。一些老年人动脉硬化又阴血不足也见革脉，此人易患中风。

主病 革脉为阳中之阴脉，主亡血、失精、半产^[10]、漏下、中风等证。

（九）虚脉中以脉体宽度区分

微脉——散脉

区别要点：两脉均为虚脉类，脉来无力不胜重按。

比细脉更细，似有似无为微脉；脉体浮大无峰，按之顿衰，重取绝无为散脉，微脉细如蛛丝，散脉浮散而大。

22. 微脉

定义 比细脉更细弱，若有若无为微脉。

形状 脉如蛛丝，极细极弱，按之欲绝，若有若无。

机理 细则血少，微则气衰，阴血亏虚，阳气衰弱无力鼓动，脉来见微。仲景云：“萦萦如蛛丝者阳气衰也。”多见于亡阴、亡阳气血衰败之证。

主病 微脉为阴脉。微脉主病为衄血，为自汗畏寒，为阴虚盗汗，为呕逆不食，泄利完谷，为亡阴亡阳，为拘急筋挛，为寒中少气，为崩中带下等诸般虚损。《伤寒论》286条：“少阴病，脉微不可发汗，亡阳故也”以其阳气微弱不可再伤其阳，故不可发汗。又如317条：“少阴病，下利清谷，里寒外热，手足厥逆脉微欲绝，身反不恶寒，其人面色赤，此为阴盛于内，格阳于外，内真寒外假热，白通汤主之，破阴回阳，宣通上下。”

微脉主病为气血阴阳俱虚，然而在四者中以元阳亏损阴寒之证最甚。因此，其主病多为阳虚寒证。寸部见之多为心肺阳虚，胸阳不振，或因气虚气不摄血

而见衄血，惊悸、喘逆。关部见之为胃寒吐逆，食不化或肝寒筋脉拘急。尺部见之，为肾阴虚髓竭精伤，盗汗发热；肾阳虚崩中带下，脏寒下利，脐下冷痛等等。

其寸脉微偏于阳不足，必恶寒；尺脉微而沉者，偏于阴不足，必发热；偏于阳虚者，脏寒下利。其微而兼数者多为阴亏，微而兼迟者阳衰大寒。

23. 散脉

定义 脉来浮大无峰无根，两边界限不清为散脉。

形状 浮取似有，按之顿衰，重取绝无，脉体散大如风吹扬花散漫不收。

机理 散脉为无根之脉，肾脉本沉有根，今浮散无根为肾气衰败，元气离散。仲景云：“漈漈如羹上肥者^[11]，阳气微也。”

散脉又为秋季肺的季脏脉象。由于秋季在暑热发散之后，此时人体阴津不足加上阴气初升，阳气已虚，（比夏季明显不足），故脉虽浮而软散无力，沉部明显空虚。

《内经》中散脉有两种含义：一是指浮大而有柔和之象的脉，为秋季肺脉的正常脉象。戴同父说，心脉浮大而散，肺脉短涩而散，皆平脉也，即是此意。另一种指浮大无根的病脉，是散脉的本意。经曰：心脉软散为怔忡，肺脉软散为汗出，肝脉软散为溢饮^[12]，脾

脉软散为骭肿^[13]，皆病脉。

主病 散脉属阴脉，主病为怔忡、自汗，为胀满，为益饮，为肾虚精枯髓竭。散脉既主阴虚血弱，又主阳虚。在寸者多为心肺阳虚，在尺者多为阴虚阳浮。久病见之多为肾气败绝，阴阳离绝之象，其病必阴血耗竭在前，阳气将绝在后，阴亏已极阳无所附，浮越在外，主病危。

散脉兼滑者多为中风瘫痪，兼沉者寒食成瘕，兼弦者为消渴、浸淫。

（十）细软脉从浮沉上分

濡脉——弱脉

区分要点：二脉均为细软无力脉，浮而细软为濡脉，沉而细软为弱脉。

24. 濡脉

定义 浮而细软为濡脉。

形状 脉来浮细无力，如线浮水上，轻手可见，按之软散。

机理 元气衰阳气鼓动不足，阴分亏耗脉内空虚，故浮取细软，按之无力。或外伤暑湿，湿伤阳气，脉道不畅，脉来濡细。或脾肾两虚，内湿停聚，阳气虚衰脉来细软无力。

主病 濡脉属阴脉，主病为气弱、自汗，为气血

虚少，为痹，为湿，为肿胀里水，为下元虚冷，为精伤髓枯。濡脉主阳虚又主阴虚；主虚证，又主湿证。寸脉濡多为阳虚，尺脉濡多属阴虚。其兼数者为阴虚，兼迟者为阳虚；外感暑湿，与湿痹脉多见濡为本虚标实证，其证见身热不扬，头痛头闷，身困重疼痛，舌苔白腻，大便溏泻等；里水胀满属脾肾阳虚。

25. 弱脉

定义 沉而细软为弱脉。

形状 脉来沉而柔细软，按之乃得。

机理 弱脉，为气血阴阳俱虚。阳气衰不能鼓动于外，故脉来沉而无力；阴血亏虚脉道不充，故脉见细而软。或为湿邪阻遏脉道，脉来不畅而见沉细软脉。

主病 弱脉属阴脉。弱脉主病为虚劳、血痹、湿痹、自汗、久嗽、失血、遗精盗汗又主脾胃虚弱。

寸脉弱属阳虚，卫外不固，气短自汗，心悸怔忡，自汗久咳。尺脉弱则肾气虚，腰酸腿疼，遗精盗汗，妇女则月经不调。关脉弱则脾胃虚弱，食少、便溏不能运化腐熟，或肝血不足头晕眼花，失眠多梦等。

弱脉兼数则阴虚内热，兼迟则阳虚外寒，弱而小则阳竭，弱而涩则气血交败，弱而微则阳虚阴寒盛，弱而兼滑则虚中夹实多为下利。

（十一）竭止脉以迟数分

促脉——结脉（附：代脉）

区别要点：三脉均为脉来动中有止，脉来急数，时一止为促脉；脉来缓而时一止，止无定数，中有小动复来者为结脉；脉来迟，时一止，止有定数为代脉。

26. 促脉

定义 脉来急数而时一止复来为促脉。《内经》所言的促脉，指寸脉出现急数而滑，欲上鱼际的脉象为促脉，如《平人氣象论》曰：“寸口脉中手促上击者，曰肩背痛。”于此有别。

机理 促脉为阳邪盛而有郁之脉。阳盛阴必不足，虽为邪盛内必有滞，或为血瘀，或为气滞，或因食塞，或为停痰，或为外感六淫之气，阻遏气机，先以热胜脉数，又因五者有一留滞其间，如人急行有物拌足时一止象。伤寒表证误下伤阳，阳气下陷郁而不达而见促脉。《伤寒论》21条：“太阳病，下之后脉促胸满者，桂枝去芍药汤主之。”亦有真气衰惫阴阳欲竭而见促脉者。

主病 促脉为阳脉，主邪火亢盛，热毒炽盛，发斑、癫狂、疮疡或为宿食停滞，痰气郁结，或为相火旺遗精滑泄，亦主虚脱。止数渐稀脉来转缓为病转愈，止数渐增脉更加急数为病转剧。

促脉兼洪实者为热盛，兼滑者多为肺热痰盛，兼

沉涩者多为气血郁滞，兼细数无力者为阴竭阳欲脱。

27. 结脉

定义 脉来缓，时一止，中有小动复来者，为结脉。

机理 结脉为阴寒凝聚之脉，阴邪凝聚阻滞气机，血脉运行不畅，先以气寒脉缓，又有气、血、痰、食六淫之邪留滞其间阻碍气机，经脉传导滞塞不畅而现结脉。亦有气血渐衰精力不继而见结脉。《景岳全书·脉神章》说：“结者为寒，为阴极，结脉多由血气渐衰精力不继，所以断而复续。常见久病者有之，虚劳者多有之，或误用攻击消伐者亦有之。”

主病 结脉属阴脉，结脉主病为停痰积饮，为气郁血滞，为疼痛，为积滞不化，为症瘕，或为气血衰败。结脉主虚证，亦主实证，脉来结而有力主实证，为邪聚阳郁；结而无力为虚为元气衰败。老年人气血衰弱无病时也可见到结脉，此为形与脉相应。久病见结脉多为气血衰弱之象。浮而结者为寒邪滞表，沉而结脉来有力为积气在内，缓而结者为阳虚，沉而结无力者为阳气衰败。

28. 代脉

定义 代脉有二种，一为脉来迟滞动中有止，止有定数不能自还，良久复动为代脉；其二为脉律紊乱，

乍数乍疏没有规律亦为代脉。凡脉律不整，除促脉、结脉外均可归为代脉。

机理 代脉为阴脉，为心气衰败，脾气脱绝之候。经曰，代则气衰，气血衰败元神不能接续而出现代脉。其脉止竭不匀者病轻，其脉动中止竭有常，或一、二次一代，或三四次一代者为心气衰败不能维系自身的阴阳平衡，病情严重。亦有因气血郁滞，疼痛之极气机郁而不达出现代脉，主病为实。

《内经》中代脉的含意有多种：

1. 以软弱之脉为代脉，为脾胃的正常脉象。《宣明五气篇》曰：“脾脉代”，《邪气脏腑病形篇》曰：“色黄者其脉代”，《平人氣象论》曰：“长夏胃微软弱曰平，弱多胃少曰脾病，但代无胃曰死，软弱有石曰冬病。”即是此意。

2. 脾主四季，其脉随时更代。凡脉无定候随时更代谓之代。《宣明五气篇》曰：“脾脉代”是说脾在五脏中独不主时，各寄旺于每季末 18 日，其脉亦无定候随季而变，故曰脾脉代。

3. 脉以止竭为代，《脉要精微论》曰：“数动一代者”就是以止为代。仲景在《内经》的基础上以脉来迟，时一止，止有常数不能自还，良久复动为代脉，后世医家遵之。

主病：代脉属阴脉。代脉多主虚证亦有实证。

代脉来有力，止无定数，主实证，为七情太过或跌打损伤，或为痛极一时，或为妊娠恶阻……。主实证时，除脉来有力止无定数之外兼见形气不衰。代脉来虚弱无力，止有定数兼见形气衰败，行动维艰为虚，多见于久病之人，为心气衰败脾气脱绝，为恶候。常人见之必为难治。

二、类比法

把在某一方面具有相同属性的几种脉象进行归类，通过相互比较研究的方法，叫作类比法。如：浮脉类，沉脉类，虚脉类，实脉类，长脉类，短脉类，间歇脉类等。通过同一类脉的相互比较，可以更好的了解和掌握各种脉象的特点，以便区别各种类似脉象。

1. 浮脉类：浮、洪、虚、濡、散、革、芤七脉皆浮。

区别要点：脉在上部为浮脉；浮而盛大为洪脉；浮大无力为虚脉；浮而细软为濡脉；浮而散大无根无峰为散脉；浮大中空为芤脉；浮弦而紧，按之中空为革脉。

虚脉、濡脉、散脉均为浮脉中的虚脉，均见脉来

无力。然，虚脉浮大无力；濡脉浮细软无力；散脉浮而散大无力。

革脉、芤脉同为浮脉，又同为中空之脉。革脉浮紧，按之中空；芤脉浮大，中取独空。

2. 沉脉类：沉、弱、牢、伏四脉皆沉。

区别要点：脉在沉部按之方见为沉脉，沉而细软无力为弱脉，沉弦长而有力，按之实坚为牢脉，脉在最下部必重按至筋骨乃得为伏脉。

3. 长脉类：长、弦、紧、牢、革五脉皆长。

区别要点：脉体长度超过本部端直而长为长脉；脉细而长，按之不移（脉起伏幅度小）为弦脉，脉长弦而有力（脉起伏幅度较大）兼有数意为紧脉；脉沉长而实为牢脉；脉弦长浮紧，按之中空为革脉。

4. 短脉类：短与动二脉皆短。

区别要点：脉体长度不足本部为短脉；动脉脉体更短，其形如豆，更兼滑数为动脉。

5. 虚脉类：濡、弱、虚、细、微、芤、革、散皆为虚脉。

区别要点：脉来浮大无力为虚脉；浮而细软无力为濡脉；沉而细软无力为弱脉；脉细如丝不断为细脉；比细脉更细按之欲绝为微脉；浮大中空为芤脉；浮大弦长而紧，按之中空为革脉；浮大无根无峰为散脉。

濡、弱、细三脉均为虚脉中的细软脉。浮而细软为濡脉，沉而细软为弱脉，浮沉均有如丝不断为细脉。

6. 实脉类：实、洪、紧、长、牢五脉皆实。

区别要点：脉来有力，按之不衰为实脉；脉浮而盛大为洪脉，脉来弦长有力，兼有数意为紧脉；脉体长度超过本部为长脉；沉长而实为牢脉。

7. 迟脉类：迟、缓、结三脉皆迟。

区别要点：脉来一息四至为缓脉；脉来一息四至以下为迟脉；脉来缓而时一止，复来者为结脉。

8. 数脉类：数、疾、促三脉皆数。

区别要点：脉来一息五至以上为数脉；比数脉更快一息七至、八至为疾脉；脉来数而时一止为促脉。

9. 间竭脉类：促、结、代三脉，皆脉来中有止竭。

区别要点：脉来数而时一止为促脉；脉来缓而时一止复动为结脉；脉来迟而时一止，止有定数不能自还，良久复动为代脉。（脉来乍数乍疏没有定律亦为代脉）

三、单脉、复合脉、兼脉的意义

单脉，为构成复合脉的元素。此种脉理论上可以单独存在，实际上并不能单独出现，必兼合其他脉象，

这就是单脉。如：浮脉、沉脉、迟脉、数脉、虚脉、实脉……等等。以浮脉为例，浮脉只表示脉在上部不在下部。它表明了脉所在的位置，而脉的至数和力量并没有表明，没有力量大小和至数多少的单纯浮脉实际上是不存在的。

由两种或两种以上的单脉所组成的脉象叫作复脉。如，浮而细软为濡脉，沉而细软为弱脉，沉弦而实为牢脉，浮弦而紧按之中为革脉等等。复合脉所代表的意义一般是由构成它的几种单脉所代表意义的总合。如弱脉由沉脉、细软脉组成，沉脉为病在内或为气虚，细软脉为阴血虚，两者相结合即为气血两虚。

相兼脉，指主脉中包含有几种不同意义的单脉。表示脉的部位在浮部还是沉部，脉跳动的次数是迟还是数，脉的力量是有力还是无力……。兼脉所代表的意义，除主脉所表示的意义外，一般兼浮者病多在表，兼沉者病多在里，兼数者病多为热，兼迟者病多属寒，兼实者病多是实证，兼虚者病多是虚证。所兼何脉，即以其脉主病相加。

四、辨脉提纲

经曰：“察色按脉，先别阴阳。”阴阳是宇宙间一

切事物都具有的相负相承的两种属性，是衡量万事万物属性的总纲。《素问·阴阳应象大论》曰“阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也，故治病必求于本。”阴阳也是辨脉的纲领，掌握了这个纲领即掌握了辨脉的大方向。大方向不错，临症中就不会犯大的错误。《阴阳别论》曰：“所谓阴阳者，去者为阴，至者为阳；静者为阴，动者为阳；迟者为阴，数者为阳。”按照这一原则，一些医家提出几种具有代表性的脉象作为纲脉，进行归类，从而在判断病性、病位上可以提纲挈领，执简驭繁，做到事半功倍的效果。古人提出了不同的分类纲脉。《内经》以大、小、滑、涩、缓、急六脉为纲。《灵枢·邪气脏腑病形篇》曰：“调其脉之缓急、大小、滑涩而病变定矣。”《难经》以浮沉、长短、滑涩为纲。仲景以弦、紧、浮、沉、滑、涩为纲脉，曰，此六者名为残贼^[14]，能为诸脉作病。后世医家各有所宗。我以为浮、沉、迟、数、虚、实可作为辨脉纲领，而长、短、滑、涩不足以为纲，因它们在判断病性、病位上难以明确。前六脉可以明确的表示出病性和病位，是每一种脉都不可缺少的六种因素。

浮、沉：表示脉的深浅，定病位：表、里。

迟、数：表示脉的至数，定病性：寒、热。

虚、实：表示脉的力量，定病性：虚证、实证。

总括起来浮、数、实为阳；沉、迟、虚为阴，阴阳之脉虽不明列而实寓于其中。

《内经》中提出 50 余种脉象，由于脉的名称多，出现了一脉数名或数脉一名。《难经》归纳为 30 余种，仲景又补入了芤、革等脉，后世在前人基础上归纳为二十八脉：浮、沉、迟、数、虚、实、滑、涩、弦、紧、长、短、动、洪、疾、细、濡、微、散、弱、缓、芤、革、牢、伏、促、结、代。（有人把疾脉归入数脉，缓脉归入迟脉出现 27 脉、26 脉、24 脉等不同的分法。）学习掌握各种脉象，练好基本功，是学好中医的基础。

五、脉有常、变，证有真、假，法有

取、舍

脉有常有变，掌握其常，了解其变，不失万全。浮、数、洪、长、实为阳脉，阳脉现阳症为其常，阴症现阳脉为其变。症本为阴，脉不沉、迟、细、微反见浮、大之脉，此为阴邪过盛格阳于外，出现假象。同样道理，沉、迟、虚、细、短、微为阴脉，主病阳气衰病

在里。阴脉现阴症为其常，阴脉现阳症为其变。有时表证阳气被寒邪所遏，阳郁于内不得发越，虽为表证而见沉脉；有时阳明腑实，邪结于里，阳郁而不达，脉不数而反迟。不可以为表证脉不浮为邪不在表而不予发汗解表；亦不可以为阳明腑实，脉不数而反迟为非热症而不用承气汤以攻里。

临症中并非脉与证都完全一致的反映病变的真实情况，脉有真假，证亦有真假。本为热证而现寒象，本是寒证而现热象；虚证而现实脉，实证而现虚脉；阳证见阴脉，阴证见阳脉。只有在脉证合参的基础上，认真辨别真假，才能正确地运用取舍。如脉的一方反映的是真实情况，当舍证从脉；反之，证的一方反映的是真实情况，当舍脉从证。必须指出的是这种脉证不一的情况，并非是普遍现象。当出现这种情况时，应当从病因、病机上推求产生这一现象的机理，认真辨别真假，然后取舍才不失误，不可在未搞清楚前就早下结论，言脉证不附。

六、脉有初按、久按，浮取、沉取不同

脉有初按虚软无力，久按搏指而实者；有初按弦硬，久按而有柔和之象者；又有初按浮大，久按细小

无力者，凡此种临床上都有一定的实际意义。

《诊宗三昧》问初诊，久按不同说：“夫诊察客邪^[15]，暴病，应指浮象可证，若诊虚羸久病，当以根气为本（指久按）。……下指濡软，久按搏指者，里病表和之象也，非脏气受伤，则坚积内伏，不可以脉沉误于虚实也。下指脉弦，按久和缓者，久病向安之象，气血虽殆，而脏气未败也。然，多有变症多端而脉渐小弱，指下微和似有可愈之机者，此元气与病气俱脱，反无病之象，乃脉不应病之候，非小则病退之比。若下指和，按久微涩不能应指，或渐觉硬者必难取效。”

脉有浮取、沉取不同主病各异《难经·六难》曰：“脉有阴盛阳虚，阳盛阴虚，何谓也？然，浮之损小，沉之实大故曰阴盛阳虚；沉之损小，浮之实大，故曰阳盛阴虚，是阴阳虚实之意也。”《难经》所指的是一种脉象，它在浮沉之间均有脉搏，但在浮部表现明显，大而有力，沉部表现不足细小无力，此为阳盛而阴虚。脉在浮部细小无力，而在沉部实大有力，此为阴盛而阳虚。

临症中还有虚损之症，原本为虚弱无力之脉，服用益气温阳药后。脉转数转滑，久按仍显无力，症也未有明显变化者，此非病已转热转实，而是药力所致，不可以脉滑数就急于改弦易辙，反清其热伤其阳气，当

于温阳益气药中稍佐养阴之味继服以取效。

七、脉逆从阴阳

经曰：“脉从阴阳病易已，脉逆阴阳病难已。”所谓从阴阳者，以病邪性质论，阳病见阳脉，阴病见阴脉；按四时而论：春、夏为阳，秋、冬为阴，春、夏得阳脉，秋、冬得阴脉；从新病、久病而论：新病脉实，久病脉虚；从人体质上论：瘦人脉浮大，肥人脉沉小，均为顺，脉的表现与人体阴阳盛衰变化相一致，为从阴阳。从阴阳者虽病易愈。因脉所反映的是正气不衰，病邪不甚，正气抗邪有转愈的趋势。反之阳病见阴脉，阴病见阳脉；春、夏脉沉小，秋、冬脉浮大；新病脉虚，久病脉实；瘦人脉沉小，肥人脉浮大，均为逆阴阳。脉逆阴阳病难已。所谓逆阴阳者，脉本应大今反小，脉本应浮今反沉，脉与症相反，说明邪气盛而正气衰，正不能与邪相争，病情严重，故病难已。经曰：“反四时者，有余为精，不足为消，应太过不足为精，应不足有余为消，阴阳不相应病名曰关格。”经言，证有余脉当精强，证不足脉当消弱；证本应太过者脉当精强，反见不足之脉；证本应不足者脉当为消弱，反见有余之脉，脉的表现与疾病的阴阳盛衰表现

不一致，说明阴阳关闭不相交通，相互格拒而不相融和，病名为关格。此处“关格”为病理名词，非指上吐逆，下二便不通的关格病。

八、以脉、色断病新久及预后

从脉的表现上可以推断出新病、久病。疾病的发展变化过程一般是由表及里，由实到虚，由阳证到阴证。所谓新病多实，久病多虚；新病多在表，久病多入里；新病脉现浮盛大，久病脉多沉、细、虚。正如经言：“脉小弱以涩者谓之久病，脉浮滑而疾者谓之新病。”

色为五脏精华在面部的表现。当人体无病时，元气充沛，五脏精强，其光华外现，色当隐而不露且有光泽，如缞裹朱^[16]。新病，气血未伤，元气尚盛，色泽变化不大。久病必伤气血，气血衰，五脏失养则五色外显且失光泽。经曰：“征其脉小色不夺者新病，征其脉不夺色夺者，此久病也；征其脉与色俱夺者，此久病也；征其脉与色俱不夺者，新病也。”色与脉相比，色随气血变化慢，必待病情达到一定的程度始能表现出来，而脉随气血变化快，一有变化即刻反映出来。因此脉与色合参在断病新久方面，久病以色为主，新病

以脉为主。色夺者脉必夺，色不夺者脉未必不夺。所谓色夺者即五脏病色外显，且失去光泽。《内经·五脏生成篇》曰：“五脏之气，故色见青如草兹^[17]者，死。黄如枳实者，死。黑如炁^[18]者，死。赤如衃血^[19]者，死。白如枯骨者，死。此五色之见死也。”

根据脉与证的表现来判断疾病的预后好坏又是脉诊的一大特点。一般讲有胃气、神气与根气的脉，虽病预后多良好，没有胃气的真脏脉预后不良。脉与证的表现本应如桴鼓^[20]相应，若两者表现不一往往是病情危重的征兆，多预后不良。

《内经》中对真脏脉见否，结合证状的表现作为预后的标准可作为参考。经文以症见大骨枯槁，大肉陷下^[21]，胸中气满，喘息不便，其动形气，预期6个月后死。如见真脏脉，预期短期内死。

除上述症状外再加上内痛引肩项^[22]，身热脱肉、破腠^[23]，真脏脉见十日之内死。

如上述症状再加上目眶陷下，目不识人，立死。如脉绝不来，竭止如人呼吸五、六次长的时间即便是形肉不脱，真脏脉虽不见仍将死。

然而，脉虽似无病，但病人形肉已脱，脉与形不相应，九候虽调，犹死。

寸口脉皆沉细悬绝者，主病阴盛极阳衰竭，为极

阴证，与冬脉相应，非冬时见此脉为阳衰已极。夜半为阴盛阳衰之时，阴极阳衰之病，遇此时必加重病情，危者必死。脉盛躁喘数者为阳盛极，主时为夏，非其时见此脉为阳盛极，阴欲竭之象。日中为阳旺之时，阳盛极之病遇此时必加重病情，重者转危，危者必死。但也有不可以脉作预后的情况，如经言：“急虚（如大失血），身中卒至（突然发生的中恶），五脏绝闭（各种厥证），脉道不通（心脑血管卒中）气不往来，譬如坠溺，不可为期也。”

需要说明的是古人所说的“死”是在当时科学技术尚不发达，医疗条件不完善的情况下作出的判断，今天科学技术有了很大的发展，医学有了很大的进步，古人认为无法救治的病，许多病今天已不再成为难题。因此，对古人所说的“死”要一分为二看，其中一部分可能已到了非人力所能挽救的地步，而另一部分经过积极的救治尚可逆流挽舟重反健康。不可以因古人说“死”就不再积极治疗，而贻误病情。

注 释

〔1〕 举之有余：抬手为举，诊脉时抬起手，轻取脉来搏动有力。

[2] 戴阳：阴寒证出现的假热证，面红如妆，躁热，脉浮大无力等，为阴盛格阳于外。

[3] 沉而横：横，形容脉来应指如有一横木，即沉而弦紧，坚硬之脉——牢脉的形象比喻。

[4] 腰痛控睾：腰痛牵引睾丸作痛。

[5] 厥厥而动：动摇不定的样子。

[6] 按之不移：脉在沉部搏动，幅度小，似有不动的感觉。

[7] 揭揭招招如揭长竿末梢：指脉来弦长柔和就象高高举起长竿的末梢，上下摆动一样。

[8] 饮癖：病名，证见两胁间有积块，平时不见，痛时才觉，多为饮食失节，脾胃受伤疼痛结聚，气血搏结而成。

[9] 固冷：久积不愈的寒证。

[10] 半产：即小产，指胎儿已形成尚未足月的流产。

[11] 漈漈如羹上肥：如汤中漂浮着的油花一样。

[12] 溢饮：（见上篇 25 条）

[13] 骭肿：（见上篇 28 条）

[14] 残贼：指致病较强的病邪。

[15] 客邪：指外来的致病病邪。

[16] 如绶裹朱：好象用白绸子包裹着红色的东

西一样，白里透红。

[17] 草兹：兹通子，就是草仔。

[18] 炀：烟灰。

[19] 衄血：败坏凝聚之血，其色赤黑。

[20] 桴鼓：桴，指鼓槌。桴鼓：用鼓槌敲击鼓发出声音。

[21] 大肉陷下：大肉，指身体肌肉丰满之处。陷下，因消瘦而低陷。

[22] 内痛引肩项：胸内疼痛，牵引肩背。

[23] 脱肉、破腠：腠，指隆起的肌肉。脱肉破腠，指肌肉干瘦、消瘦的症状。

下 篇

四时五脏脉法及其应用

总 论

经曰：“察其腑脏，以知生死之期，必先知经脉^[1]，然后知病脉。”诊脉之始，首先要弄清何为正常脉象，才能区别病脉。不知正常脉象，何能辨别病脉？这是辨脉中至关重要的问题。五脏在寸口脉的正常脉象即为五脏四时之平脉，《内经》作专题讨论，言之甚详。然，经文深奥，后人不深解其意，将此至重大法格置一旁，作为点缀。后世论脉多以左寸心脉必洪大而散，右寸肺脉必浮涩而短，右关脾脉缓和，左关肝脉弦长，左尺肾脉沉石，右尺与心同断作为定论。^[2]与《内经》四时五脏脉法对立起来，将辨脉引入歧途，使人不知何

为五脏正常脉象。试问，既然寸、关、尺三部脉已成定论，何以又言春弦、夏洪、秋毛^[3]、冬石^[4]？定论之脉为四季中何季之脉？此乃前人读书不明，将四季五脏之脉统于一时，归于寸、关、尺三部。四季五脏之脉岂能同现于一时！经言，五脏之气不能自至于手太阴，必在胃气作用下，于各脏气旺盛的季节，借助自然界的旺气，才能分别到达寸口，表现在脉上。因此，所谓的定论之脉不攻自破。正常的五脏脉，当分季节不分三关，统言寸口脉。脉无定候，随季而转，要弦皆弦，要洪皆洪，要浮皆浮，要沉皆沉。寸关尺三部中，一部不应则该部所属的脏腑即病，二部不应则二部皆病，局部病变反映在局部，不应之部表现何种脉形，按此脉主病辨证；两手六脉皆不应，而现他季脏象之脉形，属五脏病者，按五行生克辨证，其他病按其脉主病辨证。此非泛泛空谈，乃为确实之论，君证之以《内经》，验之以临证，必明此理，特将此理阐明发扬已示后学。

一、四时五脏常脉

人是生活在自然界中，自然界阴阳盛衰变化，必然反映在脉搏上。经曰：“万物之外，六合^[5]之内，天

地之变，阴阳之应，彼春之暖，为夏之暑，彼秋之忿，为冬之怒，四变之动，脉与之上下……。阴阳有时与脉为期，期而相失，知脉所分，分之有期，故知死期。”

何谓常脉，五脏脉象分别出现在各自相应的季节里，如肝旺于春，春见肝脉；心旺于夏，夏见心脉；肺旺于秋，秋见肺脉；肾旺于冬，冬见肾脉。因各种脉象出现在自身所主脏气的季节里，故为其常。它不仅包括五脏无病时的平脉，还包括五脏自身发生病变时的病脉。其分述如下：

（一）四时五脏平脉

何为平脉？正常的脉象即为平脉，既有胃气又与自然界阴阳变化相应的脉象即是平脉。五脏分别旺于五季，每季与一脏气相通，冬季阳气潜藏阴气盛与肾气相通。春季阳气升发与肝气相通，夏季阳气旺盛与心气相通，长夏暑湿与脾气相通，秋季阳气收敛阴气始上燥气旺与肺气相通。因此，春脉弦，肝脉亦弦；夏脉洪，心脉亦洪；长夏脉缓，脾脉亦缓；秋脉毛（浮）肺脉亦毛；冬脉沉（石），肾脉亦沉。

五脏正常脉象的具体表现《素问·平人氣象论》曰：“夫平心脉来，累累如连珠^[6]，如循琅玕，曰心平，夏以胃气为本。”琅玕者，珠玉之类。循，触摸之意。景岳云：“脉来中手如连珠，如循琅玕者，言其盛满滑

利，即微勾之义。岐伯曰：“夏脉者心也，南方火也，万物之所盛长也，故其气来盛去衰，故曰钩^[7]，反此者病。”来盛去衰与浮大而散同意，即浮取盛大按之不足是洪大而柔和之脉。所谓勾者，以钩之弯形比喻洪脉之形状与连珠、琅玕同意。

夏季阳气旺盛，万物繁茂，心为阳脏，主全身血液运行与夏季同属于火。故，心气与夏季相通，洪脉为夏季心脉，它所表示的意义为阳气旺盛阴气衰弱。

“平脾脉来，和柔相离，如鸡践地曰脾平，长夏以胃气为本。”和柔相离如鸡践地者，以鸡践地比喻长夏脾脉从容轻柔的样子，即脾脉和缓软弱之意。长夏暑热当令，气候炎热，湿气盛，人体汗出津虚，因此，其脉软弱。长夏与脾气相通，同属于土，故，长夏脉即脾脉也。岐伯曰：“脾脉者土也，孤脏^[8]以灌四傍者也，其善者不可见，恶者可见。”脾属土，居中央以灌四傍，水谷精微的运化吸收，气血精液皆出于此，为后天之本，五脏六腑四肢百骸皆赖此以营养。脾胃正常其脉从容和缓，为有胃气的正常脉象，故不可见；脾胃病，脉现异常，故恶者可见。

“平肺脉来，厌厌聂聂，如落榆荚^[9]，曰肺平，秋以胃气为本。”落榆荚者，比喻秋脉轻虚而浮、短涩之象。脉来轻虚而浮有柔和之象，为肺之平脉。岐伯曰：

“秋脉者肺也，西方金也，万物之所收成也，故其气轻虚以浮，来急去散故曰浮，反此者病。”秋脉浮取有紧急之感，按之散漫不收，即毛而有胃之义。秋季气候由热转凉，阴气上升，阳气下降与肺气相通，肺与秋同属于金，故秋脉即肺脉，它所表示的意义为阴气上升，阳气下降，阴出阳入。

“平肾脉来，喘喘累累如钩，按之而坚，曰肾平，冬以胃气为本。”喘喘累累如钩^[10]，按之而坚，比喻脉来沉滑如水之园流，虽似心脉之钩形，但在沉部出现，按之沉而实滑，且有柔和之象。歧伯曰：“冬脉者肾也，北方水也，万物之所合藏也，故其气来也沉以转，故曰营^[11]（石），反此者病。”冬季阴寒凝冽，阳气潜藏，肾者属水，主藏五脏之精气与冬气相通，冬脉即肾脉也，它所代表的意义为阴气盛，阳气衰。

“平肝脉来，软弱招招，如揭长竿末梢，曰肝平，春以胃气为本。”正常的肝脉就象高举长竿的末梢，上下摆动一样，有弦长而柔和之象。歧伯曰：“春脉者肝也，东方木也，万物之所以始生也，故其气来软弱轻虚而滑，端直以长，故曰弦，反此者病。”春季阴气下降，阳气上升，阳出于阴。肝者属木，主升发条达与春同气，故春脉即肝脉也，它所表示的意义为阳气初升，阴气始降，阳出于阴。

五脏在四季旺时所见脉象已如前述，但四季脉的变化并非是跳跃式的，从冬时的沉脉一夜间就变成了春季的弦脉，而是脉随季节气候的变化逐渐变化的。四时之气旺于主位，微于始生，衰于变化。故，每季前之气必显上季气候特点，脉象亦必兼见上季脉形。《内经》引《脉要》^[12]文曰：“春不沉，夏不弦，冬不涩，秋不数是谓四塞。”所谓四塞即四时之气不相交通而闭塞。因此，初春之脉必弦中代沉，初夏之脉必洪中代弦，而春末之脉必弦中代洪，夏末之脉必洪中代软弱，以此类推。

四时五脏（正常脉象）平脉表解

分期 季节脉象	旺 时 (季中 2/4 日数)	季 初 (季前 1/4 日数)	季 末 (季末 1/4 日数)
春	弦脉 端直而长 轻虚以滑	弦兼沉	弦兼洪
夏	洪脉 浮大而散 来盛去衰	洪兼弦	洪兼软弱

(续上页表)

分期 季节 脉象	旺 时 (季中 2/4 日数)	季 初 (季前 1/4 日数)	季 末 (季末 1/4 日数)
长夏	软缓脉 从容和缓软弱	软弱兼洪	软弱兼毛
秋	毛脉 浮涩而短 来急去散	毛兼软弱	* 毛兼沉
冬	沉脉 沉以转 (滑)	沉兼毛	沉兼弦

说明:

1. 每季日数分为 4 份, 季初约占一份, 季末约占一份, 季中旺时约占 2 份。季初 1/4 时日必兼前季脉形, 季末 1/4 时日必兼下季脉形。

2. “季中”为四季的中间, 为每季气候特点最明显的时日, 春秋为二分前后; 冬夏为二至前后。但, 因夏季中又分夏与长夏两季, 故夏季、长夏, 只能按其

他季节的一半时日计算。

3. 五季的划分是以我国黄河中下游地区气候为准，其他地区可按当地的实际情况加以变通。

4. 转：即滑意。

5. 毛脉：即浮涩而短之脉，为秋季的正常脉象。

6. * 浮不能兼沉，毛脉与沉脉相合只能显露出毛脉中的短涩之象。

四时五脏平脉歌

五脏平脉，当分季节，脉无定候，随季转来。
要弦皆弦，要洪皆洪，要浮皆浮，要沉皆沉。
肝旺春季，春肝同气，春弦肝弦，四季同理。
心旺夏时，夏心洪遇，长夏与脾，缓脉同一。
秋肺脉毛，冬肾沉滑。季中旺时，脉形显明。
显明为平，平肝脉来，如揭长竿；平心脉来，
浮大而散；平脾脉来，软弱和缓；平肺脉来，
浮涩而短；平肾脉来，沉滑以转。交季脉来，
季初兼前，季末兼后。初春沉弦，初夏洪弦，
长夏初脉，洪中显缓，初秋缓毛，初冬毛沉。
春末弦洪，夏末洪缓，长夏季末，缓中毛见，
秋末毛沉，冬末沉弦。时至脉至，时去脉去，
脉不应时，病脉当断。

（二）四时五脏病脉

五脏病脉，分太过与不及。太过者，邪气盛，不及者正气虚，此为本脏自病。

经曰：“病心脉来，喘喘连属，其中微曲曰心病。”脉来急促而连贯，是心气强盛胃气少的表现，即钩多胃少之意，为心的病脉。又曰：“其气来盛去亦盛，此为太过，病在外；其气来不盛去反盛，此为不及，病在中。太过则令人身热而肤痛，为浸淫；其不及则令人烦心，上见咳唾下为气泄^[13]。”脉来盛去亦盛即洪大有余之脉，在脏主心火亢盛，为太过之脉，在外主外感发热，身痛，或为湿热浸淫^[14]。脉来不盛去反盛为心气虚，心气不足不胜夏日炎热，故烦心，咳唾，下为气泄。

“病脾脉来，实而盈数^[15]，如鸡举足，曰脾病。”实而盈数，如鸡举足，是强急而不柔和之象，是脾脉强实而胃气少之意，为脾的病脉。“其气来如水之流，此为太过，病在外；如鸟之喙，此为不及，病在中。太过则令人四肢不举；不及则令人九窍不通，名曰重强^[16]。”脾脉以软弱从容和缓为正常，无论是脉来如鸡举足还是如水之流均为少胃气为脾的病脉，而如水之流者象泉水涌出，势不可遏，按之其脉来势不减，比

鸡举足其强急之势更甚，为脾的太过之脉，主病在外，为湿热之邪所伤。脾气壅实不能正常输化精微于四肢，故四肢不举。脉来如鸟之喙者，脉短而硬，失其柔和之意。经曰：“死脾脉来实而盈数锐坚如鸟之喙，如鸟之距，如屋之漏，如水之流曰脾死。”脉短则气病，硬者脏气损伤故为不及。脾气虚，脏气伤不能正常运化输精于五脏，五脏气虚而争，九窍为五脏所主，脏气虚故九窍不通。

“病肺脉来，不上不下，如循鸡羽^[17]，曰肺病。”不上不下如循鸡羽，比喻肺病脉来艰涩，轻虚而浮内含强实的形态，即毛多胃气少之意，为肺的病脉。“其气来毛而中央坚，两旁虚，此为太过，病在外；其气来毛而微，此谓不及，病在中。太过则令人逆气而背痛愠愠^[18]；其不及则令人喘，呼吸少气而咳，上见血，下闻病音。”肺病脉反映在寸口上，肺脉本应浮涩而短，如洛榆荚。今浮涩而短之中又见中央坚两旁虚，自为太过之脉，主病在外，为外邪伤肺，证见气逆背痛；脉来毛而微为不及之脉，主病在里，为肺本脏不足，肺气虚，呼吸少气，咳。

“病肾脉来，如引葛，按之益坚，曰肾病。”脉来如拉直的葛藤，按上去有长而实的感觉为沉石过甚，为肾的病脉。“其气来如弹石者，此为太过病在外；其来

如毛^[19]者，此谓不及，病在中。太过则令人解体^[20]，背痛而少气不欲言；其不及则令人心悬如饥，眇中清，脊中痛，少腹满，小便变。”如弹石者，脉来强硬，如以指弹在石上，为太过之脉。肾旺于冬，主收藏，肾阳虚，阴寒过盛，则寸口脉沉而搏指有力。此为阴邪盛，肾气伤，形体失于温养，故令人四肢懈怠^[21]，脊背疼痛，气短而不欲言。脉来如毛者，肾脉本沉而滑，今脉不沉反浮软无力，此为肾真阴虚，心肾不交，肾水不能上济心火，故令人心悬而怯，（如饥饿时有虚悬不适的感觉。）肋下空软之处为眇中，肾气虚此处有微冷与痛感。肾主骨生髓，肾虚髓少则脊痛。肾与膀胱相表里，肾主二便，膀胱居少腹（脐的下部），肾虚膀胱气化不利，故少腹胀满，小便变。

（以上经文中“其来如毛者……”原文为其去如数者。对“去”和“如数”提出质疑。类经解“如数”为：“其去如数者，动止疾促，营之不及也。盖数本属热而此真阴亏损之脉亦必紧数，然愈虚则愈数，原非阳强实热之数，故去如数……。”高士宗解为：“其去如数者，弹石一致而即去，去之疾也，此脉气不及，故病在中。”诸家也都随文解意，将“数”作数脉，“去”作来去，来解。我以为不妥，此句应为错简。理由有二：其一，五季病脉中除此处外余四季无论太过与不及之

脉均以“其气来……。”唯独此处为“其去”。既不合理又不易理解。其二，“如数”作疾数来讲亦不妥。此段讨论肾的病脉，“其气来如弹石为太过，主病在外”是指脉来有坚硬的感觉，而不及脉，不从软硬上相比较却从脉的指数上相比较，一言其力度，一言其至数，比如以重量比长短，风马牛不相及了。古人中对此也曾有疑者，《太素》杨氏将“数”改为“毛”较为合理，毛脉虚软无力正合此意。“去”字亦应为“来”。不及之脉，“其来如毛”当为合理。）

“病肝脉来，盈实而滑，如循长竿，曰肝病。”脉来充实而滑，如循长竿，失去柔和之意即为肝的病脉。“其气来也，实而强，此为太过，病在外；其气来也不实而微，此谓不及，病在中。太过则令人善怒，忽忽眩冒而巅疾^[22]，其不及则令人胸痛引背，下则两胁胀满。”肝脉实而强为太过之脉，肝气过盛，故令人善怒，头目眩冒；肝脉不实而微，为肝气虚，木失条达，其气郁而不伸，故令人胸痛引背，两胁胀痛。为了便于记忆对五脏病脉特作脉歌以表述。

五脏病（本脏自病）脉歌

五脏之脉，各有其常，脉有胃气，无病泰康；
脉少胃气，本脏自恙。春弦过甚，弦实而强；

夏洪过甚，来去俱盛；长夏缓甚，如水之流；秋毛过甚，坚在中央；冬沉过甚，来如弹石；诸甚为强，是谓太过。诸微不足，是谓不及，春脉弦微，不实而虚；夏脉洪微，来衰去盛；长夏缓微，如鸟之喙；秋脉不及，脉毛而微；冬脉沉微，其来如毛；太过为实，不及为虚。脉实邪实，脉虚脏虚，五脏脉法，君要牢记。

五脏病（本脏自病）脉表解

季节	脏腑	脉形 (少胃气)	太过不及 主病 分类	太过脉 (病在外)	不及脉 (病在内)
春	肝	盈实而滑 如循长竿	脉象	脉来实而强	脉来不实而微
			主病	善怒，忽忽眩冒而巅疾	胸痛引背，下则两胁胀满
夏	心	喘喘连属 其中微曲	脉象	来盛去亦盛	来不盛去反盛
			主病	身热肤痛，为浸淫	烦心，上见咳唾下为气泄

(续上页表)

季节	脏腑	脉形 (少胃气)	太 过 不 及	太过脉 (病在外)	不及脉 (病在内)
			分 类 主 病		
长 夏	脾	实而盈数 如鸡举足	脉象	如水之流	如鸟之喙
			主病	四肢不举	九窍不通名重强
秋	肺	不上不下 如循鸡羽	脉象	毛而中央坚 两旁虚	毛而微
			主病	逆气背痛愠 愠	喘，呼吸少气而咳，上见血，下闻病音
冬	肾	如引葛 按之益坚	脉象	来如弹石	其来如毛*
			主病	解体背痛少 气，不欲言	心悬如饥，眇中清，背痛，少腹满，小便变

* 原文为其去如数

二、四时五脏变脉

（一）变脉有单、兼不同

五脏四时之脉，有常有变，其常者五脏当季之脉，包括平脉与病脉。平脉——即有胃气的五脏脉象。病脉——即当季的五脏脉象出现了少胃气的病脉，分太过与不及，为本脏自病之脉。出现了不当季的五脏脉象，即为变脉。《内经·至真要大论》曰：“其脉应皆何如？岐伯曰：差正同法^[23]，待时而去也。”《脉要》曰：春不沉，夏不弦，秋不数，冬不涩是谓四塞。沉甚曰病，弦甚曰病，涩甚曰病，数甚曰病，参见曰病，复见曰病，未去而去曰病，去而未去曰病，反者死。故曰：“气之相守司^[24]也，如权衡之不得相失也。”脉应随气候的变化而变化，四时旺脉与季节交替时的兼脉，同样遵循这一规律——时至而脉至，时去而脉去。若脉不随时变化是谓四塞，即四时之气不相交通而闭塞。沉甚、弦甚、数甚、涩甚者本脏自病，为太过；沉微、弦微、数微、涩微者为不及，此脉之常也。参见、复见者，除本季旺脉以外兼见他季脉象，为脉之变。变脉有兼变脉与单变脉的不同。兼变脉，为除显本季脏腑脉象以外尚兼见不当季的脏腑脉象。如春兼见肺脉，

弦而浮涩；夏兼见肝脉，洪而弦长。单变脉，为不显本季脉象只出现一种不当季脏腑的脉象。如，春见夏脉——洪大脉；冬见肺脉——浮涩而短等。参见，即兼变脉；复见，即单变脉。脉应随时而变，今季节已变，前季之脉当去而又见，或季节未过而当季脉象已变，为脉不随时，均为变脉，主病。季节气候的特点应与脉的表现相一致，就象称锤与称杆的关系一样，行动一致不得分离。

（二）变脉主病与发病早晚

按变脉相兼与否，区别变脉所代表的脏腑病邪偏盛微甚，来判断病情的轻重与发病早晚。当病邪轻时，它所引起人体气血的变化亦轻，脉的异常变化亦轻微。这时，除了正常的季节脏脉为主脉之外，尚表现出非季节性的病脉，这就是兼变脉。兼变脉因其脏气病邪偏盛微，病邪轻，故不能立即发病，必待所兼脏气旺盛的季节，借助其旺气加重病邪，始能发病。当侵犯人体的病邪较盛时，它引起机体气血变化亦强，脉搏的异常变化亦较明显，临床只出现病变脏腑所主的脉象，这就是单变脉。由于单变脉的出现，表示它所代表的脏腑病邪强，故发病早，脉见时发病。

经曰：“春脉微弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦无胃曰死，胃而有毛曰秋病，毛甚曰今病。”春季肝气旺

盛，正常的寸口脉当是有胃气的弦脉，如出现了弦甚而少胃气的脉象，即是肝本脏发生病变。脉象表现出弦象太甚毫无胃气，浮沉均现急劲之脉，这是肝的真脏脉，说明肝病危重，预后不良。春季肝旺当现弦脉，反现肺的毛脉，根据肺脉表现的轻重，判断发病的时间。有胃气的毛脉必兼弦脉，提示肺气偏盛微，病邪轻，尚未到引起发病的程度，必待秋季肺旺之时，借助自然的旺气加重病邪方能发病。毛脉表现甚的即是单变脉，表示肺的病邪偏盛甚，病邪重，现在已经发病。

“夏胃微勾曰平，勾多胃少曰心病，但勾无胃曰死，胃而有石曰冬病，石甚曰今病。”夏季心脉旺盛，正常的脉象为有胃气的洪脉，如少胃气的洪脉即是心本脏病变。洪大无伦毫无胃气的洪脉为心的真脏脉，表示病情危重，预后不良。夏季阳盛当现洪脉，反见冬季沉石肾脉为心阳不足。其轻者为兼变脉，为夏兼冬脉，表示肾的病邪偏盛微，病邪轻，现在不能发病，到了冬季阴寒过盛，必加重病邪，始能发病。而脉沉较甚者为单变脉，说明病邪重，现在已经发病。

“长夏胃微软弱曰平，弱多胃少曰脾病，但代无胃曰死，软弱有石曰冬病。弱甚曰今病。”长夏脾脉当旺，脉来缓和软弱是有胃气的正常脉，而少胃气的软弱脉

为脾的本脏病脉，软弱过甚毫无胃气的脉象为脾的真脏脉，预示脾病危重，预后不良。软弱脉中又显露冬季肾脉沉象者为兼变脉，提示肾邪气偏盛较轻，因病邪轻，目前尚未发病，到了冬季，必加重病邪始能发病。脉沉石过甚者为单变脉，为病邪重，阴盛阳衰现在已经发病。

“秋胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，但毛无胃曰死，毛而有弦曰春病，弦甚曰今病。”秋季肺脉当旺，其脉毛而有胃气即为正常脉象。毛脉较重而少胃气，表示肺脏病变，只有肺的毛脉毫无胃气的脉象为肺的真脏脉，预示肺病危重，预后不良。毛脉中显示弦脉之象者为兼变脉，为肝气偏盛轻，因病邪轻，现在尚不足以发病，必待春季肝旺时加重病邪，始能发病。脉弦过甚者为单变脉，为肝气偏旺甚，病邪重，现在已经发病。

“冬胃微石曰平，石多胃少曰肾病，但石无胃曰死，石而有勾曰夏病，勾甚曰今病。”冬季肾脉当旺，沉石有胃气的脉为肾的正常脉象，少胃气的沉石脉为肾本脏病变，只有沉石毫无胃气的脉为肾的真脏脉，预示肾病危重预后不良。如沉石脉中反显露夏季洪脉之象的为兼变脉，为心火较盛，因病邪轻，目前尚未发病，必待到夏季阳气旺盛的时节，加重病邪始能发病。洪

脉过甚者为单变脉，为病邪重，现在已经发病。（发病早晚应当活看，由于人的禀赋不同，耐受程度有别，有些人病邪虽轻，证状不重，因耐受病痛程度低可能已表现出病态。而另一些人虽病邪较重，因耐受力较强自觉尚可，反而尚未发病。）

经文只谈了相克脏腑间脉象的变化，实际上并非只有夏见肾脉，春见肺脉的变化，而是随着机体疾病的发生，五脏的偏盛，阴阳盛衰的变化，五脏脉象都可能反映在一个季节里，分别表现在寸口脉上（不是同时）。在此引用王叔和《脉经》五脏脉的变化作为补充。《脉经》说：“春肝木旺，其脉弦细而长，名曰平脉；反得浮涩而短者，是肺之乘肝，金克木为贼邪^[25]大逆十死不治；反得洪大而数者，是心之乘肝，子病累母，为实邪^[26]，虽病易愈；反得沉濡而滑者，是肾之乘肝，母病归子为虚邪，虽病易治；反得大而缓者，是脾之乘肝，土之凌木，为微邪^[27]，虽病即瘥。

夏心火旺，其脉洪大而散，名曰平脉；反得沉濡而滑者，是肾之乘心，水之克火为贼邪大逆十死不治；反得大而缓者，是脾之乘心，子病累母^[28]为实邪，虽病易愈；反得弦细而长者，是肝之乘心，母病归子^[29]为虚邪，虽病易治；反得浮涩而短者，是肺之乘心，金之凌火为微邪，虽病即瘥。

脾王之时，其脉大阿阿而缓，名曰平脉；反得弦细而长者，是肝之乘脾，木之克土为贼邪大逆，十死不治；反得洪大而数者，是心之乘脾也，母病归子为虚邪，虽病易治；反得浮涩而短者，是肺之乘脾，子病累母为实邪，虽病易愈；反得沉濡而滑者，是肾之乘脾，水之凌土为微邪虽病即差。

秋金肺王，其脉浮涩而短曰肺平；反得洪大而散者，是心之乘肺，火之克金为贼邪大逆十死不治；反得沉濡而滑者，是肾之乘肺也，子病累母为实邪，虽病易愈；反得大而缓者，是脾之乘肺，母病归子为虚邪，虽病易治；反得弦细而长者是肝之乘肺，木之凌金为微邪，虽病即瘥。

冬肾水王，其脉沉濡而滑曰肾平；反得大而缓者，是脾之乘肾，土之克水为贼邪大逆；十死不治；反得弦细而长者，是肝之乘肾，子病累母为实邪，虽病易治；反得洪大而散者，是心乘肾也，火之凌水为微邪；反得浮涩而短者是肺之乘肾也，母病归子为虚邪，虽病即瘥。

在五脏所属的五行生克致病关系中，按五脏相生的关系：

木（肝）^生→火（心）^生→土（脾）^生→金（肺）^生→水

生
(肾) → 木 (肝)

按相生的关系，生我者为母，我生者为子。在五脏五邪致病关系中，凡是病邪由生我脏来的为母病及子，母虚则累子，故为虚邪，治当补其母脏。在子脏当季的季节中，本当出现子脏的脉象反而出现母脏的脉象，如水为木之母，春见肾脉即属于此。

凡是由我生的脏腑来的病邪为子脏病累母脏，子实则病及母，故为实邪，治当泻其实。在母脏当季的季节中，本当出现母脏的脉象，反而出现了子脏的脉象，如春见心脉即属于此。

按相克的关系：

木 (肝) ^克 → 土 (脾) ^克 → 水 (肾) ^克 → 火 (心) ^克 → 金

克
(肺) → 木 (肝)

在五脏所属的五行相克关系中，凡是由相克脏腑来的病邪，因其本身即为强者，加上病邪成为更强，因其致病因素强，故为贼邪大逆，治当抑强扶弱。比如春季当出现肝脉，今不见弦脉反见相克季节脏腑的脉象一肺脉即是如此。

凡是由反克季节脏腑来的病邪，因其为以弱凌强，

故其致病因素较弱，为微邪，虽病易愈。如春季当出现肝脉，今不见肝脉反见反克季节脾的缓脉即是如此。四时变脉主五脏病列表如下：

五脏变脉主病表解

季	本 季 脉	主 病 分类	变脉 微 甚	肝 弦		心 洪		脾 缓		肺 毛		肾 石	
				微(兼)	甚(单)	微(兼)	甚(单)	微(兼)	甚(单)	微(兼)	甚(单)	微(兼)	甚(单)
春 肝	弦	变脉	本脏		弦兼洪	洪	弦兼缓	缓	弦兼毛	毛	弦兼石	石	
		发病早晚			夏发病	今病	长夏病	今病	秋病	今病	冬病	今病	
		五行生克	自病		子病累母		土凌木		金克木		母病归子		
夏 心	洪	变脉	洪兼弦	弦	本脏		洪兼缓	缓	洪兼毛	毛	洪兼石	石	
		发病早晚	春发病	今病			长夏病	今病	秋病	今病	冬病	今病	
		五行生克	母病归子		自病		子病累母		金凌火		水克火		
长夏 脾	缓	变脉	缓兼弦	弦	缓兼洪	洪	本脏 自病		缓兼毛	毛	缓兼石	石	
		发病早晚	春发病	今病	夏发病	今病			秋病	今病	冬病	今病	
		五行生克	木克土		母病归子				子病累母		水凌土		
秋 肺	毛	变脉	毛兼弦	弦	毛兼洪	洪	毛兼缓	缓	本脏 自病		毛兼石	石	
		发病早晚	春发病	今病	夏发病	今病	长夏病	今病			冬病	今病	
		五行生克	木凌金		火克金		母病归子				子病累母		
冬 肾	石	变脉	石兼弦	弦	石兼洪	洪	石兼缓	缓	石兼毛	毛	本脏		
		发病早晚	春发病	今病	夏发病	今病	长夏病	今病	秋病	今病			
		五行生克	子病累母		火凌水		土克水		母病归子		自病		

四时五脏变脉歌

四时五脏，脉各有常，旺时出现，方为平常。
时至脉至，时去脉去，脉不随时，即为变脉。
变脉之中，单兼不同，单变脉来，本脉不见，
他季脉现。春见肺脉，夏见肾脉，秋见心脉，
冬见肝脉，……。兼变脉来，本季脉中，
兼显他脉，春见弦洪，夏见洪弦，秋见浮弦，
冬见沉弦，……。

变脉主病，单兼不同，兼变邪轻，不即发病，
必待旺时，方能呈凶；单变邪重，见时病生，
欲求治法，不离五行，无论单兼，其法雷同。
当季为主，变脉为客，主客之间，五行生克。
客乘于主，乘者为强，发病亦笃；主反乘客，
反克邪微，虽病无妨。克者为强，被克者弱，
大法不离，抑强扶弱。

客生主脉，母虚归子，其势为顺，虽病易愈。
主生客脉，子实累母，其邪为实，母子之间，
补虚泻实，以平为期。

（三）变脉主病分类及治法

变脉主病大致上可分为杂病（或外感病），脏腑病两大类。在脏腑病中，又可能出现三种情况：

- (1) 只出现当季脏腑一脏病症；
- (2) 只出现变脉所代表的脏腑病证；
- (3) 出现当季脏腑和变脉脏腑两脏同病。

它们之间的关系分列如下：

变脉主病	{	1. 杂病：有脏脉而无脏症，属杂病（或外感病）	
		{	(1) 只有当季脏腑病证。
			(2) 只有变脉脏腑病证。
		(3) 出现当季脏腑和变脉脏腑两脏同病。	

变脉主病及治法分述如下：

1. 杂病：

临床上常可见到有脏脉而无脏病，多属杂病。脉象表现为弦、洪、软弱、毛、石非旺季脏腑所主脉象，而临床症状上却见不到它们所代表的脏腑病证，有此脏脉而无此脏症，这并非是五脏病，而是杂病（或外感病）。由于一种脉象所代表的意义有多种，除脏腑病外还有外感病和杂证，要知为何种病，当从 28 脉主病中求之。（28 脉主病见中篇）例如，冬季不见沉滑脉，反见洪大脉象，临床证状并无心烦、心悸等心经证状，而见口渴、汗出、牙痛、便秘等证状。脉证合参为胃火盛，当清泻胃火，选清胃散^⑥，凉膈散^⑦之类的方剂即可，不必定要治心。

2. 当只出现变脉所主脏腑一脏病症时，按变脉主

病辨证。其法同于本脏自病，按虚则补之，实则泻之的法则辨证施治。但同时还要考虑变脉脏腑与其他脏腑之间的生克制化关系，按补虚泻实、抑强扶弱的原则通盘考虑。

3. 当出现两个脏——当季脏腑与变脉所代表脏腑同病时，按五行生克辨证，如前文所示。如春见心脉——洪脉。证状上既有心的症状，心慌、心烦、口苦又见肝的症状眩晕、烦躁、胁痛等。此为心肝俱病，心肝火旺，子病累母，为实热证，当清泻心肝之火，黄连解毒汤^⑩，龙胆泻肝汤^⑪之类加减化裁。如出现肝阴不足心火旺盛引起的心悸失眠、心烦等证，在清心火的同时，养阴柔肝，滋阴降火，用导赤散^⑫合一贯煎^⑬或天王补心丹^⑭加黄连等化裁治之。如长夏见肝脉——弦脉，临床出现纳呆、腹胀、胸闷、胁痛、暖气、口苦等证，为木不疏土之象，当疏肝扶脾，以逍遥散加减化裁两脏同治。

4. 无论出现何季脏腑脉象，临床症状上却只有当季脏腑一脏病证者，按变脉所代表的阴阳盛衰意义进行辨证。一般来讲，出现心的洪脉表示该脏阳邪盛主热病；出现肾的沉滑脉，表示该脏阴邪盛主寒病；出现肺的毛脉表示该脏阴虚血弱；出现肝的弦脉，春夏表示该脏阳气不足，多主寒证、痛证，主饮或为肝病；

秋冬出现弦脉多主阳亢或肝邪。具体变化参见《四季脉解，阴阳盛衰论》与《五脏四时变脉主病表解》。

当季脏腑变脉主病表解

季 脏	变脉 主病	弦	洪	缓（软弱）	毛 （浮涩短）	石（沉滑）
春肝	弦	常	肝火旺	肝气虚	肝阴虚	肝寒证
夏心	洪	主寒，主痛，主饮，心阳不足	常	心气虚	心阴虚	心火衰
长脾 夏	（缓） 软弱	肝邪，脾虚	脾胃火旺	常	脾阴虚	（阴寒盛） 脾阳虚
秋肺	（毛） 浮涩短	肺失肃降	肺热证	肺气虚	常	肺寒
冬肾	（石） 沉滑	肝阳亢 肾失潜藏	肾水亏火旺	肾虚水泛	肾阴虚精亏	常

说明：本表为只有当季脏腑一脏病证，变脉所表示的意义

三、四季脉解，阴阳盛衰论

春夏为阳，秋冬为阴。

春脉弦，肝脉亦弦。此弦脉代表了阳气初升，阴气尚重，稚阳突破重阴渐升于上。由于阳气受阴寒之气所迫，故其脉弦。初升必兼沉象，随气候转暖，阳气渐盛脉体逐渐变大，由沉变浮，至盛夏变为洪脉。春弦之脉与夏季洪脉相比较，春脉代表阳气尚幼稚，夏脉代表阳气旺盛。夏季阳盛之时见弦脉，除有些主肝病、肝郁气滞外，多为阳气不足，为寒、为饮、主痛。长夏见弦脉多为肝脾不和、肝郁气滞之象，或为寒、为饮、为痛。秋季阳气下降，阴气渐长，反见浮弦之脉，是阳气当降而反升，多为肝阳偏盛；沉弦而迟，或弦紧者则多为寒为痛；弦而数者多主热症。冬季阳气潜藏反见浮弦之脉（兼数）为阳偏盛多主热症或为肝阳盛，沉细弦之脉多为阴虚阳亢。

春脉虽弦但弦而柔和方为正常，古人比喻春脉之弦如高举长竿的末梢上下摆动一样，有柔和之感无急劲之意。如弦而硬，按之不移，或有急劲感者，不是脏气损伤，就是肝邪横逆，或为沉寒固冷，或内有症积。

夏季阳气最盛脉来鼓动有力，故见洪脉。应当是盛大而有柔和之象方为正常，正如经言：“来盛去衰。”春见夏脉为阳气过盛为太过，主阳邪盛为热病。除夏季外其余四季见洪脉均为阳盛，主热病。其中冬季阳

气当藏脉应沉而反浮盛在外，与自然界的阴阳变化相反，主热病尤重，或为外感发热。

夏季脉洪，盛夏遇热病其脉亦洪，何以别之？正常的夏洪脉应是，浮而盛大按之不实即洪而有柔和之象。倘若洪大有力，按之不衰，为阴阳俱实之脉，为有余之象，主实热症。阴虚血弱，虚阳外浮之人，其脉亦浮大，但按之软弱无力，且有明显的空虚感，与正常的夏脉有明显的不同。

长夏暑湿气盛，人体汗出津伤，故脉来浮而软弱。秋季见此脉多为阴虚有热，冬见此脉为阴虚内热或为脾虚，春见此脉多主脾胃虚弱或为湿热郁阻，夏季见此脉多为气阴两虚，或为湿热之邪，或为脾胃虚弱。

秋季阳气下降，阴气渐长，由于阳气的进一步削弱，脉来鼓动力量不足，又在夏季发散之后，气阴两虚，脉由软弱变为浮涩而短，轻虚如毛。秋脉如出现了中央坚两旁虚，即中央部有实满感，两旁虚，自为阳气有余。冬季阳气汗藏，脉当沉滑反见秋季的毛脉为阴虚阳浮之象，春季阳气初升当见弦脉，反见秋季的毛脉亦为阴虚阳浮之象。夏季见秋季的毛脉为气阴两虚。

冬季气候寒冷，阳气深藏，脉由浮转沉，由于阳气深藏于内，脉不但沉而且滑。五季中除冬季外，其他四季见冬脉，其兼数者为阳热内郁之象，或主宿食，

妇人无病象，月经不来者，多主孕。兼迟兼缓者多主寒痰，留饮。夏季阳气盛，脉当浮洪，反见沉滑之冬脉，为寒痰、留饮，其阴盛尤重，为反四时，提示病情严重。

冬季正常的脉象应是沉而滑，往来均匀，力量不大不小。寒痰留饮之脉虽也见沉，但必沉而搏指有力，久按不衰；阴寒过盛之脉虽也见沉，然必沉紧搏指有力，正如经言，按之如引葛而益坚。阳虚之证脉也见沉，必沉而微，按之欲绝，其症必见面白、形寒、纳呆、便溏、自汗、乏力等证。冬时阴阳两虚之脉沉而细弱，或沉细而涩毫无滑意。其证必见春夏恶热，秋冬则恶寒，舌红，口干而不多饮，面色晃白，精神疲惫等证。脉症合参必不致混淆。

人是生活在自然界中，自然界的阴阳盛衰变化必然反映在脉上，四季脉的变化就具体反映了四季阴阳的这种变化。因此，四时五脏脉象就反映了人体四时阴阳的变化，掌握了每个季节气候阴阳变化的特点，就掌握了该季脉象所代表的意义，各种脉象出现在不相应的季节里，就反映了人体阴阳的失调。不同的脉象间所反映的阴阳盛衰反差即说明了病变的性质与程度。

四、六气变化对脉的影响

四时五脏在正常气候时，脉的表现已如前述，但气候的变化并非是完全一致的，有时也会出现反常。如春应暖而反热，夏应热而反寒，秋应燥而反湿，冬应寒而反暖。六气加临引起异常的气候变化，对脉也有一定的影响。六气代表了一年四季中六个时段的气候变化特点。每种气候特征都有一种脉象与之相应，这就是六经脉，它与四时五脏脉象并不完全相同。四时五脏脉是在正常气候下脉的表现，六经脉是异常气候下脉的表现。厥阴之至，风气大来，木之胜也，其脉弦。少阴之至，热气大来，火之盛也，其脉勾。少阳之至，火气大来，火之盛也，其脉大而浮。太阴之至，湿气大来，土之胜也，其脉沉。阳明之至，燥气大来，金之胜也，其脉短涩。太阳之至，寒气大来，其脉沉而紧。六经代表了六种气候特点。厥阴代表春天的风气，少阴代表初夏的温热，少阳代表盛夏的炎热，太阴代表了暑天的湿盛，阳明代表了秋天的燥气，太阳代表了冬日的严寒。六气的太过与不及，和失去正常时序引起人体脉象的相应变化。经曰：“至而和则平，至而甚则病，至而反者病，至而不至者病，未

至而至者病，阴阳易者危。”

六气顺时而至表现温和时，正常脉象就是四时五脏的平脉，六气太过和失序，就变成了六淫，成为致病的因素。脉也表现为一种变脉。即常规的当季脉和六经脉（加临于该季的气候所主脉象）相合而出现的相兼脉。其气表现微的脉的表现亦微，为兼变脉；六气表现甚的就只反映出异常气候所主脉象，为单变脉。如：春见少阳之气，热气大来。春季脉本应弦，而六经中少阳主热，其脉大而浮，春见过热天气，此时脉象应是两脉相合，即表现为浮大而弦方为正常，反此者病。如春见大热天气，犹如炎夏，当唯见少阳之脉——大而浮。又如春见太阴湿土之气，雨湿偏胜，气候本应温暖而反见寒湿，此时正常脉象除了出现春季应有的弦脉外还当出现太阴之脉——沉象。阴雨太胜气温下降，脉本应弦而反沉，方为正常。余同此理，具体变化参见《六经变脉表解》。

以太阴湿土之气为例。

太阴之至，湿气大来，其脉沉。其气加临于四季初春的脉象为：沉而兼弦。春季阳气上升，脉本应弦，但阴雨湿胜，气温偏低故脉沉而兼弦；其甚者，脉沉细。夏季脉本为洪（钩），阴雨多湿脉由洪变为不浮不沉，脉居中部，其甚者脉必沉。长夏脉本软弱，因阴

雨过甚脉变沉弱。秋季脉本浮散而短涩，因阴雨使本应干燥的气候变为阴湿多雨，脉由浮涩而短变为沉而短涩，甚者为沉细。冬季脉本为沉滑，雨雪过胜则脉沉更加明显。六气引起四时五脏脉象的变化列表简述如下：

六经变脉表解

六经	气候特征	脉象	变脉		五季常脉	春	夏	长夏	秋	冬
			微	甚	脉	弦	洪	软弱	毛	石
厥阴	风胜	弦	微			微弦	洪弦	缓弦	毛弦	沉弦
			甚			弦	弦	弦	弦	弦
少阴	热胜	勾	微			弦勾	微勾	缓勾	毛勾	勾(中部)
			甚			勾	勾	勾	勾	勾
少阳	火胜	大而浮	微			弦大而浮	微大而浮	缓大而浮	毛大而浮	中部
			甚			大而浮	大而浮	大而浮	大而浮	大而浮
太阴	湿盛	沉	微			弦沉	中部*	缓沉	中部	沉
			甚			沉细	沉	沉细	沉	沉
阳明	燥胜	短涩	微			弦涩**	洪涩	软而短涩	微短涩	沉短涩
			甚			短涩	短涩	短涩	短涩	短涩
太阳	寒胜	沉紧	微			沉弦	中部	沉弱	沉短涩	沉
			甚			沉紧	沉紧	沉紧	沉紧	沉紧

表中说明：

1. * 沉与浮脉相合，脉应表现为不浮不沉，脉居中部。
2. 钩脉与洪脉同意。
3. * * 弦为长脉类，不能与短脉相兼，弦脉遇短涩脉只能表现出短涩脉中的涩象。

六经脉歌

六经脉来，各有形态，厥阴之胜，风气大来，其脉当弦；少阴之胜，热气大来，其脉当勾；少阳之胜，火气大来，其脉大浮；太阴之胜，湿气大来，其脉当沉；阳明之胜，燥气大来，其脉短涩；太阳之胜，寒气大来，其脉沉紧。六气和顺，脉见平常，太过失序，人生病恙。非时气来，微甚有别，气微脉兼，主客同见；气甚独显，客脉呈单。气至脉至，气去脉去，气微脉微，气甚脉甚，脉不随气，必病无疑。

说明：

主：即主脉，指正常气候时的季脏脉象。

客：即客脉，指异常气候所主脉象就是六经脉。

〔按语〕 六经脉解

六气与六经相配合，代表一年之中六个时段气候变化的特点。厥阴代表风气，为一年中的初气，少阴代表温热为一年中的二气，少阳代表火热，为一年中的三气，太阴代表湿盛为一年中的四气，阳明代表燥气为一年中的五气，太阳代表了寒气为一年中的六气。六经脉是通过六气的微甚，和失序时的交叉变化，来研究异常气候对脉搏的影响。

本篇所说的六经（六气）与《内经》五运六气中的六经（六气）有所不同，其区别主要有三点。其一，《五运六气》是人为地划分六经的次序，它有固定的格式，六经轮回，每年前进一步，以前一年的二气变为当年的初气，以此类推，配合五运以六十年为周期，循环往复周而复始。而本篇所说的六经和它们的交叉变化，是以当时的客观气候为依据，没有固定的格式。

其二，它们的排列次序有别。本篇六经配六气的排列次序已如前述。《内经》运气学说中的六经与六气相配是以三阴在前，三阳在后。厥阴配风气为初之气，少阴配火气为二气，太阴配湿气为三之气，少阳配火气为四之气，阳明配燥气为五之气，太阳配寒气为六之气。上半年 3 之气为司天，主上半年的气候；下半

年6之气为在泉，主下半年气候。

其三，六经脉的表现不同，运气学说中的太阳之气寒气大来，其脉大而长；而本篇所言太阳之气寒气大来，其脉沉而紧。

五、四时五脏脉与寸关尺相结合

寸口脉在各季中的变化，正常情况下应是一致的，如引绳齐等，要浮皆浮，要沉皆沉。然而，由于人体气血逆顺有别，阴阳强弱不一，加上病邪的作用使得左、右手六脉不可能都处在同一状态，表现出完全一致来。往往表现个别部位独大、独小、独浮、独弦……。表现独的部位即为该部所属的脏腑组织或身体相应部位发生病变，出现何种脉象按其所主病辨证。一脉主多病，一病可出现多种脉象，究为何病，应以有此脉有此证方为此病，有此脉无此证则非为此病。

例如：夏季心脉当旺，寸口脉应浮大而散。六脉中唯右关脉沉弱无力脉不应时，证见纳呆，食少不知味，便溏腹泻。右关属脾，脉沉弱无力，参之以证为脾胃阳虚，运化无力。当益气健脾，补中益气汤合理中汤为治，甚者温中健脾，以附子理中汤调理。

又如，冬季肾脉当旺，脉应沉滑而柔和。六脉中

唯右寸脉洪大，不应时，证见低热，咳嗽胸痛，咳吐黄稠痰，舌红苔黄。右寸脉属肺，脉证合参为肺热证，上焦热盛，治宜清肺化痰，治以麻杏石甘汤^⑦加味。

如左右手脉表现不一，当断其那边为正常，那边为异常，异常脉即为变脉，异常脉象为何季脏脉，按变脉主病辨证。例如《素问·病能篇》曰：“帝曰，有病厥者，诊右脉沉而紧，左脉浮而（迟）涩^[30]，不知^[31]病主安在？岐伯曰：各诊之，右脉固当沉紧，此应四时，左脉浮而涩，此逆四时，在左当主病在肾，颇关在肺，当病腰痛也。帝曰：何以言之？岐伯曰：少阴脉，贯肾络肺，今得肺脉，肾为之病，故肾为腰痛之病也。”《内经》以阴虚者手足热为热厥，阳虚手足冷为寒厥，多与肾虚有关。帝问，有在冬季患厥病的人，诊其右脉沉而紧，左手脉浮而涩，不知此病表现在那里？岐伯答曰：两手脉分别诊，右手脉本应沉紧，因冬季阳气潜藏，阴寒盛，脉当沉紧，此为正常脉象。而左手脉出现异常，表现出肺脉——浮涩，此为脉不应时。由于冬季出现肺脉，而又主病在肾，此为肾阴虚故病腰痛。为什么呢？因肾属少阴，肾的经脉贯肾络肺抵腰，腰为肾之腑，冬见肺脉，表现出肾病者，脉浮涩而短为肾阴虚精亏，故病腰痛及热厥。

六、脉象与体质及用药的关系

脉的形成不离气血，脉的表现无外阴阳。气为阳，血为阴；气主鼓动，血主充沛。脉浮为阳，沉为阴；脉数为阳，迟为阴；脉实为阳，虚为阴。阳有余便是火，阴有余便为寒；阳不足虚寒生，阴不足虚热起。脉来浮大有力为阳盛，浮而虚软无力为阴虚。脉沉而有力（不数）为阴盛，沉细无力（不迟）为阴虚。

气血旺盛之人，脉来搏动有力，按之不衰，法曰：脉大有力不可补气。

阳气虚弱之人，脉来沉、微，无力。法曰脉小无力不可伤气。经曰，形不足者温之以气。

阴气虚之人，脉来虚、软、细数。治以滋阴、养阴之味，不可再用温燥药伤其阴液。

阴阳俱虚之人，脉来沉、细、弱。治法当阴阳双补，气血同调，不可苦寒以伤阳，温燥以伤阴，不可用猛烈之剂。此阴阳俱虚之人，往往虚不受补，补气则生热、补阴则生寒，只能益气养血，平调阴阳，缓中见功，不可急于求成。

脉虚、软、芤、弱之人，多有精亏血虚，当养血益气，补肾填精，不可辛热、苦寒，伤阴伤阳，当以

辛润甘温之剂，厚味滋填。法曰：精不足者补之以味。

尺寸无脉，两关短小，病位不在肝脾、应从气血上辨，属气虚，当补其气。

众脉虚弱我独实，众脉细小我大独。独实独大为实余为虚，当先泄其实后补其虚。

脉来浮大，不胜重按为虚，当以扶正。脉来沉小久按不衰为实，为邪结在里，应攻之。

脉来浮大，两边软散，虽有弦、滑、实之象，仍为虚中夹实，本虚标实之证，当扶正驱邪，不可过于克伐。

脉来短，兼有滑、数、实者，除少数为饮酒或下利外，多为虚中夹实证，法当虚实兼顾。

一些老年人，平时阴气不足，阳气有余，脉体往往变大，加上动脉逐渐硬化，脉来浮大弦长，按之有空虚感。如脉弦硬不甚临床又无其他见证者，仍为脉与形体相应，而非病脉。如弦硬过甚又证状明显，即为肝肾阴虚，虚阳外浮之象，治疗上当滋阴养血柔肝补肾，不可再温燥升提，反助其阳，加重病情。

注 释

〔1〕 经脉：指正常脉象为经脉。

[2] 定论脉：三关候五脏：引自《医宗必读》左寸心脉必浮大而散，右寸肺脉必浮涩而短……。此论首见于《伤寒论平脉法》：脉有三部尺寸及关，荣卫流行，不失衡铨，肾沉心洪，肺浮肝弦，此自经常。后人疑其非仲景所写，乃为王叔和之言，观《金匱要略》，《伤寒论》正文中并无此论。后世元·滑伯仁《诊家枢要》，明·李中梓《医宗必读》张景岳、李延是等人均昌此论，对脉学影响颇大。

[3] 秋脉毛：以鸟的羽毛比喻秋脉轻虚而浮、短涩之脉。

[4] 冬脉石：以石沉水底来比喻冬肾脉沉滑之象。

[5] 六合：指上、下、左、右、前、后六个方位。

[6] 累累如连珠：以串联的珠玉比喻夏脉的盛满滑利。

[7] 钩（脉）：即洪脉，以勾之形比喻夏季心脉。

[8] 孤脏：一说脾独不主时，寄旺于四季之末，各十八日，故曰孤脏。

[9] 厌厌聂聂如落榆荚：以落榆荚翩翻纷飞之状比喻秋脉轻浮和缓之象。

[10] 喘喘累累如钩：脉来沉滑而有洪脉象。

[11] 营：即沉石之意。《难经》、《甲乙经》作“石”。

[12] 《脉要》、《内经》已前的脉学著作，今已失传。

[13] 气泄：指阳气虚不能行于上，引起的气从肛门泄出。

[14] 浸淫：病名，由湿热引起的皮肤疾病，如黄水疮之类。

[15] 实而盈数：脉来充实急数，失去柔和之象。

[16] 重强：肢体沉重拘强，不柔和的样子。

[17] 不上不下如循鸡羽：形容脉来艰涩轻虚而浮内含强实的形态，就象用手触摸鸡的羽毛。

[18] 背痛愠愠：背痛郁闷不舒。

[19] 其来如毛：原文为其去如数。因其他脉均为来，独此处为去不易理解，“数”，按《太素》改为“毛”。

[20] 解体：指身体感觉困倦，肢体懈怠的证状。

[21] 懈怠：肢体困倦乏力。

[22] 巅疾：泛指头部疾患，多为头痛目眩。

[23] 差正同法：四季旺时的脉象为正，季初与季末的兼脉为差，它们都循着同一个规律，时至而脉至，时去而脉去。

[24] 气之相守司：指脉随季节气候变化而变化，脉与气候相跟随不可分离。

[25] 贼邪：见中篇第 14 条。

[26] 实邪：邪从被生者方来的为实邪，为子病累母。

[27] 微邪：邪从被克方来者为微邪。

[28] 子病累母：同 26 条。

[29] 母病归子：邪从生我方来者为虚邪，为母病归子。

[30] 浮而涩：原文为“浮而迟”，根据文义当为肺脉，而肺脉为浮短而涩，今改正。

[31] 不知：原文为“不然”，不易解，今从甲乙经改作“不知”。

《内经》遍身诊脉法

遍身诊脉法是根据经脉与五脏六腑的所属关系，和经脉的循行部位，将人体分成上、中、下三部分，每个部分又分为天、地、人三候，通过对九个部位动脉的变化观测，来推断脏腑组织及循行部位所发生的病变。它包括三部九候诊法，人迎、气口对比诊法和诊尺肤法。由于这种诊脉法用于临床很不方便，又难于掌握，因此，自《难经》以后，后世医家除了在生命垂危时，少数部位如：太溪脉、趺阳脉、人迎脉仍采

用外，已多不用。但由于我们今天所采用的寸口诊脉法，是从遍身诊脉法中演变过来的，了解它的前身对更好的学习脉诊仍有着重要的意义。同时，遍身诊脉法在提示我们全面观察病人，和对比辨脉方法上对我们今天辨脉仍具有一定的意义。

一、三部九候诊脉法

（一）诊脉部位

【原文】 《素问·三部九候论》帝问曰：天地之至数^[1]，合于人形、血气，通决死生为之奈何？岐伯曰：天地之至数，始于一，终于九焉。一者天、二者地、三者人，因而三之，三三者九，以应九野。故人有三部，部有三候，以决死生，以处百病，以调虚实而除邪疾。

【按语】 古人以天人相应的观点把地域分成九野，将人体分为上、中、下三部，每部又分为天、地、人三候，共九个部位。通过对九个部位动脉观察而测知人体疾病的发生与变化。

【原文】 帝问曰：何谓三部？岐伯曰：有下部、有中部、有上部，部各有三。三候者，有天、有地、有人也，必指而导之，乃以为真。

上部天，两额之动脉（在额两旁，为足少阳胆

经)；上部地，两颊之动脉（鼻两旁近于巨髃，为足阳明胃经)；上部人，耳前之动脉（耳前陷者中，为手少阳三焦经)。

中部天，手太阴也，（寸口脉，候肺）。

中部地，手阳明也（合谷脉，候大肠）。

中部人，手少阴也（神门脉，候心）。

下部天，足厥阴肝也（在毛际外羊矢下一寸半陷中，五里之分卧而取之。女子取太冲在足大指本节二寸陷中，候肝)；

下部地，足少阴肾也（足内踝骨上陷中，太溪脉，候肾)；

下部人，足太阴脾也（在鱼腹上趋筋间，直五里下箕门之分，候胃气当取足跗之上，冲阳之分，候脾胃）。

故，下部天以候肝，地以候肾，人以候脾胃之气。帝曰：中部之候奈何？岐伯曰亦有天，亦有地，亦有人。天以候肺，地以候胸中之气，人亦候心。帝曰：上部何以候之？岐伯曰：亦有天，亦有地，亦有人。天以候头角之气，地以候口齿之气，人以候耳目之气。三部者，各有天，各有地，各有人，三而成天，三而成地，三而成人，合则为九，九分为九野，九野为九脏，故神脏五，形脏四合而为九脏。

【解说】 此段具体论述了三部九候的诊脉位置与每部脉所诊的脏腑及部位。五脏主藏精气与魂魄神志，故为神脏；大肠、小肠、胃与膀胱藏水谷糟粕，故为形脏，以地域分九野比喻人体有九脏。

（二）诊脉方法

1. 正常脉与病脉的表现：

【原文】 “九候之相应也，上下若一，不得相失，一候后则病，二候后则病甚，三候后则病危。所谓后者应不俱也。”

【解说】 正常的九候脉，其表现应是一致的，要浮皆浮，要沉皆沉，要迟皆迟，要大皆大。如一处脉有异则为该动脉所属的脏腑或它所主的部位发生病变。二处不应则病甚，三处不应病情就很严重了。

2. 察病位，及病性：

【原文】 帝曰：“何以知病之所在？”

岐伯曰：“察九候独小者病，独大者病，独疾者病，独迟者病，独热者病，独寒者病，独陷下者病。”

【解说】 独处藏奸，表现独异于常者即为病脉，它所主的脏腑与所属的部位发生病变。独大，独小察病的虚实。一般讲脉大为邪盛，脉小为正虚。独疾，独迟察病性的寒热。脉疾者为热，阳偏胜；脉迟者为寒，阴偏胜。独寒独热察脉络及皮肤温度。阳胜及局部瘀

热者脉络及皮肤温度上升，阴胜及局部受寒邪者脉络及皮温降低。独陷下者，其指有二，一指脉沉伏，一指脉体陷下不能充盈。沉伏主病在里，或为阳气虚弱；脉来陷下不能充盈，指脉管内循环血量减少，使脉体不能充盈，多为失血或因虚损。

（三）病脉，死脉

【原文】“上下左右之脉相应如参舂^[2]者病甚。上下左右相失不可计数者死。中部之候虽独调与众脏脉相失者死。中部之候相减者死。”

“形盛脉细，少气不足以息者危。形瘦脉大胸中气多者死。形气相得者生，参伍不调者病，三部九候皆相失者死”。“是以脱肉身不去者死，中部乍疏乍数者死。”，“形肉已脱，九候虽调犹死。七诊^[3]虽见，九候皆从者不死。所言不死者，风气病，及经月之病，似七诊之病而非也，故言不死。若有七诊之病，其脉候亦败者死矣，必发哆噫。”

【解说】 上下左右之脉如参舂者，为众脉往来快慢不一致，参伍不调。脉来不一致为病重的表现，久时不来不能计数者，主死。

脉与形气应是一致的，形盛脉必旺，形衰脉必弱。如形气与脉不相应，形盛脉细小，或形瘦脉大，多为病重之象，加上少气不足以息，胸中气多、喘满，为

危重之象。大肉已脱，行动艰难卧床不起者，主死；中部有脉，其他部无脉也多主死。中部之脉迟滞，和其他脏脉不一致者主死。中部之脉虽表现一致，但与其他脉不一致者，主死；中部之脉忽快忽慢者，主死。如形肉已脱，说明气血衰败，九候之脉虽表现和缓一致，也是正气与病气俱脱，反无病之象，故必死。而局部脉的独异，只有局部脏腑或部位的病变时，非为主死之脉。如，偶感风邪，或妇女经期下血出现独大、独小的脉象变化，虽似七诊之脉而非七诊之病故不死。有七诊的病症，脉候又出现败象者，亦死。然，此证必发哆噫，因脾败，心气绝。

（四）脉的表现与预后

【原文】 岐伯曰：“九候之脉，皆沉细悬绝者为阴，主冬，故以夜半死。盛躁数喘者为阳，主夏，故以日中死。是故寒热病者，平旦死；热中及热病者，以日中死；病风者，以日夕死；病水者，以夜半死；其脉乍疏乍数、乍迟乍疾者，日乘四季死。”

【解说】 九候之脉皆沉细悬绝为沉细至极之脉，冬时见之因脉与自然界的阴阳变化相一致。非其时见之为阴盛极而阳衰的表现，夜半为阴盛阳衰之时，阳衰之病遇此时必加重病情，重者必危，危者必死。盛躁数喘之脉，在夏时因脉与气候相应，非其时见之为

阳盛极阴衰竭，日中为阳旺之时，阳盛极之病遇此时必加重病情，危者必死。病风者，风属木，日夕为日将落时，此时属金，金克木故以日夕死。病水者为阴盛阳衰，夜半阳衰时必加重病情，危者必死。脉来乍疏乍数、乍疾乍迟者为脾绝之脉，景岳说：“日之四季，辰戌丑未也。四季为五行之墓地，故败竭之脏，遇之而死。”

（五）五脏六脉微甚主病

【原文】 黄帝问曰：“请问脉之缓、急、大、小、滑、涩之病形何如？岐伯曰：臣请言五脏之病变也。”

【按语】 五脏六变脉主病，载于《灵枢·邪气脏腑病形篇》，是属于那种诊法，经文未明确说明。《甲乙经》、《类经》等对《内经》有研究的论著中也未提及。考《内经》时代五脏脉辨病只有两种，一种是遍身诊法：中部脉，天以候肺，人以候心；下部脉，天以候肝，地以候肾，人以候脾胃之气。另一种是寸口诊脉法中的四时五脏脉法，四时五脏脉法是按季节气候与脏腑的关系加以讨论的。此段文字论五脏脉象是单以脉论病，不与季节挂勾。这显然与四时五脏脉法不相吻合。因此，它是遍身诊法的内容是毋庸置疑的了。

1. 心脉六变主病：

【原文】 心脉急甚为瘈瘲^[4]；微急为心痛引背，食不下。缓甚为狂笑；微缓为伏梁^[5]，在心下上下行，时唾血。大甚为喉𦣻^[6]；微大为痹引背，善泪出。小甚为善𦣻；微小为消瘵^[7]。滑甚为消渴；微滑为心疝引脐，小腹鸣。涩甚为暗；微涩为血溢，维厥^[8]、耳鸣、颠疾。

【解说】 脉急，即弦急之脉，主寒、主痛。心主血脉，寒邪侵袭筋脉挛缩，肢体就要发生抽搐的病证。心脉微急为阳虚，胸阳不振阴邪干之就会出现心痛引背，饮食不下。心脉缓是心气热，热则心脉弛缓不收则为狂笑；微缓为热壅血瘀为伏梁积在心下，能升能降时有吐血。心脉大甚为心火盛，火性炎上故病喉中𦣻然有声；微大为气阴两虚为心痹引背，容易流泪。心脉小甚为阳气虚弱，心火不生脾土，脾阳虚食不能化，故为善𦣻；微小为血弱肌肤消瘦。心脉滑甚为阳热盛，热灼津伤故为口渴；微滑为有热在下，为心疝引脐，小腹时有肠鸣。心脉涩甚为血瘀气滞，故为声哑；微涩为精伤血少，为虚寒，症见出血、四肢逆冷、耳鸣、头痛等。

2. 肺脉六变主病：

【原文】 肺脉急甚为癰疾；微急为肺寒热、怠惰、咳唾血、引腰背胸、若鼻息肉不通。缓甚为多汗；微缓为痿痿^[9]，偏风，头以下汗出不可止。大甚为胫肿；

微大为肺痹引胸背，起恶日光。小甚为泄；微小为消瘴。滑甚为息贲^[10]上气；微滑为上下出血。涩甚为呕血；微涩为鼠痿^[11]，在颈、支腋之间，下不胜上，其应善酸矣。

【解说】 肺脉急甚是风邪盛，风属木，肺为金，木反侮金，风木亢盛易发癫疾。微急是风寒伤肺，寒邪束表为恶寒发热，身体怠惰。肺失肃降则咳嗽，伤及肺络则咳吐血，牵引腰背痛。肺气不利鼻塞不通象患了鼻息肉一样，皆为风寒束表引起。肺脉缓为肺气虚，卫外不固表虚多汗。微缓是肺气阴两虚，易发生痿证、鼠痿及瘫痪，或头部以下多汗不止。肺脉大甚为邪热盛，肺热壅滞，上源不清影响水道通条则下为胫肿，上为肺气壅塞引腰背胸，伤于热则恶热，日光为阳故怕日光。肺脉小甚为阳虚，肺与大肠相表里，肺寒大肠不固则泄泻；微小则气虚血少形体消瘦。肺脉滑甚为痰热壅肺，故喘急上气。微滑为阴虚血热，热伤血络则出血，伤及阳络则衄血、吐血，伤及阴络则二阴出血。肺脉涩甚多因伤血而涩，为呕血。微涩则为阴虚血少易发鼠痿。肺阴虚血少金不生水，肾气亏虚则足膝酸软。

3. 肝脉六变主病：

【原文】 肝脉急甚为恶言；微急为肥气^[12]，在胁

下若覆杯。缓甚为善呕，微缓为水瘕^[13]，痹也。大甚为内痛，善呕衄；微大为肝痹阴缩，咳引小腹。小甚为多饮；微小为消瘴。滑甚为瘕疝^[14]；微滑为遗溺。涩甚为溢饮；微涩为癰挛筋痹。

【解说】 肝脉急甚是肝气强盛，肝为将军之官在志为怒，肝气强盛为怒生恶言；微急为症积，肝之积为肥气，积在胁下如覆杯状。肝脉缓甚是土气壅实，脾土反侮肝木，脾实不运故善呕，微缓是湿胜，故为水积不化或成湿痹。肝脉大甚为肝火盛，热壅血瘀成痛，肝火犯胃则善呕，热伤血络则衄血；微大为阴虚内热，主肝痹、阴缩，木火刑金则咳引小腹，遗尿。肝脉小甚为血少津亏，故口渴多饮；微小为肝阴虚血少，故形体消瘦。肝脉滑甚为肝经湿热易发瘕疝；肝脉微滑亦为蕴热，邪热下走易为淋痛、遗尿。肝脉涩甚为气滞，肝郁气滞木不疏土，脾失健运则成溢饮，微涩为血虚，筋脉失养易发拘挛抽掣，筋脉痹痿。

4. 脾脉六变主病：

【原文】 脾脉急甚为癰疽；微急为膈中^[15]，饮食入而还出，后沃沫。缓甚为痿厥^[16]；微缓为风痿^[17]，四肢不用，心慧然若无病。大甚为击扑；微大为疝气，腹里大脓血在肠胃之外。小甚为寒热；微小为消瘴。滑甚为溃瘡^[18]；微滑为虫毒蝮蝎^[19]腹热。涩甚为肠

溃^[20]；微涩为内溃^[21]，多下脓血。

【解说】 脾脉急甚为肝邪盛，肝阳化风发为抽搐，微急为症积，在脾为膈中，食入格拒，故入而反出，后吐涎沫。脾脉缓甚为脾虚，脾主四肢，四肢失养则痿废失用，但心中明了，若无病。脾脉大甚为热盛极，脾胃热极而发扑倒如被打击。微大为湿热，易发疝气，热壅血瘀化腐为脓，则可出现脓血积于肠胃之外。脾脉小甚为中气不足，脾阳虚。阳虚则外寒，脾气虚则湿滞，湿郁久化热故为寒热。脾脉滑甚为湿热在肠所致溃疝、癰疝；微滑为虫积，腹内发热。脾脉涩甚是气滞血瘀，多主肠内发生溃疡；微涩为气虚血伤，多为溃疝下脓血，气血已伤。

5. 肾脉六变主病：

【原文】 肾脉急甚为骨癰疾^[22]；微急为沉厥、奔豚^[23]，足不收不得前后。缓甚为折脊；微缓为洞，洞者食不化，下嗝还出。大甚为阴痿^[24]；微大为石水^[25]，起脐已下至小腹痿痿然^[26]，上至胃脘死不治。小甚为洞泄；微小为消瘵。滑甚为溃癰^[27]；微滑为骨痿，坐不能起，起则目无所见。涩甚为大痛，微涩为不月沉痔^[28]。

【解说】 肾脉急甚为寒邪盛，肾主骨，骨受寒发为骨癰疾；微急为阳虚寒气盛，发为奔豚，四肢逆冷

沉重，两足不能自收，二便不通。缓甚为肾气不足湿气过盛，病机十九条曰：诸颈项强皆属于湿，湿胜故为脊柱反折。微缓为阳虚火衰，阳气不升故为洞泄，即完谷下利，食物下嗑很快排泄。肾脉大甚为阴虚火旺，则发阴痿不举；微大为水气病，为石水，其证是腹大从脐至小腹膨胀下垂，发展到胃脘时，即为不治。肾脉小甚为肾阳虚，亦为洞泄；肾脉微小为气阴两虚，多为消瘵病。肾脉滑甚为下焦热盛则发癰闭，或癰疽；微滑亦为火旺伤阴，阴伤则发为骨痿。肾脉涩甚为瘀血内阻，郁久化热化腐为大痈，微涩为气血虚，在女子为不月或久痔伤血。

【按语】 上述六脉，急，指脉来弦疾有力，或主寒、主痛、或为肝邪。缓，指脉来迟缓，或缓散不收，或主热、主湿、主虚。大，指脉形浮大多为邪热所致。小，指细弱脉，多为气血虚弱，又主阳气虚阴寒盛。滑，多主湿热，热盛或痰热。涩，主血瘀气滞，或精伤血少，气血亏虚。

六脉配五脏，因五脏的生理功能不同，病理有别。因此，相同的脉象主病往往不同。但亦有脉同病同的情况。如六脉微小为气虚血少，主病形体消瘦为津液亏耗为消瘵病。

（六）危候诊法

【原文】 以左手足上去踝 5 寸按之，庶右手足当踝而弹之，其应过 5 寸以上，蠕蠕然^[29]者，不病；其应疾，中手浑浑然^[30]者病，中手徐徐^[31]然者，病；其应上不能至 5 寸，弹之不应者死。

【解说】 医生用左手放在病人足内踝上 5 寸处，用右手指在足内踝处弹几下，医生左手有搏动感在 5 寸以上且从容和缓者，不病；如搏动感过强不柔和者，为病；搏动感过弱者，病；如搏动感不能上传 5 寸远者，病危；没有搏动感者，主死。

注 释

[1] 至数：张介宾释：“天地虽大，万物虽多，莫有能出乎数者，数道大至，故曰至数。”即反映自然规律的数字。

[2] 参春：春即臼是谷类去壳的工具。参春即捣臼，以此来比喻众脉往来不一致。

[3] 七诊：为遍身诊法的内容。即独大、独小、独疾、独迟、独寒、独热、独陷下。

[4] 瘕疢：指肢体小的抽搐。

[5] 伏梁：病名，为积的一种。心之积名曰伏梁。其症为起脐上，大如臂，上至心下，久不愈，令人病

心烦。

[6] 喉、𦣻：喉中𦣻然有声。

[7] 消瘵：即消渴病。以多饮、多食、多尿而形体消瘦的三多一少为其特征。

[8] 维厥：维指四肢，厥为厥逆。即四肢逆冷的意思。

[9] 痿痿：痿指肺痿，为肺热叶焦所致。痿即鼠痿，即淋巴结核之类，好发于颈、腋部。

[10] 息贲：病名，肺之积为息贲，其症为喘息。

[11] 鼠痿：同第九条痿。

[12] 肥气：病名，肝之积名曰肥气，症见在胁下如复杯，有头足，久不愈，令人发咳逆痞虐。

[13] 水瘕：病名即水积。

[14] 瘕疝：病名即癥疝，是疝气的一种，为阴囊肿硬，重坠麻木等。

[15] 膈中：即食入反出，为噎膈、反胃之类。

[16] 痿厥：痿为肉痿；厥为四肢厥逆。

[17] 风痿：感受风邪而四肢痿软无力。

[18] 溃癰：病名即瘕疝和癰疝，也泛指腹内化脓性，炎症肿块。

[19] 蛭蝎：蛭同蚘，即蛔虫。蛭蝎泛指腹内诸虫。

[20]、[21] 肠溃、内溃：指肠内溃疡。

[22] 骨癰疾：癰疾之重，病深在骨。

[23] 奔豚：病名，肾之积名曰奔豚，发于少腹上至心下，有气上冲，若奔豚状。豚：小猪。

[24] 阴痿：即阳痿。

[25] 石水：病名，为水肿类型之一，症状为水肿偏于腹部，腹满不喘，或引胁下胀痛，脉沉。

[26] 腹胕胕然：腹部肿胀，下坠的样子。

[27] 癃溃：小便点滴而下为癃，溃即溃疔。

[28] 沉痔：即痔疮。

[29] 蠕蠕然：从容和缓的样子。

[30] 浑浑然：强急而不柔和的样子。

[31] 徐徐然：缓慢而弱的样子。

二、人迎、气口诊脉法

人迎、气口诊脉法，属于遍身诊法的范畴，它是在足阳明胃经上取结喉旁人迎穴处的动脉，与手太阴肺经太渊穴处的动脉即寸口脉，进行对比诊脉的方法。因人迎为足阳明胃经的动脉，胃为腑，属阳，故主于外。寸口属太阴肺经的动脉，肺为脏、属阴，故主乎里。《灵枢·四时气篇》曰：“人迎候阴，气口候阳”，

《灵枢·五色篇》曰：“人迎盛坚伤于寒，气口盛坚伤于食。”

在诊脉辨病中，正常的人迎脉、寸口脉应当是大小和节律一样。《灵枢·禁服篇》曰：“寸口主中，人迎主外，俱往俱来若引绳大小齐等，春夏人迎微大，秋冬寸口微大，如是者，名曰平人。”春夏阳气盛，人迎脉属阳，故脉稍大；秋冬阴气盛，阳气衰，寸口属阴，故秋冬寸口脉稍大。大体上两脉应搏动一致，脉率及大小一致。

人体在正常时，阴阳是相对平衡的，阴阳失去了平衡就会产生疾病。因此，疾病的发生是阴阳盛衰的转化，掌握了阴阳的变化就掌握了疾病的变化。人迎脉和气口脉的对比诊病上，从人迎脉可以察出阳气的变化，气口脉可诊察阴气的变化。《灵枢·四时气篇》曰：“气口候阴，人迎候阳。”从二者相互对比变化上可以推测出整体的阴阳进退变化。从而推测疾病的部位和性质。《素问·六节脏象论》曰：“故人迎一盛病在少阳，二盛病在太阳，三盛病在阳明，四盛以上为格阳。寸口一盛病在厥阴，二盛病在少阴，三盛病在太阴，四盛以上病为关阴。人迎与寸口俱盛四倍以上为关格，关格之脉，羸^[1]不能极于天地之精气，则死矣。”

通过人迎脉与寸口脉对比诊病来确定病位。人迎一盛是指人迎脉比寸口脉大一倍、二倍……。这一点《灵枢·禁服篇》说的更明白些。他说：“……人迎大一倍于寸口，病在足少阳，一倍而躁病在手少阳。人迎二倍病在足太阳，二倍而燥病在手太阳。人迎三倍病在足阳明，三倍而燥病在手阳明。……寸口大于人迎一倍病在足厥阴，一倍而燥病在手心主。寸口二倍病在足少阴，二倍而燥病在手少阴。寸口三倍病在足太阴，三倍而燥病在手太阴……”人迎脉与寸口脉相互对比，由于人迎候阳气的强弱，寸口候阴气的强弱。因此，人迎脉大，病在阳，为阳盛；寸口脉大，病在阴，为阴盛。两者相比有三种情况：①人迎大于寸口脉，一倍、二倍、三倍；②寸口脉大于人迎脉，一倍、二倍、三倍；③两者同大或同小。六经代表了人体经脉的阴阳多少，少阳为阳之初，太阳为阳之中，阳明为阳之极；厥阴为阴之始，少阴为阴之中，太阴为阴之极。故人迎一盛为阳之始，病在少阳经。二盛为阳之中，病在太阳经。三盛为阳之极在阳明经，阴经亦然。三阴三阳经又分手足，手为上，足为下；上为阳，下属阴。三阳经中手三阳为阳中之阳，三阴经中手三阴为阴中之阳。脉来躁动为热，为阳偏胜，故为在手；不躁者属阴故为在足。两者俱盛四倍以上为阴阳俱实

之证，为真脏脉，关格脉。经文只谈了邪盛的脉象，由此可以推想在相反的情况下正虚时，阳虚脉象必为人迎小于气口（气口脉正常）一倍、二倍、三倍……，阴虚时气口脉小于人迎（人迎脉正常）一倍、二倍、三倍……。而阴阳俱虚时为两者俱小于正常……。《灵枢·经脉篇》曰：五脏盛者寸口大（一、二、三）倍于人迎，虚者则寸口反小于人迎也。六腑盛者人迎大（一、二、三）倍于寸口，六脏虚则人迎反小于寸口也。

在人迎、寸口脉诊法中，除了对比诊病外单独诊人迎脉，寸口脉可以掌握病机的进退，邪气的盛衰。《灵枢·四时气篇》曰：“一其形，听其动静者持气口，人迎以视其脉，坚且盛且滑者，病日进；脉软者，病将下；诸经实者，病三日已。”《灵枢·五色篇》曰：“切其脉口，滑小紧以沉者，病益甚，在中；人迎气大紧以浮者，其病益甚，在外。其脉口浮滑者，病日进；人迎沉而滑者，病日损。其脉口滑以沉者，病日进，在内；其人迎脉滑盛以浮者，其病日进，在外。脉之浮沉及人迎与寸口气小大等者，病难已。病之在脏，沉而大者，易已，小为逆；病在腑，浮而大者，其病易已。”

在病变过程中，凡邪气盛者病日进，邪气衰者病渐好。正气盛者病易愈，正气衰邪气盛者病日进。人

迎主阳，寸口主阴，两部脉坚盛且滑均为邪盛，邪盛故病日进；脉软是邪气衰，邪气衰者病好转。诸经实者为邪在经而不在脏腑，故病轻，三日已。

寸口脉候阴，主邪在内，寸口脉滑小紧为阴邪盛，故病进。人迎脉主阳，气大紧以浮为阳邪盛，故病日进。寸口浮滑者为阴分中阳邪盛，故病日进。人迎脉沉滑者，阳邪渐退，故病日损，损者减也。脉口滑以沉者，阴邪盛故病日进，为在内。其人迎脉滑盛以浮者，为阳邪盛，故病日进，为在外。寸口脉与人迎脉在无病状态下，大小同等，如引绳齐等为阴阳平和之脉，在发生病变时人迎与寸口大小等者，为阴阳同病，同盛或同衰，故为病难已。病在脏，脉沉而大者为阴病得阳脉为正复之象，故易愈；而脉小是正气衰败，故为病难已。病在腑，脉浮大为阳病见阳脉，脉症相附，正气不衰，故病易好转。

注 释

[1] 羸：肌肉消瘦。

三、诊尺肤法

诊尺肤也是脉诊中的一个组成部分，通过诊察尺部皮肤的缓、急、大、小、滑、涩及温度的变化和肌肉的坚脆、厚薄以及尺肤与脉的相应变化来诊病，又是《内经》脉诊的一大特点。

《灵枢·论疾诊尺篇》黄帝问于岐伯曰：“余欲无视色持脉，独调其尺，以言其病，从外知内，为之奈何？岐伯曰：审其尺之缓、急、大、小、滑、涩，肉之坚脆，而病形定矣。……尺肤滑其淖泽^[1]者，风也。尺肉弱者解体，安卧脱肉者，寒热不治。尺肤滑而泽脂者，风也。尺肤涩者，风痹也。尺肤粗如枯鱼之鳞者，水洩饮^[2]也。尺肤热，其脉盛躁者，病温也，其盛而滑者，病且出也。尺肤寒其脉小者，泄、少气。尺肤炬然，先热后寒者，寒热也。尺肤先寒，久大之而热者，亦寒热也。”

除了尺肤的皮肉可反应出一些病证外，从尺肤与脉的变化上（主要是寸口脉）可诊出疾病变化。一般讲，脉的变化与尺的皮肤变化是相应的。脉急者尺之皮肤亦急，脉缓者尺之皮肤亦缓，脉大者尺之皮肤亦胀大，脉滑者尺之皮肤亦滑……。《灵枢·色诊篇》：

“脉急者，尺之皮肤亦减而少气；脉大者，尺之皮肤亦贲而起；脉滑者，尺之皮肤亦滑；脉涩者尺之皮肤亦涩；凡此变者，有微有甚，故善调尺者，不待于寸……。《素问·平人氣象论篇》曰：尺脉缓涩，谓之解𦣻^[3]。安卧脉盛，谓之脱血。尺涩脉滑，谓之多汗。尺寒脉细，谓之后泄。脉尺粗常热者，谓之热中。”

除了从尺肤的变化诊病外，从肘的前后局部的寒热变化上也可看出病邪的部位和病性的寒热。《灵枢·邪气脏腑病形篇》曰：“肘所独热者，腰以上热；手所独热者，腰以下热，肘前独热者，膺前热；肘后独热者，肩背热。臂中热者，腰腹热；肘后粗以下三四寸热者，肠中有虫。掌中热者，腹中热；掌中寒者，腹中寒。鱼^[4]上白肉有青血脉者，胃中有寒。”

注 释

[1] 淖泽：皮肤光滑而润泽。

[2] 水洗饮：洗同溢，水洗饮即溢饮。

[3] 解𦣻：见下篇第20条。

[4] 鱼：指鱼际，拇指本节内侧肌肉隆起处。

脉 案

一、五脏病脉案

1. 中风先兆案（气血亏虚、虚风内动）

刘××，男，63岁，工人。初诊于1995年10月17日，霜降前6天。

正常脉象 短涩略沉。

病脉 两手脉细软无力，两寸尤甚。

辨脉提要 两寸脉独，寸脉主上，在脏主心肺，在体主头胸。脉虚证虚。

主诉及简要病史 头晕，心悸1周，近2天加重，感舌麻耳鸣，左侧肢体麻木，两腿无力走路不稳如踩棉花。晨起口干但不多饮，小便频数，余尚可。

查体 形体消瘦，面色萎黄，精神疲惫；脉细软无力，两寸尤甚；舌略红，苔白薄少津；血压13.3/8.0kPa 神精系统检查未见明显异常。

脉理、病理分析 深秋脉当短涩略沉为平，今见脉来细软无力两寸尤甚；细者阴血不足，软弱无力者气虚。寸脉主上，两寸尤甚者，气血亏虚不能荣于上，

经曰：“推而上之，下而不上者头项痛也。”心脑血管失养，虚风内动、故见头晕、心悸、舌麻、耳鸣、肢体麻木等证。辛劳之人，平时过于节俭，营养匮乏，气血亏虚不能荣于上，虚风内动，欲发偏枯，谨防中风。

诊断 中风先兆（气血亏虚，虚风内动）。

治则 补气养血，活血通络。此纯虚之证，虽见风证，不可以祛风药治之，仿补阳还五汤意。

生芪20克，生晒参8克，当归12克，川芎10克，杭芍12克，熟地12克，元肉15克，枣柏仁各15克，云苓12克，鸡血藤20克，丹参15克，桑桂枝各12克，炙草10克。每日1剂，2次水煎，早晚分服。

治疗结果 服上药3剂后头晕，心悸明显减轻，舌已不麻；6剂后各种证状基本消失唯感活动后气短。继以前方减生芪为12克，加首乌、山萸肉等，调理1周身体恢复，面色红润，最后以归脾汤合天王补心丹加减化裁调理，以资巩固。

2. 心悸、水亏火旺心肾不交案

张××，男，29岁，个体工商户。初诊于1996年4月5日，清明后第2天。

正常脉象 弦而柔和。

病脉 六脉中唯见左寸脉洪大，余弱。

辨脉提要 左寸脉在脏主心，洪为阳脉，非旺时见，主病，为热盛。其余脉沉弱，亦为脉不应时，春见沉弱为阴虚。

主诉及简要病史 心悸阵发已患数年，每活动则加剧，近1月来加重，自觉心慌、气短、烦热，伴见干呕，失眠；纳可，二便正常。

查体 左寸脉洪大而数，余沉弱；舌略红苔白薄。

脉理病理分析 左寸脉洪数，病位在心，洪脉在春为阳有余，主热盛，为心火亢盛；余脉沉弱为不足，为阴虚。心火盛，肾水亏，心肾不交，心火盛故见心悸、烦热，火盛胃气不降故见干呕。肾水亏不能上济心火，则心烦失眠。

诊断 心悸（心火盛，肾水亏，心肾不交）。

治则 清心火，安心神，交通心肾。

方药 交泰丸加味。

黄连9克，肉桂3克，生地15克，丹参12克，当归10克，玉竹15克，枣柏仁各15克，云苓12克，远志10克，莲子心4克，朱砂1克，灯心为引。每日1剂，2次水煎，早晚分服。

治疗结果 服药3剂后左寸脉洪势大减，心悸烦热不再发，唯有干呕未尽，上方加太子参12克，继服数剂，痊愈。

3. 肾虚腰痛案

李××，男，40岁，工人。初诊于1995年12月8日，正值大雪节令。

正常脉象 冬令脉以沉滑为平。

病脉 两手寸关沉滑应时，唯两尺沉弱。

辨脉提要 两尺不应时为变脉，主病。两尺脉在脏主肾，在体主腰膝。经曰：“推而下之，上而不下者腰足清也。”沉弱脉冬时为阴虚精亏。

主诉及简要病史 腰痛，腰膝酸软2年余，近1年来加重，伴见两目发花，眼前似有蚊虫乱飞；纳可，二便正常。

查体 舌略红苔白薄，脉两尺沉弱，余沉滑。腰部叩击痛不明显，各种理化检查未有阳性发现。

脉理病理分析 冬令脉以沉滑为平，六脉中唯两尺沉弱不应时，两尺在脏主肾，在体主腰膝，冬令脉弱为阴虚精亏。肾主骨生髓，肾阴虚精亏，则髓少骨不坚故病腰痛、腰膝酸软。肝肾同源，精血互生，肾阴虚精亏日久，母病累子引起肝血不足，肝主目，肝血虚目失所养故昏花。

诊断 腰痛（肾虚精亏，肝血不足）。

治则 补肾壮腰，养血填精。

方药 左归饮加减。

熟地 18 克，山萸肉 15 克，生白药 15 克，枸杞 15 克，当归 10 克，制首乌 15 克，怀牛膝 12 克，川断 12 克，寄生 15 克，杜仲 12 克，金毛狗 15 克。每日 1 剂，水煎 2 次，早晚各 1 次服。

治疗结果 服上药 6 剂后证状减轻，因未能坚持治疗而未能痊愈。

4. 下肢浮肿案

魏××，男，53 岁，工人。初诊于 1996 年 3 月 20 日，正值春分。

正常脉象 弦而柔和。

病脉 初病脉短，后期两尺独大。

辨脉提要 ①春脉本弦今反短，短为气病中气不足；②尺部属阴，浮大脉为阳，尺见浮大脉是阳乘阴位，主下焦热盛。

主证及简要病史 双下肢浮肿 1 月余，晨起轻，午后重，伴见气短乏力畏寒。病起于外感之后（现外感已愈）纳一般，二便正常。有慢性乙肝病史。

查体 满月脸，肝掌，舌略红苔白稍厚，水滑；两关脉短，余弱；踝部按之没指。尿常规，肝、肾功能化验正常。

脉理病理分析 春脉弦长，今反短。经曰：短则气病，证见畏寒怕冷，两下肢浮肿为脾肾两虚，水失运化。肾主水，脾制水，脾虚水无以制则泛滥，肾虚水湿气化不利则为肿。

诊断 水肿（脾肾两虚，中气不足）。

治则 益气健脾，温阳利水。

方药 济生肾气汤加味。

黄芪20克，白术12克，薏苡仁30克，桂枝10克，制附片6克，川牛膝12克，泽泻12克，云苓12克，丹皮10克，山萸肉12克，生山药12克，熟地12克，车前子30克。开水煎服每日1剂，煎2次，早晚分服。

复诊 服上药3剂后水肿已消大半，6剂后午后微有胀感，9剂后未见痊愈，反见小便短赤，尿热等证。诊其脉，两尺洪大，余弱。

脉理病理分析 尺脉主下焦，尺属阴部，洪大脉为阳，尺见洪大是阳乘阴位为阳有余，主下焦热盛，故见尿赤，尿热。考虑连用桂附，久而增气，隧改弦易轍，以益气健脾，清利湿热，从温脾肾转为治肝脾，健脾化湿清热利湿。

方药

茵陈15克，苍白术各10克，白蔻仁6克，藿香10克，薏苡仁30克，车前子30克，丹参15克，大小

蓟各 15 克，虎杖 12 克，泽泻 12 克，茜草 12 克。水煎服，每日 1 剂，2 次水煎，早晚分服。

上方连服 9 剂，浮肿消退，二便正常，脉变为应时脉象。后以健脾强肾保肝成药调养，以资巩固。

5. 心悸失眠案

霍××，女，68 岁，退休工人。初诊于 1995 年 12 月 22 日，冬至前 1 天。

正常脉象 冬旺之脉，沉滑为平。

病脉 两手六脉浮数，按之无力。

辨脉提要 浮数脉为阳有余，主时为夏，冬见夏脉为阳有余阴不足。脉来按之无力为阴虚。

主诉及病史 二天前因生气感心慌，心悸，失眠，午后额部灼热。平时常有失眠，手足心热；纳可，二便正常。

查体 舌略红苔白薄，脉浮数按之无力。

脉理病理分析 冬令脉以沉滑为平，今脉不沉反浮数，按之无力。冬见夏脉为心病，浮数为阳有余，按之无力为阴不足。心火旺水必亏，肾旺时节当藏不藏，脉反浮数在外，为水亏火盛，肾水不能上济心火，心肾不交，故见心慌，心悸，午后额部升阳。病起于心情不畅，肝郁化火，心肝火旺扰动心神。

诊断 心悸，失眠（肝郁化火，心肾不交，水亏火旺）。

治则 清心安神交通心肾，佐以疏肝解郁。

黄连 6 克，肉桂 3 克，生地 15 克，元参 12 克，炒枣仁 15 克，夜交藤 15 克，珍珠母 15 克，远志 10 克，炒柴胡 6 克，杭芍 12 克，郁金 12 克，枳壳 10 克，青皮 6 克，炙草 10 克。每日 1 剂，2 次水煎，早晚分服。

治疗结果 2 剂而安，诸证消失。

6. 肝脾不和，肝郁化火案

高××，女，41 岁，干部。初诊于 1995 年 12 月 7 日，大雪前 1 天。

正常脉象 冬旺时脉以沉滑为平。

病脉 右脉浮弦有力，左脉细弦。

辨脉提要 冬见弦脉为肝病，两手脉中右脉大于左脉，浮弦有力为实。以脉辨证，知病邪来自肝，为阳邪，而表现在脾胃上。

主诉及简要病史 近 1 周来口苦，口涩，心急，食不知味，腹胀，纳呆，矢气多，大便干。病起于外孙烫伤，病情严重心中焦虑而发。

查体 舌红苔白厚，右脉浮弦有力，左脉细弦。

脉理病理分析 冬令脉当沉滑为平，今脉不沉反

浮弦，为冬见春脉为肝病。然而右脉有力，左脉反细弦，古人多以左手脉主肝肾，右手脉主脾胃。（丹溪说，两手脉相似，右手弱者责之脾虚。《素问·病能篇》曰，……左脉浮而涩，此逆四时，在左当主病在肾，颇关在肺……。）右脉浮弦有力为肝气实，左手脉细弦为肝阴虚。肝强脾必弱，从肝的有余脉出现在脾胃部故知此病为肝郁化火克脾犯胃。从病因病机上推求，病发于心情焦虑之后也证实了这一点，肝郁化火和脾失健运同见于一时，故见口苦，口涩，心急，食不知味，纳差，腹胀，矢气多等证。

辨证 肝脾不和（肝郁化火，克脾犯胃）。

治则 疏肝解郁，健脾清热。

方药 丹栀逍遥散加味。

炒柴胡 10 克，郁金 12 克，杭芍 15 克，枳壳 12 克，香附 12 克，青皮 10 克，黄芩 10 克，丹皮 10 克，炒栀子 10 克，茯苓 12 克，白术 10 克，炒三仙各 10 克。每日 1 剂，2 次水煎，早晚分服。

治疗结果 3 剂而安。

7. 眩晕、中风先兆案

梅××，女，68 岁，退休工人。初诊于 1995 年 11 月 25 日，小雪后第 2 天。

正常脉象 沉滑。

病脉 沉细弦。

辨脉提要 冬旺之时脉见沉滑为平，今沉中兼见细弦为冬见春脉为肝病。细为阴不足。弦为阳有余。

主诉及简要病史 近1周来头目晕眩，两足萎软无力不能站立，伴见心慌、失眠、口干、口苦。有高血压病史十余年，1993年曾患脑梗，经治疗后恢复，半月前发生一次小中风，当时口眼歪斜、失语、半身不随，一天内恢复正常未留残疾。现纳可，二便正常。自述有家族高血压病史。

查体 血压30.7/16.0kPa，四肢活动基本正常，各种生理反射存在，病理反射未引出。舌略红，苔白中心稍厚，脉沉细弦。

脉理病理分析 冬旺之时脉当沉滑为平，今沉中兼见细弦，弦为肝脉，为阳亢，细者阴不足。经曰：诸风掉弦皆属于肝，今证见头晕目眩，不能站立是肝风欲动之兆，脉证合参为阴虚阳亢，肝风欲动。阴虚水不涵木故见心慌、口干、口苦等证。

诊断 中风先兆。（肝肾阴虚、肝阳上亢、肝风欲动）

治则 平肝潜阳，养阴熄风。

方药 羚羊钩藤汤加减化裁。

羚羊角 1.5 克，钩藤 15 克，天麻 15 克，石决明 30 克，川牛膝 15 克，胆南星 6 克，杭芍 20 克，桑枝 30 克，云苓 12 克，橘红 6 克，女贞子 20 克，枣柏仁各 15 克，生龙牡各 20 克。每日 1 剂，2 次水煎，早晚分服。

复诊 服上药 3 剂后头晕好转，心已不慌，眠安，腿软减轻。查右脉沉，久按仍弦，左脉略大按之不实，舌略红苔白薄中心仍稍厚。

分析 从脉象上看弦象减轻是其肝阳上亢之势减缓，左脉略大按之不实仍为肝肾阴虚。上方已中的，效不更方当击鼓再进。上方加山萸肉 15 克，旱莲草 15 克，鸡血藤 20 克，继服 1 周诸证消失。嘱其常服杞菊地黄丸等，以资巩固。

8. 郁证、带下案

吉××，女，30 岁，干部。初诊于 1995 年元月 15 日，大寒前 6 天。

正常脉 沉滑；

病脉，左手脉弦，右手软弱无力。

辨脉提要 脉不应时为变脉，主病。变脉涉及两脏同病时，当按五行生克辨证施治。两手脉不一，右手脉软弱无力主脾胃，左手脉弦为肝脉。

主诉和简要病史 生气之后，肝区胀痛两月余，近十余日加重，现感身困乏力、口淡、纳食无味、腰酸、小腹下坠，白带量多色黄，月经正常，二便正常。

查体 面色淡黄，舌淡红、苔白稍厚，左手脉弦较有力，右手脉软弱无力。

脉理病理分析 三九时节肾气旺，脉当沉滑为平，今左脉不沉反弦，是冬见春脉为肝病，右脉软弱无力为长夏脉，冬见长夏脉为脾病。脉在肝，有力为实，脉在脾，无力为虚。两脉合看为木克土。

病起于情志不畅，肝气郁结故见肝区胀痛。肝强脾必弱，脾虚失运故见身困乏力，口淡无味，纳差。脾虚则湿胜，积湿下流则白带量多，湿郁久生热则带下色黄，带下日久必损及肾，肾气伤冲任不固则腰酸，小腹下坠。脉证合参为郁证，带下。

诊断 郁证，带下（肝木克脾土，肾气伤）

治则 疏肝健脾，清热利湿佐以固肾。

方药 逍遥散加减化裁。

炒柴胡 10 克，香附 15 克，苍白术 10 克，青皮 10 克，杭芍 12 克，薏苡仁 30 克，黄柏 10 克，胆草 6 克，川牛膝 12 克，川断 15 克，云苓 15 克，山萸肉 12 克，白果肉 15 克。每日 1 剂，2 次水煎，早晚分服。

治疗结果 3 剂见轻，6 剂大效，9 剂痊愈。

9. 脾虚胃失和降案

白××，女，16岁，学生。初诊于1995年2月25日，谷雨 after 第4天。

正常脉象 弦而柔和。

病脉 弦而软弱。

辨脉提要 ①初诊：弦而软弱为春兼长夏脉，非其时而有其脉，主病；

②复诊：弦而洪滑为春兼夏脉，为心病，但有心脉而无心证，非为心病，此案为药力所致。

主诉及简要病史 腹胀、纳差、纳后腹胀加重，大便不畅半年有余，曾服多种药物疗效不佳。

查体 面色淡黄，腹肌薄弱。六脉弦中兼见软弱无力不胜重按，舌淡红苔白稍厚。

脉理病理分析 春季肝旺，脉当弦而柔和为平，今诊其脉弦而软弱不胜重按，是春兼长夏之脉，非其时而有其脉，主病。软弱无力脉在脏为脾，病性为虚。脾虚运化无力则证见腹胀纳差，纳后腹胀加重，脾虚五脏气争九窍不通故大便不畅。

诊断 脾虚，胃失和降。

治则 益气健脾，通降和胃。

方药 补中益气汤合香砂六君子汤加减。

黄芪 20 克，党参 15 克，白术 12 克，云苓 12 克，枳壳 10 克，木香 10 克，砂仁 8 克，升麻 6 克，柴胡 4 克，莱菔子 10 克，酒军 5 克，谷麦芽 15 克，炙草 10 克。每日一剂，水煎 2 次，早晚分服。

复诊 服上药 7 剂后自觉腹胀减轻，纳食较佳，但大便仍有不爽。

脉诊 弦中兼有洪滑而数，久按仍无力。

脉理病理分析 弦为应时脉，洪滑而数为夏心脉，从脉上分析，为春兼夏脉，此未至而至，为脉不应时。洪滑而数为心脉，主病为阳盛，虽有心火盛之脉却无心火旺之证，脉与证不合。推求机理，此乃虚损之证连用参芪术草之类温阳补气药，机体受补，气偏旺而阴不配，故出现弦中兼有洪滑而数之象，此药力所致，非为病已转热、转实，故其脉久按仍乏力。治疗上不可改弦易辙反清其热，误伤阳气，应在前药基础上稍佐益阴之味以平衡阴阳。

前方去莱菔子，加沙参 15 克，杭芍 12 克，生山药 15 克。

治疗结果 经上方调治 2 月余，后改为丸剂共治疗半年余，纳佳，食欲旺盛，体重增加，面色红润，腹已不胀，大便正常，脉已为应时脉象。

10. 咳嗽，寒郁化热案

刘××，男，24岁，职员。初诊于1995年，元月1日，冬至后10天。

正常脉象 沉滑。

病脉 浮涩而短。

辨脉提要 见此脏脉，有此脏证方为此脏病。

主诉及简要病史 咳嗽20余天，其声深沉，无痰，伴见低热午后恶寒。病起于1月前在山区学汽车驾驶，感受风寒。现纳可，二便正常。

查体 舌略红，苔白薄，脉浮涩而短。

脉理病理分析 冬脉应以沉滑为平，今见浮涩而短，为冬见秋脉为肺病。脉浮为风邪在表，为阴虚，脉短为气病，涩为津伤。从病因推求，其受风寒于前，化热伤阴在后，风寒伤肺，肺失肃降，寒邪郁久化热。从症状上看，午后恶寒为表邪未解，咳声深沉无痰为热伤肺津燥痰难出，故咳不止。脉证合参为风寒伤肺，郁久化热伤阴。

诊断 咳嗽（风寒化热损伤肺阴）。

治则 先以宣散郁寒佐以清肺化痰。

方药

荆芥10克，防风10克，紫菀12克，款冬花12克，杏仁10克，黄芩8克，前胡10克，川贝10克，瓜蒌

15 克，射干 10 克，炙兜苓 5 克，甘草 3 克。水煎 2 次，早晚分服。

复诊 服药 2 剂后恶寒减轻，体温由 37.5℃ 上升到 38.5℃～39℃。证见发热汗出，口干多饮咳声由深沉转宏亮，仍少痰，舌边尖红，苔白薄，中央略干，脉由浮涩而短变为浮大而数。

脉理病理分析 脉浮为邪在表，数为热。内伏寒邪已出，证已由寒化热，邪在肺卫、气分，故见身热，口干，多饮。

诊断 风寒化热，邪在肺卫、气分。

治则 清肺化痰止咳，佐以养阴。

方药

薄荷 10 克，荆芥 6 克，杏仁 10 克，桔梗 10 克，沙参 15 克，川贝 12 克，茯苓 8 克，瓜蒌 15 克，元参 12 克，鱼腥草 30 克，知母 10 克，杷叶 15 克，甘草 6 克。并配合梨糖水内服。

治疗结果 3 日后热退身凉，咳嗽由深变浅，由无痰渐到有少量白痰，1 周后痊愈。脉由初诊时的浮涩而短，先变为浮大而数，随热退咳嗽好转，渐转为应时的沉滑脉象。

11. 眩晕、气阴两虚案

蒋某，男，50岁。初诊于1995年5月2日，春末。

正常脉象 弦而兼洪。

病脉 两寸脉弱，左寸尤甚，余浮软无力。

辨脉提要 既有整体的不应时，又存在部位上的两寸独弱，左寸尤甚，应把两者结合起来考虑。

主诉与简要病史 今天下午下班回家，上5楼后突然头昏，口舌、四肢麻木，乏力。伴见心慌气短，汗出，微恶寒。平时工作劳累，长期失眠，纳少，二便正常。

查体 舌体瘦，质略红，苔白薄。脉浮软无力，两寸弱，左寸尤甚。血压14.0/8.0kPa。

脉理病理分析 春末脉当弦中兼洪为平，今见浮软无力是春末见长夏脉为脾病，但未见脾证知非为脾病，按28脉主病求之。浮软弱无力为气血两虚，两寸脉主心肺，以心肺气虚尤甚。本为气血两虚体质，又于劳累之后，烦劳伤气，气虚加剧，血不能上达于头面及四肢，故见头目晕眩、口舌及四肢麻木。由于心肺气虚故见心悸、气短、自汗出、微恶寒。夜间属阴，阴虚不能潜阳，阳不能入阴，故见平日失眠。

诊断 眩晕（气血虚，心脑失养）。

治则 补气养血，安神。

生晒参 6 克，桂枝 6 克，黄芪 15 克，鸡血藤 20 克，丹参 15 克，当归 10 克，熟地 12 克，杭芍 12 克，元肉 15 克，炒枣仁 15 克，柏子仁 15 克，云苓 12 克，炙草 10 克。每日一剂，2 次水煎，早晚分服。

治疗结果 2 剂诸证消失，后以益气养阴安神之剂调治以资巩固疗效。

二、杂病脉案

12. 虚劳腰痛案

王××，女，38 岁，工人。初诊于 1995 年 11 月 21 日，小雪前 2 天。

正常脉象 沉滑。

病脉 沉弱短涩。

辨脉提要 脉不应时即为病脉，非五脏脉象，当按 28 脉主病求之。

主诉及简要病史 腰痛似拆，1 年有余，夜间腰痛不能入睡，自觉气短难以接续，动则气喘，每呼吸数次必深吸气方可。3 年前曾患白血病，经长期化疗，病情稳定。现纳一般，大便干，数日 1 次，小便正常，月经量少色淡，2 月 1 行。

查体 消瘦，面色黄白，贫血貌，舌瘦淡红，苔

白薄，六脉沉、弱、短，涩。

脉理病理分析 冬令脉以沉滑为平，今脉虽沉而毫无滑意，反见短、弱，而涩。短为气虚，弱涩者血脉亏虚，证见面色黄白，消瘦，气短难续，经少色淡，显为气血阴阳俱不足之证。气血大亏，经脉失养，脾肾两虚故腰痛似折。

诊断 虚劳（气血阴阳俱虚，脾肾两虚）。

治则 益气养血，健脾补肾。

方药 归脾汤加减化裁。

黄芪 15 克，生晒参 8 克，白术 10 克，云苓 12 克，当归 10 克，熟地 12 克，阿胶 8 克，枸杞 15 克，山萸肉 12 克，元肉 12 克，川断 15 克，怀牛膝 15 克，杜仲 12 克，陈皮 6 克，炙草 10 克。水煎 2 次，早晚分服。

治疗结果 服上药数剂后病情明显缓解，腰痛减轻，精神好转，气已不短，纳食转佳。后以上方去生晒参改洋参 5 克加减变化调理 2 月余，面色红润，体重增加精神大增，腰已不痛。

13. 便血、心悸案

张××，女，65 岁，退休工人。初诊于 1995 年 10 月 23 日，正值霜降。

正常脉象 短涩略沉。

病脉 浮大搏指，按之空虚。节律及脉力大小不等，为解索脉。

辨脉提要 浮大较有力，按之空虚为芤脉，为真虚假实脉；节律及脉幅大小不等完全没有规律为解索脉。解索为真脏脉，因其经治疗后仍可恢复，不可作为死脉。（失血之脉，初时并不一定见芤，过一、二日方见芤脉，随病情变化，失血多少可出现芤脉、革脉、细脉等，病愈康复时应转为应时脉。）

主诉及简要病史 半夜起床小便时突感心慌、胸闷，大汗淋漓，小便频数，伴见呕吐少量清水。贰周前大便下血，出血约1千毫升以上，住院治疗后血止。素有冠心病史，近几年每年都要发生房颤数次。现纳可，大便正常。

查体 形体较胖，面色黄白，脉浮大有力按之空虚，节律及大小不等。舌淡苔白。

脉理病理分析 脉来浮大似有力按之空软为芤脉，为真虚假实之脉。仲景云：芤者为减，大者为虚。失血之后血脉空虚，阳无所附，气脱于外，故见脉浮而大，证见大汗淋漓，小便频数。由于失血过多心失所养，脉见真脏如解索，此血损于内，气脱于外，有虚阳暴脱之虑。

诊断 失血后心气欲脱。

治则 当务之急必先固其气，气不固必亡阳，阳亡阴必脱。急以独参汤，红参 10 克浓煎灌服。十分钟
后汗止，心慌减，继以炙甘草汤加附片 10 克，云苓 12
克，浮小麦 30 克，龙牡各 30 克，山萸肉 20 克。每日
一剂水煎早晚分服。

复诊 上方 2 剂后心悸缓解，解索脉已除，脉力
减弱，有缓和之象，变为两关短而动兼有芤象；舌淡
苔白。

脉理病理分析 脉短而动者，短为气虚，元气大
亏；动为阴阳不和，失血之人血脉空虚，阴阳不和故
见短而动兼有芤象。虽见脉律已复，气脱已止，然元
气大虚，血脉空虚，阴阳不和在情理之中。继以归脾
汤加阿胶、熟地等调理半月余，气力大增，面色转润。

三诊 1995 年 12 月 12 日夜，外出看戏，劳累后
又感心慌、胸闷，自服丹参片、速效救心丸数粒后半
夜又解黑便如柏油状，伴见心慌、气短、汗出，小便
频数。

查体 面色黄白，脉浮大略数，按之空虚。

脉理病理分析 浮大略数按之空虚为芤脉，本为
气血亏虚尚未痊愈又因劳累而加剧；前有出血，病情
尚未稳固又用耗气动血之药，迫血再出。

诊断 便血。

治则 益气养血止血。

方药

洋参 6 克，阿胶 10 克，生地炭 12 克，地榆炭 15 克，仙鹤草 15 克，白芨 15 克，乌贼骨 12 克，姜炭 5 克，三七粉 3 克，阿胶 6 克，熟地 12 克。水煎 2 次早晚分服。

治疗结果 1 剂血止，精神转佳，3 剂后便血痊愈，但脉弦而芤，右大于左。仲景说，弦大而芤其名为革，男子失精，女子失血，其表有寒内有亡精失血，正合病机。后以养血益气药调理近 2 月，体力恢复面色红润，脉由初时的浮大而芤，先变为细小而沉，后变为应时的沉滑脉。

14. 食阻气机昏迷案

杨××，女，90 岁。初诊于 1996 年 3 月 10 日，惊蛰后第 4 天。

正常脉象 沉弦。

病脉 沉滑而结。

辨脉提要 结脉属阴，阴邪凝积，气机阻滞血脉不畅，脉见结。浮滑为阳，沉滑属阴，沉滑而结，为阴邪凝聚之象。

主诉及简要病史 神志不清，昏睡，纳呆 5 天，伴有呓语，轻咳。患者平时健康，耳目尚聪，食量较好，每天吃 4~5 顿饭，近几天突然不食，大便二日未解。前医疑为脑血栓，重度肺炎曾连用先锋五号 10 支，氨基酸，维脑路通等数天不见好转。

查体 虽神志不清但呼之能应，虽有咳嗽并无气喘痰鸣，虽几天不食而气色不衰，且两肺无明显罗音，神经系统检查未见异常。舌淡红，苔白稍厚，脉沉滑而结。

脉理病理分析 脉沉为在里，滑为阴邪凝聚。结脉有二、或为气、血、痰、食壅滞，脉来不畅或气血虚衰难以接续，虚实两端，唯脉来有力、无力可资鉴别。虚者必结而细弱，或细涩无力，绝不能兼滑。该患者脉来有力，结而兼滑，兼见气色不衰，故必为壅滞。气、血、痰、食中究为何者？结合患者平时食量较好，然九旬老人脾胃功能减弱，过量饭食必宿结于内，伤食者必厌食。脉证合参应为食结在内，三焦壅塞，气机阻滞，血脉不畅。

诊断 昏迷（食阻气机）。

治则 健脾，消积化滞。

党参 12 克，生山药 12 克，炒扁豆 10 克，莲子肉 10 克，枳实 4 克，炒曲 10 克，半夏曲 3 克，云苓 6 克，

谷麦芽 12 克，白术 6 克，炒莱菔子 6 克，黄芩 6 克，砂仁 5 克，炙草 6 克。

治疗结果 服上药 1 剂，神志清醒，不再昏睡，（病中之事患者一无所知）2 剂纳增，大便正常，痊愈。

15. 牛皮癣性红斑病（血风疮）案

季××，女，21 岁，干部。初诊于 1995 年 2 月 1 日，立春前 5 天。

正常脉象 沉滑略弦；

病脉 细弦。

辨脉提要 冬末脉当沉滑略弦为平，今脉细弦，为变脉，主病。细为阴不足，弦为阳有余。

几诊之后，脉随病转，出现了弱脉，又出现了细缓脉，同时表现出脾湿不运，脾胃虚弱的证状。治疗上除始终坚持驱风通络，解毒凉血的大方向不变外，根据脉的变化兼顾脾胃。

主诉及简要病史 全身起大小不等红斑 2 月余，除手足掌及面部外遍及全身，剧烈搔痒，夜间不能入睡。病起于外感发热之后，初起皮疹如针尖大，色赤，分布于身体上半身，胸、背、腹部，逐渐扩大成斑片，遍及全身。曾在几家大医院求治，均诊为牛皮癣性红斑病，中西药内服、外涂均不见效，痛苦非常。现纳

减，大便干燥，数日 1 次。

查体 皮疹融合成片遍布全身，尤以胸、腹、背部为重。皮损增厚，有鳞状脱屑，基底部色红。

脉理病理分析 冬未脉当沉滑略弦为平，今脉不沉而细弦，细为阴不足，弦在冬时为阳有余。参考临床证状，病起于发热之后，短时间内遍及全身，是风热毒邪为患，斑疹色赤为血分蕴热。

诊断 牛皮癣红斑病。中医辨证：风热毒邪蕴于血分，发于肌表，类于“血风疮”。

治则 凉血解毒，疏风活血通络。

方药

浮萍 15 克，生熟地各 30 克，丹皮 10 克，丹参 15 克，赤芍 15 克，白藓皮 30 克，茜草 15 克，紫草 15 克，槐花 15 克，地肤子 15 克，泽兰 15 克，桃仁 15 克，红花 10 克，丝瓜络 12 克。每日 1 剂，水煎 2 次分服。

上方略作变化连服 1 月后搔痒明显减轻，躯干部皮损开始大量脱屑、退皮，露出红色斑片。又服药一月余症状持续好转，四肢皮疹已大部消退，躯干部红斑颜色变浅。此时脉出现细而软弱脉，舌苔较厚，胃纳欠佳。考虑连用凉血阴柔重剂脾胃受损，上方减生熟地为 15 克，更加平胃散以顾护胃气。

连服至 6 月 5 日皮疹已基本痊愈，临床却出现了

恶心欲吐、纳少、口淡等脾湿不运的证状，脉也变成细缓。在坚持主攻方向不变继续凉血解毒，祛风通络的前提下，去生熟地、紫草、槐花等寒凉阴腻之味，加苦参、苍术、苡仁、土茯苓以化湿邪。

方药

苦参 15 克，苍术 10 克，地肤子 15 克，白藓皮 20 克，薏苡仁 20 克，浮萍 15 克，土茯苓 15 克，丹皮 10 克，赤芍 15 克，茜草 15 克，丹参 15 克，丝瓜络 12 克，乌蛇肉 15 克，蜂房 10 克。改为散剂，每次 9 克，1 日 2 次，早晚服用。

连用 2 月后，皮疹痊愈，皮肤光泽，纳正常，脉已变为应时脉象。

16. 黄疸、胰头癌后期案

薛××，女，62 岁，干部。初诊于 1994 年 11 月 4 日，立冬前数日。

正常脉象 短涩而沉。

病脉 六脉中唯右尺脉沉弦大而有力，余均沉伏细微。

辨脉提要 脉来沉、牢、弦、实主病症积；脉来沉伏细微亦主症积，前者为病始成，元气尚在，后者为病变后期，气血衰败。

主诉及简要病史 黄疸数月，经治疗效果不佳，B超提示为胰头癌，2周前行腹部手术探查，确诊为胰头癌转移，已失去手术机会。现卧床、少气、纳差口干、大便干结不通，肛门下血，痛苦非常。

查体 舌略红苔白，中心黄如沉香色。六脉中唯右尺沉弦大而有力，余均沉伏细微。

脉理病理分析 诸积大法云：脉来细软附骨者，积也。此案病致晚期，脉来沉伏细微，脉证相附。右尺主右肾及大肠，邪热炽盛，热结便闭故见右尺独弦大有力。

诊断 1. 肿瘤后期；
2. 阳明腑实，热结大肠。

治则 软坚散结，养阴通腑清热。

半枝莲 15 克，白花蛇草 20 克，丹参 15 克，龟甲 12 克，山甲 10 克，赤芍 12 克，生地 15 克，玉片 6 克，玄参 15 克，沙参 15 克，枳实 10 克，大黄（后下）10 克，洋参 6 克。1 剂水煎 2 次，早晚分服。

服上药后腑气已通，精神较前好转，病情暂时得缓。诊其脉右尺脉已缓和，其余仍沉伏细微。虽大便已通，热结已去，然沉伏脉仍在，病未除，半月后突然腹痛不食，未几而亡。

17. 真脏脉案

郝××，男，75岁，退休工人。诊于1982年5月6日。

病脉 两手寸关无脉，两尺脉极短，极浮浅，疾数，形如麻子，按之无脉。

辨脉提要 两手寸关无脉，尺脉极短、极浮浅疾数为麻促脉，为真脏脉。仲景曰：寸脉下不至关为阳绝；尺脉上不至关为阴绝。此为心的真脏脉为阴绝。

主诉及简要病史 近两月来，自觉心悸、气短难以接续，行动维艰，精神痿颓，近十天来纳差。大小便短少。

查体 舌嫩红少苔，脉麻促，（西医诊为病毒性心肌炎，自述年轻时曾患过梅毒。）

分析 此脉两尺独有，极浅，极短，疾数不可计数为真心脉。经曰：真心脉至如转豆燥疾。虽尺部有脉不能为有根脉，因胃气，神气已绝。断其短期内死，果不及1周而亡。

18. 脉不应病主死案

刘××，男，76岁，退休工人。诊于1979年5月5日。

正常脉象 弦洪。

辨脉提要 脉不应病，形病脉不病主死。

证状及脉象 形体极度衰竭，破腮脱肉，头倾视深，以手代足，以椎代首。近几天精神极度衰弱，纳食甚少。诊其两手脉尚均匀和缓，脉似无病。

分析 《内经·三部九候论》曰：“形肉已脱，九候虽调，犹死。”《诊宗三昧》曰：“……然，有变证多端而脉渐小弱，指下缓和似有可愈之机者，此元气与病气俱脱，反无病之象，乃脉不应病之候，非小则病退之比。”此病气与正气俱脱形体与脉不相应，脉虽似无病，不可作转愈，诊后3日亡。

19. 久病无脉主死案

陈××，男，74岁，1986年8月10日。

辨脉提要 久病两手无脉，主死。

证状及病史 肝癌后期已失去手术机会，以中药扶正软坚化瘀之剂，寄一线希望，已维持1月有余。今晨4时许突然神昏、谵语、躁动不宁。家属请求会诊，两手寸关尺、浮中沉均已无脉，太溪脉似有似无，趺阳脉极细极微，舌淡白。此为心阳暴脱（肝昏迷）。断其活不过今夜，勉为开方以希延缓时间，嘱家属准备后事，至中午时分，未及进药而亡。

三、附录

(一) 文中方剂索引

上 篇

1. 大补阴丸：《丹溪心法》

黄柏 知母 熟地 龟板

2. 六味地黄丸：《小儿药证直诀》

熟地 山萸肉 生山药 丹皮 泽泻 茯苓

3. 附子理中汤：《闫氏小儿方论》

附子 人参 白术 云苓 干姜 炙草

4. 桂附八味丸：《金匱要略》同金匱肾气丸

附子 肉桂 熟地 山萸肉 生山药 茯苓 丹
皮 泽泻

5. 补中益气汤：《脾胃论》

黄芪 党参 白术 当归 升麻 柴胡 橘皮
炙草

6. 黄芪建中汤：《金匱要略》

黄芪 桂枝 芍药 炙草 饴糖 生姜 大枣

7. 四物汤：《太平惠民和剂局方》

当归 川芎 熟地黄 白芍

8. 归脾汤：《济生方》

黄芪 党参 白术 当归 龙眼肉 枣仁 茯神
远志 木香 生姜 大枣 炙草

9. 地黄饮子：《宣明方论》

熟地 巴戟 山萸肉 石斛 肉苁蓉 附子 官
桂 五味子 白茯苓 麦冬 菖蒲 远志

10. 右归丸：《景岳全书》

大怀熟地 山药 山茱萸 枸杞 鹿角胶 菟丝
子 杜仲

11. 人参白虎汤：《伤寒论》

人参 生石膏 知母 粳米 炙草

12. 王孟英清暑益气汤：《温热经纬》

洋参 石斛 麦冬 黄连 竹叶 荷梗 知母
粳米 瓜翠 甘草

13. 白虎加苍术汤：《类证活人书》

生石膏 知母 苍术 粳米 炙甘草

14. 藿香正气散：《太平惠民和剂局方》

藿香 紫苏 白芷 半夏曲 厚朴 白术 云苓
大腹皮 桔梗 陈皮 甘草

15. 香薷饮：《太平惠民和剂局方》

香薷 银花 鲜扁豆花 厚朴 连翘

16. 东垣清暑益气汤：《脾胃论》

黄芪 党参 苍术 白术 当归 升麻 葛根
青皮 陈皮 麦冬 五味子 神曲 泽泻 炙草

17. 柴白汤：（即柴胡石膏汤）《医方集解》

柴胡 黄芩 人参 半夏 生石膏 知母 粳米
炙草

18. 达原饮：《温疫论》

玉片 厚朴 草果 知母 芍药 黄芩 甘草

19. 藿朴夏苓汤：《医原》

藿香 半夏 赤苓 杏仁 生薏仁 白蔻仁 猪
苓 淡豆鼓 泽泻 厚朴

20. 甘露消毒丹：《温热经纬》

飞滑石 茵陈 黄芩 石菖蒲 川贝母 木通
藿香 射干 连翘 薄荷 白蔻

21. 大柴胡汤：《伤寒论》

柴胡 黄芩 半夏 枳实 芍药 大黄

22. 枳实导滞丸：《内外伤辨感论》

大黄 枳实 神曲 茯苓 白术 黄芩 黄连
泽泻

23. 五汁饮：《温病条辨》

梨汁 荸荠汁 鲜苇根汁 麦冬汁 藕汁或蔗汁

24. 茵陈汤：《金匱要略》

茵陈 栀子 大黄

25. 茵陈术附汤：《医学心悟》

茵陈 白术 附子 干姜 甘草

26. 茵陈五苓散：《金匱要略》

茵陈 白术 云苓 桂枝 泽泻 猪苓

27. 人参养荣汤：《太平惠民和剂局方》

白芍 当归 陈皮 黄芪 桂心 人参 白术

炙草 熟地 五味子 茯苓 远志

28. 归脾汤：《济生方》

人参 白术 黄芪 茯苓 龙眼肉 酸枣仁 当

归 木香 远志 炙草

29. 犀角地黄汤：《急急千金方》

犀角（水牛角代） 生地 芍药 丹皮 元参

30. 大黄黄连泻心汤：《伤寒论》

大黄 黄连 黄芩 栀子

31. 小蓟饮子：《济生方》

生地 小蓟 木通 蒲黄 藕节 淡竹叶 栀子

甘草

32. 黄土汤：《金匱要略》

甘草 干地黄 白术 附子 阿胶 黄芩 灶心

黄土

33. 桃花汤：《金匱要略》

赤石脂 干姜 粳米

34. 理中汤：《金匱要略》

人参 白术 茯苓 干姜 炙草

35. 芍药汤：《保命集》

芍药 当归 黄连 玉片 木香 甘草 大黄

黄芩 官桂

36. 葛根芩连汤：《伤寒论》

葛根 炙甘草 黄芩 黄连

37. 保和汤：《丹溪心法》

神曲 山楂 茯苓 半夏 莱菔子 陈皮 连翘

38. 痛泻要方：《刘草窗方》

防风 白术 陈皮 白芍

39. 逍遥散：《太平惠民和剂局方》

柴胡 当归 芍药 白术 茯苓 炙草 薄荷

生姜

40. 玉女煎：《景岳全书》

生石膏 知母 麦冬 熟地 牛膝

41. 甘草干姜汤：《金匱要略》

炙甘草 干姜

42. 五苓散：《伤寒论》

桂枝 白术 茯苓 泽泻 猪苓

43. 香砂六君子汤：《医方集解》

人参 白术 茯苓 炙草 木香 砂仁

44. 乌头汤：《金匱要略》

川乌 麻黄 芍药 黄芪 甘草 蜜

45. 薏苡仁汤：《类证治裁》

薏苡仁 瓜蒌仁 丹皮 桃仁

46. 防风汤：《宣明方论》

防风 当归 赤苓 杏仁 黄芩 秦艽 葛根

麻黄 甘草

47. 白虎加桂枝汤：《金匱要略》

生石膏 知母 桂枝 粳米 甘草

48. 桂芍知母汤：《金匱要略》

桂枝 芍药 知母 麻黄 白术 防风 附子

甘草 生姜

49. 独活寄生汤：《备急千金要方》

独活 寄生 杜仲 细辛 桂枝 防风 牛膝

党参 白术 茯苓 当归 熟地 芍药 川芎

50. 瓜蒌薤白白酒汤：《金匱要略》

瓜蒌 薤白 白酒

51. 乌头赤石脂丸：《金匱要略》

乌头 附子 蜀椒 干姜 赤石脂

52. 生脉散：《千金方》

人参 麦冬 五味子

53. 炙甘草汤：《伤寒论》

炙草 桂枝 生地 阿胶 胡麻仁 麦冬 人参
大枣 生姜 加少量酒。

54. 丹参饮：《时方歌括》

丹参 檀香 砂仁

55. 大承气汤：《伤寒论》

大黄 枳实 厚朴 芒硝

56. 参苓白术散：《太平惠民和剂局方》

莲子肉 薏苡仁 砂仁 桔梗 白扁豆 茯苓
人参 白术 山药 甘草

57. 八正散：《太平惠民和剂局方》

车前子 瞿麦 扁蓄 滑石 山梔仁 木通
大黄 甘草

58. 小蓟饮子：《济生方》

当归 梔子 炙甘草 生地 小蓟 滑石 木通
蒲黄 藕节 淡竹叶

59. 知柏地黄丸：《医宗金鉴》

生地 山萸肉 生山药 丹皮 泽泻 茯苓
盐知母 盐黄柏

60. 大乌头煎：《金匮要略》

乌头五枚 蜜二升

61. 羚羊钩藤汤：《通俗伤寒论》

羚羊角 桑叶 川贝 鲜生地 双钩 滁菊花
生白芍 淡竹茹 生草

62. 镇肝熄风汤：《衷中参西录》

怀牛膝 生赭石 生龙骨 生牡蛎 生龟板 生
白芍 玄参 天冬 川楝子 生麦芽 茵陈 甘草

63. 补阳还五汤：《医林改错》

黄芪 归尾 赤芍 地龙 川芎 桃仁 红花

下 篇

64. 清胃散：《兰室秘藏》

生地 当归身 丹皮 黄连 升麻

65. 凉膈散《太平惠民和剂局方》

川大黄 朴硝 甘草 栀子仁 薄荷 黄芩
连翘

66. 黄连解毒汤：《外台秘要》

黄连 黄芩 黄柏 栀子

67. 龙胆泻肝汤：《医方集解》

龙胆草 黄芩 栀子 生地 木通 泽泻 车前
子 当归 柴胡 生甘草

68. 导赤散：《小儿药证直诀》

生地 木通 竹叶 甘草梢

69. 一贯煎：《柳州医话》

北沙参 麦冬 当归 生地 枸杞 川楝子

70. 天王补心丹：《摄生秘剖》

生地 人参 丹参 元参 茯苓 五味子 远志
桔梗 当归 麦冬 天冬 枣仁 柏子仁 朱砂

71. 麻杏石甘汤：《伤寒论》

麻黄 杏仁 生石膏 甘草

（二）主要参考书目

《黄帝内经素问》 唐·王冰注

《黄帝内经素问直解》 清·高士宗

《灵枢经》

《难经会通》 近代·黄竹斋

《注解伤寒论》 汉·张仲景著，
宋·成无己注解。

《金匱要略》 汉·张仲景

《甲乙经》 晋·皇甫谧

《脉经》 晋·王叔和

《千金方》 唐·孙思邈

《类经》 明·张介宾

《脾胃论》 元·李 杲

《内外伤辨感论》 元·李 杲

《东垣十书》 元·李 杲

《丹溪手镜》
《丹溪心法》
《诊家枢要》
《诊家正眼》
《医宗必读》
《医学入门》
《频湖脉学》
《诊宗三昧》
《脉诀汇辨》
《脉理求真》
《脉 确》
《医部全录》
《脉理阐微》
《中医脉诊学》
《全息诊断学》
《中医内科学》

元·朱震享
元·朱震享
元·滑伯仁
明·李中梓
明·李中梓
明·李 梴
明·李时珍
清·张 璐
清·李延昱
清·黄宫绣
清·黄 琳
清·陈梦雷
清·陈公远
 赵思俭
 郑卫东
上海中医学院

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=脉法求真

作者=

页数= 1 9 5

S S 号=

出版日期=

自序	
凡例	
上篇脉学的一般理论及诊脉方法	
一、脉搏形成的机理	
二、影响脉搏的因素	
(一) 非疾病因素	
(二) 疾病因素	
三、诊脉时间	
四、诊脉部位	
五、论“寸口脉诊病分三关候五脏”的科学性	
六、人迎脉、气口脉正误	
七、持脉方法	
八、病位应从变中求	
九、正常人脉象	
十、真脏脉	
十一、诊脉辨证	
(一) “独”字求病位	
(二) 阴阳求病性	
(三) 比较求病势	
十二、脉象反映病理变化	
十三、寸口脉主病脉辨	
(一) 外感病脉辨	
(二) 五脏病脉辨	
(三) 杂病脉辨	
1. 虚劳病脉辨	
2. 暑病脉辨	
3. 虐病脉辨	
4. 黄疸病脉辨	
5. 失血病脉辨	
6. 泻、痢病脉辨	
7. 消渴病脉辨	
8. 痹病脉辨	
9. 胸痹病脉辨	
10. 宿食病脉辨	
11. 淋病脉辨	
12. 寒疝病脉辨	
13. 症瘕积聚病脉辨	
14. 中风病脉辨	
十四、寸关尺三部脉独见主病（十种脉象主病表解）	
上篇注释	
中 篇二十八脉辨析及主病	
一、对看法（28脉主病脉辨）	
(一) 以脉在部位的深浅来分	
1. 浮脉	
2. 沉脉	
3. 伏脉	
(二) 以脉来至数上分	

- 4. 迟脉
- 5. 数脉
- 6. 缓脉
- 7. 疾脉
- (三) 以脉来搏动有力无力来分
- 8. 虚脉
- 9. 实脉
- 10. 牢脉
- (四) 以脉来流利与否分
- 11. 滑脉
- 12. 涩脉
- (五) 以脉体长短区分
- 13. 长脉
- 14. 短脉
- 15. 动脉
- (六) 以脉体宽度区分
- 16. 洪脉
- 17. 细脉
- (七) 弦直脉，从搏动力度和幅度上分
- 18. 弦脉
- 19. 紧脉
- (八) 空虚脉分
- 20. 芤脉
- 21. 革脉
- (九) 虚脉中以脉体宽度区分
- 22. 微脉
- 23. 散脉
- (十) 细软脉从浮沉上分
- 24. 濡脉
- 25. 弱脉
- (十一) 竭止脉以迟数分
- 26. 促脉
- 27. 结脉
- 28. 代脉

二、类比法

三、单脉、复合脉、兼脉的意义

四、辨脉提纲

五、脉有常、变，证有真、假，法有取、舍

六、脉有初按、久按，浮取、沉取不同

七、脉逆从阴阳

八、以脉、色断病新久及预后

中篇注释

下篇四时五脏脉法及其应用

总论

一、四时五脏常脉

(一) 四时五脏平脉

四时五脏平脉表解

(二) 四时五脏病脉

四时五脏病脉表解

二、四时五脏变脉

- (一) 变脉有单、兼不同
- (二) 变脉主病与发病早晚
- 五脏变脉主病表解
- (三) 变脉主病分类及治法
- 当季脏腑变脉主病表解

三、四季脉解，阴阳盛衰论

四、六气变化对脉的影响

 六经变脉表解

 按语：六经脉解

五、四时五脏脉与寸关尺相结合

六、脉象与体质及用药的关系

下篇注释

 附：《内经》遍身诊脉法

一、三部九候诊脉法

二、人迎、气口诊脉法

三、诊尺肤法

脉案

一、五脏病脉案

二、杂病脉案

三、附录

 (一) 文中方剂索引

 (二) 主要参考书目